

FORMAÇÃO INTEGRAL EM SAÚDE

Prof.^a Rafaela Liberali

Prof.^a Simone A. P. Vieira





Copyright © UNIASSELVI 2016

Elaboração:

Prof.^a Rafaela Liberali

Prof.^a Simone A. P. Vieira

Revisão, Diagramação e Produção:

Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI

Ficha catalográfica elaborada na fonte pela Biblioteca Dante Alighieri
UNIASSELVI – Indaial.

614

L695f Liberali; Rafaela

Formação integral em saúde/ Rafaela Liberali; Simone A. P.
Vieira : UNIASSELVI, 2016.

178 p. : il.

ISBN 978-85-515-0008-8

1.Saúde pública.

I. Centro Universitário Leonardo Da Vinci.

APRESENTAÇÃO

Prezado acadêmico(a)!

Bem-vindo(a) à disciplina de Formação Integral em Saúde. Esse é o nosso Caderno de Estudos, material elaborado com o objetivo de contribuir para a realização de seus estudos e para a ampliação de seus conhecimentos sobre os aspectos históricos e conceituais da saúde coletiva e das políticas de saúde no Brasil, especialmente do SUS, proporcionando reflexões sobre outras perspectivas no espaço educacional em geral.

Ao longo da leitura deste Caderno de Estudos, você irá adquirir conhecimentos fundamentais para o entendimento da saúde pública, bem como a concretização da assistência voltada as necessidades reais da população brasileira, aplicando esse conhecimento com maior inteligência, autonomia, responsabilidade e sensibilidade.

Neste Caderno de Estudos, você encontrará conteúdos que possibilitarão visualizar a trajetória histórica, conceitual e as ações da Saúde Coletiva; a educação em saúde; as bases legais, históricas, os avanços e desafios, modelo assistencial e planejamento de saúde no SUS, bem como todos os aspectos envolvidos na Estratégia da Saúde da Família. Ao propor uma formação integral em saúde, o profissional da saúde terá objetivos claramente definidos, amplos e consistentes nos domínios sobre as leis e fundamentação da saúde pública no Brasil, podendo atuar de forma que potencialize as competências para a integralidade dos direitos e deveres do cidadão.

Desejo a você um bom trabalho e que aproveite ao máximo o estudo dos temas abordados nesta disciplina.

Bons estudos e sucesso!

Professora Rafaela Liberali
Professora Simone A. P. Vieira



Você já me conhece das outras disciplinas? Não? É calouro? Enfim, tanto para você que está chegando agora à UNIASSELVI quanto para você que já é veterano, há novidades em nosso material.

Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos os acadêmicos desde 2005, é o material base da disciplina. A partir de 2017, nossos livros estão de visual novo, com um formato mais prático, que cabe na bolsa e facilita a leitura.

O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura interna foi aperfeiçoada com nova diagramação no texto, aproveitando ao máximo o espaço da página, o que também contribui para diminuir a extração de árvores para produção de folhas de papel, por exemplo.

Assim, a UNIASSELVI, preocupando-se com o impacto de nossas ações sobre o ambiente, apresenta também este livro no formato digital. Assim, você, acadêmico, tem a possibilidade de estudá-lo com versatilidade nas telas do celular, *tablet* ou computador.

Eu mesmo, UNI, ganhei um novo *layout*, você me verá frequentemente e surgirei para apresentar dicas de vídeos e outras fontes de conhecimento que complementam o assunto em questão.

Todos esses ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, para que você, nossa maior prioridade, possa continuar seus estudos com um material de qualidade.

Aproveito o momento para convidá-lo para um bate-papo sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.

Bons estudos!



BATE SOBRE O PAPO ENADE!



Olá, acadêmico!

Você já ouviu falar sobre o **ENADE**?

Se ainda não ouviu falar nada sobre o ENADE, agora você receberá algumas informações sobre o tema.

Ouviu falar? Ótimo, este informativo reforçará o que você já sabe e poderá lhe trazer novidades.



Vamos lá!

Qual é o significado da expressão ENADE?

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Em algum momento de sua vida acadêmica você precisará fazer a prova ENADE.



Que prova é essa?

É **obrigatória**, organizada pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Quem determina que esta prova é obrigatória... O **MEC – Ministério da Educação**.

O objetivo do MEC com esta prova é o de avaliar seu desempenho acadêmico assim como a qualidade do seu curso.



Fique atento! Quem não participa da prova fica impedido de se formar e não pode retirar o diploma de conclusão do curso até regularizar sua situação junto ao MEC.

Não se preocupe porque a partir de hoje nós estaremos auxiliando você nesta caminhada.

Você receberá outros informativos como este, complementando as orientações e esclarecendo suas dúvidas.



Você tem uma trilha de aprendizagem do ENADE, receberá e-mails, SMS, seu tutor e os profissionais do polo também estarão orientados.

Participará de webconferências entre outras tantas atividades para que esteja preparado para #mandar bem na prova ENADE.

Nós aqui no NEAD e também a equipe no polo estamos com você para vencermos este desafio.

Conte sempre com a gente, para juntos mandarmos bem no ENADE!



SUMÁRIO

UNIDADE 1 – AS BASES DA SAÚDE COLETIVA.....	1
TÓPICO 1 – A TRAJETÓRIA HISTÓRICA E CONCEITUAL DA SAÚDE COLETIVA	3
1 INTRODUÇÃO.....	3
2 SAÚDE COLETIVA – RECORTES HISTÓRICOS E SUAS DEFINIÇÕES.....	3
2.1 SAÚDE.....	4
2.2 SAÚDE PÚBLICA.....	4
2.3 SAÚDE COLETIVA	4
2.4 MOVIMENTO PREVENTISTA.....	8
2.5 MEDICINA SOCIAL	8
2.6 TRAJETÓRIA DA SAÚDE COLETIVA	10
2.7 REFORMA SANITÁRIA.....	12
2.8 TRANSDISCIPLINARIDADE NA SAÚDE COLETIVA	13
LEITURA COMPLEMENTAR.....	15
RESUMO DO TÓPICO 1.....	18
AUTOATIVIDADE	20
 TÓPICO 2 – AS AÇÕES DE SAÚDE, POLÍTICAS PÚBLICAS E EIXOS DE ATUAÇÃO DA SAÚDE.....	 23
1 INTRODUÇÃO.....	23
2 PRÁTICAS SOCIAIS DA SAÚDE (DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO).....	24
3 POLÍTICAS PÚBLICAS SAUDÁVEIS (PPS) E MOVIMENTO CIDADES SAUDÁVEIS	30
4 EIXOS DE ATUAÇÃO DA SAÚDE (INTERSETORIALIDADE E INTEGRALIDADE).....	32
RESUMO DO TÓPICO 2.....	37
AUTOATIVIDADE	39
 TÓPICO 3 – EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO VERBAL EM SAÚDE.....	 41
1 INTRODUÇÃO.....	41
2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE.....	41
3 COMUNICAÇÃO VERBAL EM SAÚDE (COM PACIENTES, INTEGRANTES DAS EQUIPES DE SAÚDE E COMUNIDADE)	46
RESUMO DO TÓPICO 3.....	48
AUTOATIVIDADE	50
 UNIDADE 2 – BASES LEGAIS E HISTÓRICAS DO SUS.....	 53
TÓPICO 1 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO SUS.....	55
1 INTRODUÇÃO.....	55
2 FORMULAÇÃO DO SUS (CRIAÇÃO DO SUS EM 1988 E A SAÚDE COMO DIREITOS DE TODOS E DEVER DO ESTADO)	55
2.1 ALGUNS FATOS MARCANTES DA TRAJETÓRIA DE SÉRGIO AROUCA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUS	56

2.2 CRIAÇÃO DO SUS E A 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE	58
2.3 IMPLANTAÇÃO DO SUS	60
3 SUS: CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	61
3.1 UNIVERSALIDADE	62
3.2 INTEGRALIDADE	63
3.3 EQUIDADE	63
3.4 REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO	64
3.5 RESOLUBILIDADE	65
3.6 DESCENTRALIZAÇÃO	65
3.7 PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS	66
4 PACTOS PELA SAÚDE	68
4.1 PACTO PELA VIDA (PV)	69
4.2 PACTO EM DEFESA DO SUS	69
4.3 PACTO DE GESTÃO (PG)	70
LEITURA COMPLEMENTAR	72
RESUMO DO TÓPICO 1	75
AUTOATIVIDADE	76
 TÓPICO 2 – MODELOS ASSISTENCIAIS, PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	 79
1 INTRODUÇÃO	79
2 MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (MODELO MÉDICO ASSISTENCIAL PRIVATISTA, MODELO SANITARISTA, MODELOS ALTERNATIVOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	79
3 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI)	83
4 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	85
RESUMO DO TÓPICO 2	88
AUTOATIVIDADE	89
 TÓPICO 3 – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	 91
1 INTRODUÇÃO	91
2 CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	91
3 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E TRABALHO EM EQUIPE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	94
4 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO NA SAÚDE (PNH)	98
5 ATENÇÃO, ASSISTÊNCIA E VISITA DOMICILIAR À SAÚDE	100
RESUMO DO TÓPICO 3	102
AUTOATIVIDADE	104
 UNIDADE 3 – PLANEJAMENTO, ÁREAS E REDES DE ATUAÇÃO DE SAÚDE NO SUS	 107
 TÓPICO 1 – ÁREAS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	 109
1 INTRODUÇÃO	109
2 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO JOVEM	109
3 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM	112
4 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO	113

5 ÁREAS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE MENTAL	116
6 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)	119
7 PROGRAMAS ESPECIAIS: DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, CIRURGIA BARIÁTRICA E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS/TRANSPLANTE.....	120
LEITURA COMPLEMENTAR.....	122
RESUMO DO TÓPICO 1.....	124
AUTOATIVIDADE	125
 TÓPICO 2 – PLANEJAMENTO DE SAÚDE NO SUS	127
1 INTRODUÇÃO.....	127
2 DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE, SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS – PLANEJASUS.....	127
3 SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS – PLANEJASUS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO DO SUS.....	131
4 PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (PPI)	134
5 FINANCIAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE.....	139
6 CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS).....	141
RESUMO DO TÓPICO 2.....	144
AUTOATIVIDADE	146
 TÓPICO 3 – PRINCIPAIS INDICADORES DA SITUAÇÃO DE SAÚDE	149
1 INTRODUÇÃO.....	149
2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.....	149
2.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS (SINASC)	150
2.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM).....	151
2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SIA/SUS)	152
2.4 SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES (SIH/SUS).....	153
2.5 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (SIAB)	154
2.6 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN)	155
2.7 SISTEMA DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA).....	156
RESUMO DO TÓPICO 3.....	158
AUTOATIVIDADE	159
 REFERÊNCIAS	161

AS BASES DA SAÚDE COLETIVA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade você será capaz de:

- diferenciar os conceitos de saúde, Saúde Pública e Saúde Coletiva;
- entender como foi a trajetória de acontecimento para a formação da Saúde Coletiva;
- identificar em uma linha do tempo o que ocorreu em cada ano até a criação do SUS;
- ter conhecimento de movimentos como o Preventivista, Medicina Social e Saúde Coletiva;
- entender os paradigmas conceituais envolvidos na trajetória da Saúde Coletiva;
- entender como ocorreu a Reforma Sanitária Brasileira;
- compreender as ações e as práticas sociais da saúde;
- diferenciar promoção, proteção, recuperação, reabilitação da saúde;
- entender os eixos de atuação da promoção da saúde;
- compreender o processo saúde/doença como um objeto complexo;
- entender a importância da educação e comunicação em saúde.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em três tópicos. Em cada um deles, você encontrará atividades que o(a) ajudarão a fixar os conhecimentos abordados.

TÓPICO 1 – A TRAJETÓRIA HISTÓRICA E CONCEITUAL DA SAÚDE COLETIVA

TÓPICO 2 – AS AÇÕES DE SAÚDE, POLÍTICAS PÚBLICAS E EIXOS DE ATUAÇÃO DA SAÚDE

TÓPICO 3 – EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO VERBAL EM SAÚDE

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA E CONCEITUAL DA SAÚDE COLETIVA

1 INTRODUÇÃO

A história da saúde mundial teve sua evolução marcada por inúmeras transformações conceituais, políticas, sociais, econômicas e culturais. No Brasil não foi diferente, várias lutas foram traçadas por movimentos idealistas até iniciar a construção da saúde coletiva, fruto da necessidade de uma remodelagem dos conhecimentos e práticas que integram o valor fundamental da condição humana estabelecendo a saúde como direito universal.

Neste tópico, você verá a evolução histórica e alguns conceitos, bem como as características que nortearam e contribuíram para a organização e mudanças da saúde pública em nosso país, que culminaram na sistematização da saúde coletiva.

Este tópico abordará a saúde coletiva, seus recortes históricos e definições, dividindo-se em alguns subtítulos. Os três primeiros subtítulos apresentam definições e diferenças entre os termos: saúde, saúde pública e saúde coletiva. No quarto e quinto subtítulo serão discutidos dois momentos históricos, movimento preventista e medicina social, que são modelos históricos da saúde no Brasil. No sexto subtítulo, veremos a trajetória da construção da Saúde Coletiva embasada pelo sétimo subtítulo que descreve alguns dos princípios de toda a Reforma Sanitária. E por fim, no último subtítulo discutiremos sobre a transdisciplinaridade, como um campo particular de saberes que traz a integração das disciplinas na área da saúde coletiva.

2 SAÚDE COLETIVA – RECORTES HISTÓRICOS E SUAS DEFINIÇÕES

Ao iniciarmos nosso estudo, caro acadêmico, faz-se necessário uma breve retrospectiva nos históricos conceituais de Saúde e Saúde Pública, para entendermos o surgimento da Saúde Coletiva, que foi idealizada a partir de modificações pertinentes da Saúde Pública, e, neste sentido, cabe aqui constituirmos uma diferenciação conceitual básica desses três campos.

2.1 SAÚDE

Caro acadêmico, vamos entender alguns conceitos sobre a saúde, que vão desde a ausência de doença, harmonia com a realidade e até desenvolvimento humano. Para o Who (2006, p. 1) “Saúde é uma disposição de completo bem-estar físico, mental e social, com ausência total de qualquer doença”. Já para Segre e Ferraz (1997, p. 542) a “Saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e sua própria realidade”. E para Czeresnia e Freitas (2009, p. 20) a “Saúde é fator essencial para o desenvolvimento humano”.

Você observou acima, caro acadêmico, que os conceitos se diferenciam de acordo com a realidade em que está inserida. Portanto, vamos conhecer o conceito de saúde proposto pelo Art.196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 que diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL, 2012, p. 116).

2.2 SAÚDE PÚBLICA

De acordo com Winslow (1920, p. 23) definir Saúde Pública é

Uma ciência e uma arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física, mental e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio ambiente, controle das infecções na comunidade, a organização dos serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças.

Com o passar do tempo, ocorre a atualização do conceito de saúde pública. Terris (1992) apud Paim e Almeida Filho (1998, p. 301) propõe uma nova definição para a Saúde Pública como “a arte e a ciência de prevenir a doença e a incapacidade, prolongar a vida e promover a saúde física e mental mediante os esforços organizados da comunidade”. “Saúde Pública” é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, é o que relata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Art. 2. A Organização Mundial de Saúde reconhece como conceito de “Saúde Pública” “a ciência e a arte de promover, proteger e recuperar a saúde, por meio de medidas de alcance coletivo e de motivação da população” (WHO, 1991, p. 32).

2.3 SAÚDE COLETIVA

Ao resgatar o histórico do conceito de Saúde Coletiva, Lima e Santana (2007, p. 2521) relatam: “Saúde Coletiva é, simultaneamente, um campo científico e um âmbito de práticas, contribuindo com a Reforma Sanitária Brasileira mediante produção de conhecimentos e sua socialização junto aos movimentos sociais”.

Veja a seguir, dois conceitos sobre saúde coletiva: “A Saúde Coletiva pode ser considerada como um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, o planejamento/administração de saúde e as ciências sociais em saúde”. (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000, p. 63). E “A Saúde Coletiva deve ser entendida como conjunto de saberes que subsidia práticas sociais de distintas categorias profissionais e atores sociais de enfrentamento da problemática saúde-doença-cuidado”. (DONNANGELO; PEREIRA, 1976, p. 87).

Agora, acadêmico, após identificarmos os conceitos básicos de saúde, saúde pública e coletiva, o quadro a seguir nos norteará quanto às diferenças existente entre elas, e assim entender que a saúde pública é voltada principalmente para a promoção da qualidade de vida e saúde da população e, que a saúde coletiva como uma disciplina incorporada nas escolas médicas, propõe novos conteúdos que influenciaram a reforma sanitária no Brasil.

QUADRO 1 - DIFERENÇAS SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE COLETIVA

SAÚDE PÚBLICA	SAÚDE COLETIVA
Estabelece o direito do cidadão em ter saúde; disponibiliza meios para a manutenção e sustentação da vida.	É um campo de produção do conhecimento que atua no processo saúde-doença da coletividade, vai além do diagnóstico e tratamento.
É de dever de o Estado assegurar serviços e políticas públicas para a promoção e bem-estar da população.	É planejada de acordo com as necessidades de cada região.
É mais ampla e está centralizada na figura do médico.	Atua na prevenção, é multidisciplinar, medicina social.
Surgiu para controlar doenças e como uma tentativa de erradicar a miséria, analfabetismo e desnutrição.	Atua em três dimensões: Planejamento de gestões política, epidemiologia social e ciências de forma global.
Há separação nas ações coletivas e individuais.	Foco na diversidade e especificidade dos grupos populacionais.
É assistencial, curativa.	É pautado no campo científico/acadêmico.
Tem como referência de saúde algumas instituições, como: Adolfo Lutz (Butantã) e Vital Brazil.	É um braço da Saúde Pública, foi criada por profissionais atuantes dentro da Saúde Pública, e que auxiliou na construção e concretização do Sistema Único de Saúde – SUS.

FONTE: Adaptado de (OSMO; SCHRAIBER, 2015; NUNES, 2000)

Caro acadêmico, com a leitura do quadro acima, você pode visualizar as diferenças existentes entre os termos saúde pública e coletiva e entendê-las melhor. Como não é objetivo deste tópico aprofundar estes conceitos, mas sim nos inteirarmos sobre os aspectos da Saúde Coletiva, iremos a partir de agora rever a trajetória histórica da Saúde Coletiva. A trajetória histórica da Saúde Coletiva Brasileira nos reporta para a segunda metade dos anos 50, numa conjuntura Pós-segunda Guerra Mundial, onde a situação econômica do país se esforçava para agregar potência no trabalho, melhorar a economia e no setor da saúde, programas de saneamento e seguridade social se solidificavam (NUNES, 1994).

Com uma sinalização tendenciosa a um olhar mais para a especificidade, a medicina realizou vasta exploração da terapia antibiótica direcionando para a clínica individualizada. No entanto, essa movimentação torna-se tangível somente nos anos 70, com a implementação de um projeto denominado “Preventista”, que se embasava num trabalho profilático da instalação de futuras doenças no âmbito social com uma visão sobre a coletividade com a prática de uma Medicina Social, e desenvolve robustez como Saúde Coletiva em 1980 (NUNES, 1994).

O surgimento da saúde coletiva passou por três momentos históricos: movimento preventivista (1950), medicina social (1970) e saúde coletiva (1980). E, para entendermos o primeiro momento, chamado de “movimento preventivista” é necessário que recordemos a trajetória das doenças até chegar à descoberta das vacinas e medicamentos. O quadro a seguir mostrará a história das vacinas e sua importância para o movimento preventivista.

QUADRO 2 - DATAS E FATOS QUE MARCARAM A TRAJETÓRIA DAS VACINAS

Ano	Fatos
1796	• Eduard Jenner descobre a vacina pela inoculação em um garoto saudável utilizando o pus de uma vaca infectada com varíola, “varíola de vaca”, latim: “ <i>varíola vaccinae</i> ”, que deu origem da vacina.
1804	• Inserção da vacina no Brasil.
1811	• Elaborada a Junta Vacínica da Corte.
1832	• Criada a legislação de obrigatoriedade da vacina no Brasil.
1834-1835	• Epidemia de varíola no Rio de Janeiro.
1885	• Louis Pasteur cria a primeira vacina contra a raiva, ele desvendou a função dos microrganismos na transmissão das infecções.
1887	• Inserção da vacina antivariólica animal no Brasil.
1889	• Obrigatoriedade da vacina para crianças de até seis meses de idade.
1902	• Oswaldo Cruz assume a Direção-geral do Instituto Soroterápico Federal.
1903	• Oswaldo Cruz é nomeado Diretor Geral de saúde pública, cargo que corresponde atualmente ao de Ministro da Saúde.
1904	• Epidemia de varíola assola a capital. Estoura a Revolta da Vacina. 31.10.1904 Lei da Vacina Obrigatória.
1907	• Febre amarela é erradicada no Rio de Janeiro.

1908	• Epidemia de varíola leva a população em massa aos postos de vacinação.
1921	• Regulamentação do Instituto Vacínico Federal.
1925	• Introduzida a BCG no Brasil.
1937	• Produção e utilização da vacina contra a febre amarela fabricada no Brasil.
1940	• Necessidade de combater o mosquito vetor, <i>aedes aegypti</i> , devido à baixa eficácia da vacina.
1942	• Erradicada a febre amarela urbana no Brasil.
1953	• Epidemias de difteria no Brasil.
1961	• Primeiras campanhas com a vacina oral contra a poliomielite.
1962-1966	• Instituída a Campanha Nacional contra a Varíola. Criada a Campanha de Erradicação da Varíola. Criada as vacinas para difteria, tétano e tosse convulsa.
1971	• Criado Plano Nacional de Controle da Poliomielite. Últimos casos de varíola no Brasil. Inicia a produção do BCG liofilizado pelo Butantã.
1974	• Criado o Programa Ampliado de Imunizações. Epidemia de meningite meningocócica no Brasil. Criada a vacina para o sarampo no Programa Nacional de Vacinação.
1975	• Sistema de registro de doses de vacinas aplicadas. Instituído o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Imunizações. Campanha Nacional de Vacinação contra a Meningite Meningocócica.
1982	• Fiocruz lança o primeiro lote da vacina brasileira contra o sarampo.
1984	• Iniciada em todo o país a vacinação de crianças de 0 a 4 anos de idade contra poliomielite, sarampo, difteria, coqueluche e tétano.
1986	• Criado o Zé Gotinha, personagem símbolo da campanha pela erradicação da poliomielite no Brasil.
1987	• Criada a vacina para rubéola e parotidite
1992	• Campanha Nacional contra o Sarampo. Implantada a vacina tríplice viral. Implantada a vacina anti-hepatite B para grupos de risco. Lançado o Plano de Eliminação do Tétano Neonatal.
1994	• Certificação internacional da erradicação da poliomielite no Brasil.
1997	• Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, em crianças menores de cinco anos.
1998	• Vacinação contra a hepatite B em todo o Brasil.
1999	• Plano de Erradicação do Sarampo. Primeiro ano da Campanha de Vacinação para a terceira idade, com a finalidade de imunizá-los contra gripe, tétano e difteria. Implantada a vacina contra <i>Haemophilus influenzae b</i> , para menores de 2 anos.
2002	• Implantada a vacina tetravalente (DTP + Hib), para menores de 1 ano. Campanha Nacional de Vacinação contra a Rubéola destinada a mulheres.
2006	• Incorporada a vacinação contra o rotavírus no Calendário Básico de Vacinação da Criança. Instituído o “Dia Nacional de Prevenção da Catapora”, celebrado anualmente no dia 5 de agosto, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra a doença.
2008	• Vacina contra o Vírus Papiloma Humana (HPV).

FONTE: Adaptado de **Revista da Vacina**. Centro Cultural do Ministério da Saúde Disponível em: <<http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/bibliografia.html>>. Acesso em: 23 maio 2016.

2.4 MOVIMENTO PREVENTISTA

Agora que leu sobre a trajetória histórica das doenças e a criação das vacinas, você conseguirá entender que a vacina tem como objetivo ser um instrumento de prevenção para a saúde, com controle e erradicação de algumas doenças, e fazendo com que a população se conscientize dos seus benefícios. O movimento preventivista surge com a pretensão de instaurar a compreensão sobre os cuidados com a higiene, os custos da atenção médica, já com o pensamento de dar responsabilidade ao Estado e reavaliar as práticas e educação médicas (AROUCA, 1975).

Inicia uma reestruturação pedagógica, uma modernização no curso de medicina, uma espécie de reforma universitária, incluindo novos conteúdos na grade curricular, incluindo algumas disciplinas que abordavam ações sobre prevenção, epidemiologia, administração em saúde e a readaptação de conduta do profissional de saúde para adequar-se as mudanças, como também a instauração de um campo de saberes e práticas que se integrasse com a sociedade, numa ótica mais ampla (NUNES, 1994).

Nos anos 70, com a mudança dos padrões de saúde do movimento preventivista, ocorre a superação da biologização, forçando os profissionais a estarem preparados para assistir a uma nova saúde pautada na prevenção da saúde da sociedade como um todo (CARVALHO, 2005). Quase no mesmo período de tempo, no Brasil, assim como o movimento Preventivista que dá origem à Medicina Preventivista, e acompanhando os movimentos internacionais, surge a idealização de uma Medicina Comunitária para assistir comunidades de baixa renda, populações menos favorecidas, como também a assistência ao público idoso, que por estar fora de mercado de trabalho ficava desprovido dos serviços de saúde. Com base nesta proposta, surgem então, os centros comunitários de saúde, com auxílio do governo federal e de algumas organizações, que prestavam assistência preventiva e cuidados elementares a comunidades de difícil acesso e carente (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998).

2.5 MEDICINA SOCIAL

Agora, caro acadêmico, seguindo o entendimento da trajetória histórica da Saúde Coletiva, nos deparamos como o surgimento da Medicina Social, ou ainda futuramente a própria Saúde Pública, princípios esses que geraram grande alvoroço na área da saúde, pois trouxeram em sua bagagem todas as lutas sociais de outrora (CASTRO; GERMANO, 2012).

Diante dessa conjunção, fez-se necessário discernir sobre a relevância dos aspectos sociais e obter entendimento das dificuldades da saúde, associado às questões da sociedade, sendo assim, a medicina social chega trazendo pontos de vista modernos, de acordo como também acontecia em outros países (CASTRO; GERMANO, 2012). Nesse contexto, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define que a Medicina Social deveria ser, “o campo de práticas

e conhecimentos relacionados com a saúde como sua preocupação principal e estudar a sociedade, analisar as formas correntes de interpretação dos problemas de saúde e da prática médica” (NUNES, 1994, p. 6).

O termo Medicina Social teve início por volta de 1848, onde a preocupação era com a análise dos problemas sociais associados à saúde, prevenção de doenças, politização da área médica e a interação de uma organização coletiva (DONNANGELO; PEREIRA, 1976).

Os idealizadores alemães da Medicina Social definiram: “a saúde das pessoas é um assunto que concerne diretamente à sociedade e essa tem a obrigação de proteger e assegurar a saúde de seus membros; as condições sociais e econômicas exercem uma importante influência sobre a saúde e a doença e tais relações devem ser cientificamente investigadas; as medidas destinadas a promover a saúde e a combater a doença devem ser tanto sociais como médicas”. (DONNANGELO; PEREIRA, 1976, p. 58). Os anos 70, apesar de ter sido um tempo de repressão, o campo da saúde consegue desenvolver alguns de seus objetivos perante a sociedade. Mundialmente e no Brasil, várias discussões, pensamentos e metas estavam sendo avaliados em diversas áreas da medicina, inclusive, nessa época começa a difundir a área da psiquiatria, entendendo que a saúde de qualidade era de total direito do cidadão (NUNES, 1994).

Entretanto, em função da crise da época, os problemas de ordem da saúde pública eram inúmeros, sem contar com um crescente aumento de novas patologias, inerentes à pobreza, como: aumento na incidência de acidentes de trabalho, doenças crônicas e destruição, somados às dificuldades já existentes, realmente as ações que pretendia a Medicina Social era de grande necessidade para a organização e melhoria da saúde (NUNES, 1994). Diante disso, a Medicina Social tenta se posicionar de forma mais efetiva e sugere uma nova avaliação das práticas médicas, e quem sabe uma inclusão de novas práticas, buscando investir na formação do conhecimento. Idealiza uma interação dos conceitos biológicos e sociais, alinhando-se com as convicções da Medicina Preventiva (AROUCA, 1992).

Nessa perspectiva de fomentar o conhecimento e construção de profissionais com pensamentos político-críticos, no decorrer dos anos 70, a Medicina de formação conquista grande feito, cria cursos de pós-graduação e começa a formar profissionais mestres e doutores em áreas como ciências sociais, planejamento e epidemiológica. Conservando-se nesses moldes até a década de 80, quando esses cursos passaram a ser chamados de mestrado e doutorado em saúde coletiva (BEZERRA JUNIOR; SAYD, 1993).

Com isso, a partir dos cursos de pós-graduação, instauram-se dois arranjos organizacionais para agregar e orientar a relevância das propostas da medicina social e saúde pública, que mais tarde fizeram frente à reforma de saúde e políticas sanitárias, denominadas de CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde) e ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva). Juntamente com o surgimento dessas organizações, após várias revogadas, a Resolução 16/81 desenvolve possibilidades para os programas de Medicina Preventiva e Social, sendo eles, uma referência à Medicina da Família e uma referência à Saúde Coletiva (NUNES, 1994).

2.6 TRAJETÓRIA DA SAÚDE COLETIVA

Deste momento em diante, caro acadêmico, já quase final da década de 70, o país vive uma crise na saúde, e para ter de resolver essas questões inicia-se então à elaboração, estruturação e organização de um novo paradigma, a Saúde Coletiva (NUNES, 1994). Ao começarmos a falar da história da Saúde Coletiva temos que ter em mente que esse modelo surgiu de uma fusão de várias vertentes de pensamento, pois ele se baseia em fundamentos da Medicina Preventiva, Social, Comunitária e nos movimentos europeus que viveram as reformas sanitárias e médicas, bem como a influência dos cursos de formação de medicina (NUNES, 1994).

Com pretensão de esquematizar uma revisão dos acontecimentos históricos pela qual a saúde coletiva passou, devemos destacar a preocupação em sanar os problemas de saúde da população e a importância dos aspectos sociais que influenciavam diretamente nessa temática (NUNES, 1994). A saúde coletiva se substancializa a partir do entendimento de que a problematização da saúde é um tanto enigmática, de grande alcance e que necessita transcender as práticas biológicas para viabilizar uma ampliação, interação e reestruturação do campo da saúde para poder atender às exigências populacionais, éticas e políticas que a hegemonia dos saberes biológico já não abrangia em sua totalidade (BIRMAN, 2005).

Muito se discutiu sobre a aceção da palavra “coletiva”, por ter inúmeros significados e ser confusa nas suas variações. Foi esse o termo que obteve maior consenso por entender que se ajustava dentro da diversidade dos aspectos da saúde, dando noção de multiplicidade, conjunto, pluralidade. Esse termo começa a ser utilizado pela ABRASCO (L’ABBATE, 2003).



Se você quiser visitar a página oficial da ABRASCO, entre no seguinte endereço:
<<http://www.abrasco.org.br/site/>>.

O termo “Saúde Coletiva” entra em vigor no Brasil no ano de 1979, a partir da união de alguns profissionais que já eram atuantes na Saúde Pública e que compartilhavam das mesmas ideias e formaram um novo conceito de domínio científico, com foco no aprofundamento teórico e metodológico, fomentação e introdução de políticas sociais que preconizassem atenção minuciosa da saúde como um todo, “coletiva”. (NUNES, 1994, p. 61). Ela passa por três momentos históricos: redes de pensamento, mobilização social e prática teórica.

A concepção da Saúde Coletiva Brasileira surge como uma perspectiva de construir um novo modelo de saúde que estabelecesse conexões nos diferentes âmbitos da saúde, perfazendo todas as técnicas, práticas, ideologias científicas, políticas e econômicas. Convictos desses objetivos, e diante de uma forte crise econômica que reverberava na saúde, a Saúde Coletiva é inserida e defendida por profissionais, sindicatos e a comunidade científica, para conseguir mudanças e transformações sócias para melhorar a saúde do país (L'ABBATE, 2003). A seguir você verá um quadro que tem por objetivo ajudá-lo a fixar e entender as datas e os acontecimentos que marcaram parte da saúde do Brasil, isto facilitará sua compreensão.

QUADRO 3 - DATAS E FATOS QUE MARCARAM A TRAJETÓRIA DA SAÚDE NO BRASIL

Ano	Fatos
1898 - 1945	• A saúde seguia o modelo sanitarismo campanhista, surge a caixa de aposentadoria e pensão.
1946-1984	• A saúde segue o modelo médico assistencial privatista.
1960	• A saúde é estruturada nas campanhas sanitárias – erradicação/controle de doenças – saneamento.
1964-1966	• Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) ainda seguia o modelo médico-assistencial privatista.
1975	• Criação do Sistema Nacional de Saúde pela Lei nº 6.229, e fixa campos institucionais da Saúde coletiva e individual.
1976	• Criação do CEBES: Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, com objetivo de democratizar a saúde e a sociedade.
1977	• Criação do INAMPS: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. • Criação da ABRASCO.
1979	• Inserção do termo “Saúde Coletiva”.
1980	• A saúde é oficializada como Coletiva Social e Política. • OMS adota meta de “Saúde para todos”! • Fim da exigência de apresentar a carteira de INAMPS.
1983	• Programa de Ações Integradas de Saúde em São Paulo.
1986	• Reforma Sanitária.
1987	• Criação do sistema Unificado e a descentralização da Saúde (SUDS), administrado pelo INAMPS.
1988	• Criação do SUS – Sistema Único de Saúde, vigente até a data atual.
1990	• Criação da Lei Orgânica da Saúde 8080. • Regulamentação do SUS.
1993	• Extinção do INAMPS. • Lei nº 8693, de 27.07.1993.

FONTE: Adaptado de Dias (2012)

Caro acadêmico, para entendermos todo o contexto em que a Saúde Coletiva está inserida faz-se necessária a compressão de um movimento muito forte que iniciou na década de sessenta e teve grande importância para a saúde. Para tanto, segue uma breve noção desses acontecimentos.

2.7 REFORMA SANITÁRIA

Este movimento originou-se na década de 60 em meio à Ditadura Militar, e aconteceu com objetivo de contestar os mandos autoritários da época e principalmente para tirar a saúde de uma intrínseca crise e lutar por saúde de dignidade para o povo brasileiro. Mas durante essa década as conquistas não foram de grande relevância, apenas articulações e certas alianças foram concretizadas, até por que as forças políticas da ditadura foram maiores (AROUCA, 1992). No decorrer dos anos 70 e 80, esse movimento que tinha recuado num primeiro momento, consegue amadurecer seus ideais e ganha força, obtendo espaço, nos sindicatos, nas universidades e com a massa popular que reivindicava melhoras na saúde, tomando as ruas, usando como mote: Saúde e Democracia (OLIVEIRA, 1988).

A Reforma Sanitária foi pensada e motivada pelo aguçado momento de mudanças que o país passava, e sua aspiração sempre foi contribuir para a democracia e assistir os direitos à saúde integral a todos como proteção social, porque nessa época só tinha direito à saúde os trabalhadores que eram cooperados do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), os demais não tinham vez. Os objetivos da reforma sanitária, segundo Arouca (1992), são: direito à saúde para todos sem distinção; acesso à saúde preventiva e curativa integrada; descentralização da gestão (SUS) e controle social das ações de saúde.

Em 1976, a saúde começa a ganhar novos horizontes e foi criado o Colégio Brasileiro de Estudos da Saúde – CEBES, distribuído em vários núcleos pelo país, idealizava uma saúde melhor para a sociedade (NUNES, 1994).

Em 1986, durante na 8ª Conferência Nacional da Saúde (CNS) firmou-se um novo conceito que traduz mudanças consideráveis na saúde e ficou estabelecido que a Saúde é direito dos cidadãos e dever do Estado, refletindo em melhores condições nos mais variados setores da vida, como: alimentação, trabalho, educação, transporte, habitação, lazer e liberdade, sendo, a partir disso, a finalidade maior dessa reforma sanitária, que serviu como base para futuras transformações na saúde (BRASIL, 1987).

Ao olharmos o passado da saúde, é de imediato que compreendemos a importância histórica da reforma sanitária, a caminhada de um povo forte que soube explorar a união dos profissionais de saúde, dos trabalhadores, estudantes e vários setores da população para lutar pelos seus ideais, enfrentar de peito aberto as lutas sociais em meio

à opressão imposta pela Ditadura Militar e tudo que isso significou para o Brasil, conseguiu direcionar essas lutas para a democratização da saúde, e passo a passo seus objetivos se fortaleceram tornando um marco na trajetória da saúde, auxiliada pelas transformações científicas que certificaram e fomentaram a saúde coletiva. (PAIM, 2009, p. 29).

Com o movimento da reforma sanitária as transformações na saúde começam a se realizar, como por exemplo, a criação do SUS em 1988, e mais recentes o Pacto pela Saúde e a Política Nacional de promoção à saúde em 2006, expressam progressão no setor, mas em meio a conflitos, contradições, desgastes, entraves políticos e cientes de que muito há ainda para fazer, a saúde brasileira segue em luta árdua governo após governo, até os dias atuais, em busca de uma saúde digna e de qualidade para todos (PAIM, 2009).



Depois de termos conhecido toda a trajetória da Saúde Coletiva no Brasil e entender que a busca por condições melhores de saúde ainda continua, vamos partir para o entendimento da transdisciplinaridade na Saúde Coletiva.

2.8 TRANSDISCIPLINARIDADE NA SAÚDE COLETIVA

Iniciaremos este novo item, caro acadêmico, levantando alguns questionamentos sobre: Qual é a importância da transdisciplinaridade dentro da saúde coletiva? Respondemos a essa questão apontando que atualmente existem desafios na construção de políticas públicas e assim a saúde coletiva busca um novo método denominado Gestão Colegiada centrada em equipes de saúde, com uma prática de trabalhos em equipes multiprofissionais – campo complexo e transdisciplinar.

Além dos desafios na construção de políticas públicas, a comunidade acadêmica lutava também para avançar em pesquisas e ultrapassar sua área de conhecimento (medicina biologicista). E então, com esse olhar mais para a especificidade e transdisciplinaridade, a Saúde Coletiva idealiza compreender o indivíduo em sua integralidade, e ao mesmo tempo abre e estrutura um novo campo de atuação e produção científica, remodelando suas práticas e trazendo seus objetivos para o coletivo (BURDANDY; BODSTEIN, 1998).

A transdisciplinaridade entra como uma nova proposta de contemplar toda essa complexidade dos saberes e das práticas, adicionando à diversidade aos saberes disciplinares, que vem a ser o produto final no histórico da saúde coletiva que passa por evoluções significativas como a multidisciplinaridade,

pluridisciplinaridade, metadisciplinaridade, interdisciplinaridade, chegando à transdisciplinaridade (LUZ, 2009).

Segundo Nicolescu (1999, p.11), um dos autores mais citados no que se refere a Transdisciplinaridade, conceitua- a como: “a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são quatro flechas de um único e mesmo arco: o conhecimento”. Assim, você poderá visualizar no quadro a seguir como a transdisciplinaridade é moldada atualmente na saúde coletiva, contemplando seus saberes científicos e práticas, bem como seus agentes de atuação (LUZ, 2009).

QUADRO 4 - SAÚDE COLETIVA: CAMPO TRANSDISCIPLINAR DE SABERES E PRÁTICAS

Saúde Coletiva		Transdisciplinaridade	
(1ª caracterização)		Saberes → Disciplinas	
		Ciências	Biomédicas
		“Produção de verdades”	Humanas
		Paradigma do Conhecimento	Físicas
Saúde Coletiva		Agentes	
		Profissionais (pesquisadores, técnicos, docentes, gestores).	
		Prática → Políticas	
		Intervenções	Técnicas
“Área” (CAPES)	Campo (Bourdieu)	Transformações (Paradigma da eficácia)	Éticas

FONTE: Adaptado de Luz (2009, p. 307)



Olá acadêmico! Estamos finalizando esse nosso primeiro tópico. E como sugestão, deixamos um vídeo de uma aula da psicóloga Sandra Felicidade Lopes da Silva (CRP 08/12815), publicado em 14 jun. 2013. Assista ao vídeo abaixo e complemente o seu aprendizado.

Vídeo: <<https://www.youtube.com/watch?v=S7eyOQblfvA>>.

LEITURA COMPLEMENTAR

TEXTO EM CORDEL SOBRE A REFORMA SANITÁRIA

Leia a seguir um poema popular, um cordel escrito por Rubens Alves e Sérgio Arouca sobre a Reforma Sanitária.

Reforma Sanitária Brasileira. Já te contaram?



Cordel da Reforma Sanitária

Os militantes da Reforma Sanitária não aceitavam o modelo médico-assistencial privatista porque favorecia a exploração e era elitista não atendia às necessidades de saúde do povo enfim o Brasil precisava de algo novo.

O modelo de atenção à saúde adotado no país

centrado na doença era considerado ineficaz e ineficiente
e a população queria um sistema de saúde
democrático, resolutivo e eficiente

Com a difusão das ciências sociais no Brasil

o Movimento de Reforma Sanitária
vivenciou experiências de medicina comunitária
e de medicina preventiva também
várias experiências foram bem-sucedidas.

No contexto de redemocratização

a 8ª Conferência Nacional de Saúde
realizada de 17 a 21/03 de 1986
foi a mais avançada da história
afinal o povo participou do debate pela primeira vez
conquistando o SUS como vitória!

Dos 4.000 participantes reunidos em Brasília

1000 delegados representaram governo
entidades privadas, usuários e sociedade civil
as propostas foram contempladas na Constituição de 1988,
algo assim nunca ocorreu na história do Brasil,
culminando, em 1990, nas leis 8080 e 8142
regulamentadas depois.

Debateu-se o conceito ampliado

e a saúde, até então abstrata, adquiriu concretude
através da intersetorialidade, regionalização
controle social, descentralização
acesso universal, equidade e integralidade
e de direitos humanos pra sociedade.

A VIII Conferência legitimou

o projeto da Reforma Sanitária
o SUS tornou-se um amplo projeto político-social
isso comprova que interatividade é vital!
percebi que o SUS é co-criação!
projeto contra hegemônico em construção....

FONTE: Disponível em: <<http://scoobyturmab2.blogspot.com.br/2012/04/reforma-sanitaria-brasileira-ja-te.html>>. Acesso em: 2 jun. 2016.

ATIVIDADE PRÁTICA

Ações Recordatórias do período da Reforma Sanitária

Objetivo: Realizar um recordatório visual, em forma de cartazes sobre a Reforma Sanitária nas décadas de 70 e 80, trazer os fatos daquele momento, tentando demonstrar o que foi a luta desse movimento. Elaborar um material expositivo e apresentá-lo em sala de aula.

Tempo de duração: 48 horas.

Material a ser utilizado: entrevistas, fotografias, imagens, recortes de jornais e revistas, cola e uma cartolina. Separado em grupos ou cada grupo cria o seu.

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você viu:

- Uma breve retrospectiva nos históricos conceituais de Saúde e Saúde Pública.
- As diferenças Saúde Pública e Saúde Coletiva.
- A trajetória histórica da Saúde Coletiva Brasileira.
- A formação de um Movimento Preventivista, grande feito no campo conceitual que trouxe mudanças na prática médica, e benefícios para a sociedade.
- Reestruturação pedagógica, modernização no curso de medicina.
- Com Medicina Preventivista, que acompanha os movimentos internacionais, surge a idealização da Medicina Comunitária para assistir comunidades de baixa renda, populações menos favorecidas.
- O surgimento da Medicina Social que futuramente seria a própria Saúde Pública.
- A instituição dos campos de conhecimentos, saberes e práticas.
- Fomento do conhecimento e construção de profissionais com pensamentos político-críticos.
- Criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES).
- Criação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO).
- A saúde coletiva se substancializa a partir do entendimento de que a problematização da saúde é complexa.
- Várias discussões para a definição do termo “coletiva”.
- O termo “Saúde Coletiva” entra em vigor no Brasil no ano de 1979.
- Saúde Coletiva: Rede de pensamentos, Mobilização Social e Prática teórica.
- Trajetória da Reforma Sanitária no país.

- Reforma sanitária: Direito à saúde para todos sem distinção, acesso à saúde preventiva e curativa integrada, descentralização da gestão, controle das ações de saúde.
- Transdisciplinaridade na Saúde Coletiva.
- Evoluções significativas passando pelos paradigmas multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, metadisciplinaridade, interdisciplinaridade, até chegar ao paradigma atual: a transdisciplinaridade dentro da saúde coletiva.
- Saúde Coletiva: Campo transdisciplinar de saberes e práticas.
- Criação do SUS em 1988.



1 Saúde Pública é:

“Uma e uma de evitar doenças, prolongar a e desenvolver a saúde física, mental e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade para o do meio ambiente, controle das na comunidade, a organização dos e paramédicos para o diagnóstico e o tratamento de doenças, e o aperfeiçoamento da máquina social que irá a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à manutenção da”. (WINSLOW, 1920, p. 23).

Assinale a alternativa correta que preenche a citação acima:

- a) () Ciência, arte, morte, saneamento, infecções, serviços paramédicos, precoce, preventivo, assegurar, saúde.
- b) () Ciência, arte, vida, saneamento, infecções, serviços médicos, precoce, preventivo, assegurar, saúde.
- c) () Ciência, arte, vida, saneamento, infecções, serviços médicos, precoce, preventivo, inviabilizar, saúde.
- d) () Ciência, arte, vida, saneamento, infecções, serviços médicos, tardio, preventivo, assegurar, saúde.

2 Entendemos que há várias diferenças entre Saúde Pública e Saúde Coletiva. Das semelhanças apresentadas, assinale a INCORRETA:

- a) () Somente a saúde individual.
- b) () Somente a especificidade.
- c) () Saúde para todos.
- d) () A Saúde oferecida pelo SUS não faz parte da Saúde Pública e nem da saúde Coletiva.

3 Com relação à Saúde Coletiva assinale V para verdadeiro e F para falso sobre suas características:

- () É um campo de produção do conhecimento que atua no processo saúde-doença da coletividade, vai além do diagnóstico e tratamento.
- () É mais ampla e está centralizada na figura do médico.
- () Surgiu para controlar doenças e como uma tentativa de erradicar a miséria, analfabetismo e desnutrição.
- () É pautado no campo científico/acadêmico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – V – V.
- b) () V – F – F – F.
- c) () F – V – F – V.
- d) () V – F – F – V.

4 Movimento preventivista. Assinale a alternativa verdadeira:

- a) () Movimento ideológico, um grande acontecimento no campo conceitual, que trouxe mudanças na prática médica, com conseqüente benefícios para a sociedade.
- b) () É de dever de o Estado assegurar serviços e políticas públicas para a promoção e bem-estar da população.
- c) () É um movimento complexo definível apenas em sua configuração mais ampla.
- d) () É um único campo científico e um âmbito de práticas, que muito contribuiu com a Reforma Sanitária Brasileira.

AS AÇÕES DE SAÚDE, POLÍTICAS PÚBLICAS E EIXOS DE ATUAÇÃO DA SAÚDE

1 INTRODUÇÃO

Em todo o mundo, os sistemas de saúde estão em constante processo de construção e desenvolvimento, com objetivos de prover um melhor estado de saúde para as suas populações. Consequentemente, os sistemas não são estáticos, pois devem acompanhar as necessidades e mudanças sociais e culturais que acompanham o desenvolvimento de qualquer sociedade (DEMARZO; AQUILANTE, 2012, p. 580).

Assim prevenir doenças e promover saúde são consideradas duas estratégias fundamentais para essa melhoria das condições de saúde da população.

Neste tópico, você entenderá que as práticas sociais da saúde coletiva englobam a promoção, proteção, recuperação e reabilitação fundamentadas pelo planejamento da política e da gestão em saúde, como também das equipes multiprofissionais e saberes interdisciplinares, além de abordarmos as políticas públicas saudáveis (PPS), o movimento cidades saudáveis e o entendimento dos eixos de atuação da saúde (Intersetorialidade e Integralidade).

Este tópico será dividido em três itens. No primeiro, “Práticas sociais da saúde (diferenciação entre promoção, proteção, recuperação, reabilitação)”, apresentaremos suas diferenças, características, formas de atuação e local de intervenção. No segundo item serão discutidas as Políticas Públicas Saudáveis e Movimento Cidades Saudáveis, mostrando os níveis de atuação dos diferentes setores do governo e as estratégias usadas. E por fim, no último item, abordaremos dois eixos de atuação da saúde, a intersetorialidade e a integralidade, descrevendo seus conceitos e sua importância no contexto da saúde atual.

2 PRÁTICAS SOCIAIS DA SAÚDE (DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO)

Caro acadêmico, a Saúde Coletiva aproxima as ciências sociais e humanas da saúde e ao fazê-lo, segundo Paim e Almeida Filho (1998, p. 310), coloca como elementos significativos “a superação do biologismo dominante, da naturalização da vida social, da sua submissão à clínica e da sua dependência ao modelo médico hegemônico”, elementos que representam os desafios importantes no avanço da saúde coletiva. Para que esse avanço seja efetivo, algumas ações em saúde foram necessárias, trazendo consigo as influências do relacionamento entre os grupos sociais (OSMO; SCHRAIBER, 2015). Caro acadêmico, veja, a seguir, as ações de saúde, segundo Osmo e Schraiber (2015): promoção, proteção, recuperação e reabilitação.

As necessidades sociais em saúde norteiam as ações da saúde coletiva, preocupando-se com a saúde do público em geral (indivíduos, grupos étnicos, classes sociais e populações), instigando uma maior e mais efetiva participação da sociedade na dimensão do coletivo e do social, nas questões da vida, da saúde, do sofrimento e da morte (CARVALHO; CECCIM, 2006). No pós-guerra, a medicina preventiva tinha uma realidade centrada na integralidade da atenção, englobando cinco níveis de prevenção: promoção, proteção, diagnóstico precoce, limitação do dano e reabilitação.

Após esse período, veja, acadêmico, a prevenção, originou-se da saúde pública e foi organizada em três níveis segundo Paim (2001) e Lacerda Júnior e Guzzo (2005): na prevenção primária (medidas inespecíficas ou de promoção ou de proteção e ações dirigidas a grupos amplos, tomando antes de uma doença se estabelecer e possuem um caráter educativo maior do que os outros níveis);

prevenção secundária (recuperação da saúde, ocorre após a identificação de fatores de risco e busca evitar que o problema se torne crônico, por meio de diagnóstico e intervenção precoces); prevenção terciária (reabilitação, o mais específico de todos os níveis e busca reabilitar ou minimizar os efeitos de uma doença já instalada) Lacerda Junior e Guzzo (2005, p. 240).

Entende-se que a saúde da população resulta da forma com que a sociedade se organiza, levando em conta as dimensões econômica, política e cultural, assim, segundo a Constituição da República “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL, 2012).

Ao apontar a Saúde Coletiva e a sua relevância social, Carvalho e Ceccim (2006, p. 29-30) relatam:

A Saúde Coletiva, após os movimentos da saúde pública, da saúde preventiva, da saúde comunitária e da reforma sanitária ampliou e ressingularizou o campo de atuação dos profissionais de saúde. Da assistência às doenças ao cuidado humano, da nosologia médica às necessidades em saúde, do tratamento e reabilitação à integralidade

da saúde. Cada núcleo profissional foi ampliado e a pesquisa em saúde em todas as profissões intensificada. Não cabe mais a cada profissão uma parcela no diagnóstico e tratamento das doenças, mas detectar e ofertar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e produção da saúde e da vida.

Agora que você leu e compreendeu que as ações de saúde se dividem em prevenção primária, secundária e terciária e que é prevista na lei da Constituição Federal. Vamos entender, a partir de agora, cada uma, isoladamente, e suas interposições.



Acadêmico! Você sabe o que é prevenção e a sua relação com a saúde? Você entenderá essa relação e o que definimos como prevenção, lendo a citação a seguir.

“A palavra prevenção tem origem no Latim *praeventione*: vir antes, tomar a dianteira; traduz-se pelo ato de prevenir-se, premeditar, dispor-se previamente ou ter opinião antecipada”. (CESTARI; ZAGO, 2005, p. 219).

Na saúde o termo prevenção precisa estar atento à dificuldade das relações com modelos, “padrões de reconhecimento e valorização dos aspectos culturais, levando em conta os valores, atitudes e crenças dos grupos sociais a quem a ação se dirige, ou seja, aos seus aspectos culturais”. (CESTARI; ZAGO, 2005, p. 220). A prevenção em saúde, baseando-se no conhecimento da história natural para evitar o progresso da doença, exige uma ação antecipada, ou seja, as ações preventivas podem ser definidas como intervenções orientadas, reduzindo a incidência e prevalência das doenças (CZERESNIA; FREITAS, 2009).

A epidemiologia é uma das disciplinas que dá a base do discurso voltado a prevenção, pois procura o domínio da transmissão de doenças infecciosas, a diminuição do risco de doenças degenerativas ou outros agravos característicos, até recomendações normativas de mudanças de costumes e comportamentos (CZERESNIA; FREITAS, 2009). Composta por ações de caráter primário e genérico, a prevenção na área da saúde, envolve segundo Cestari e Zago (2005), melhoria das condições de vida; educação da sustentabilidade das pessoas às doenças; educação sanitária; detecção precoce das doenças; tratamento adequado das doenças e ações destinadas a minimizar as consequências dessas.

A prevenção é importante em atitudes individuais, como medidas preventivas de usar camisinha, vacinar-se, alimentar-se bem, usar cinto de segurança, não tomar sol depois das dez da manhã etc. Assim, nós estaremos nos protegendo contra as doenças. E também coletivamente, quando o governo adota medidas preventivas como vacinações, barreiras sanitárias para impedimento de

contaminação por estrangeiros, visitas às casas das pessoas para detectar focos de mosquitos transmissores de doenças, inspeção permanente de alimentos para evitar intoxicações alimentares etc. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2004).



Agora que você leu sobre a prevenção da saúde, vamos entender a promoção da saúde e suas diferenças. Você sabe essas diferenças?

Para diferenciar a prevenção de promoção, pode-se dizer que a promoção se caracterizaria por uma intervenção ou conjunto de intervenções que, teria como um objetivo ideal “não apenas evitar que as doenças se manifestem nos indivíduos e nas coletividades de indivíduos, mas, a eliminação permanente, ou pelo menos duradoura, da doença porque buscaria atingir suas causas mais básicas” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2004, p. 145).

E também a promoção da Saúde, caro acadêmico, pode ser entendida como um processo de capacitação da comunidade, família e indivíduo, “incorporando valores como solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria que se constitui numa combinação de estratégias para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde” (MACHADO et al., 2007, p. 336).

Veja, no quadro a seguir, a distinção entre prevenção das doenças e promoção da saúde.

QUADRO 5 - CARACTERÍSTICAS DA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE

PREVENÇÃO DAS DOENÇAS	PROMOÇÃO DA SAÚDE
Saúde = ausência de doença	Saúde = conceito positivo e multidimensional
Direcionado principalmente aos grupos de alto risco na população	Direcionado à população no seu ambiente total
Envolve patologias específicas	Envolve uma rede de questões de saúde
Estratégia única	Estratégias diversas e complementares
Medidas diretivas são fortalecidas em grupos-alvo	Medidas incentivadoras são oferecidas à população
Programas focalizando principalmente tópicos individuais e de grupos.	Mudanças no <i>status</i> dos homens e de seu ambiente são buscadas nos programas
Programas preventivos são assunto dos grupos profissionais.	Organizações não-profissionais, grupos cívicos e governos municipais, regionais e nacionais são necessários para se atingir as metas de promoção da saúde.
	Modelo participativo de saúde
	Abordagens facilitadoras e integradoras

FONTE: Disponível em: <<https://goo.gl/yk5Dtu>>. Acesso em: 20 maio 2016.

Buss (2009), no livro “Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências, também aponta diversas características que diferenciam a prevenção de doenças e promoção da saúde complementando a figura acima.

QUADRO 6 - DIFERENÇAS ENTRE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Categorias	Promoção da Saúde	Prevenção de doenças
Conceito de saúde	Positivo e multidimensional	Ausência de doenças
Modelo de Intervenção	Participativo	Médico
Alvo	Toda a população no seu ambiente total	Principalmente os grupos de alto risco da população
Incumbência	Rede de temas de saúde	Patologia específica
Estratégias	Diversas e complementares	Geralmente única
Abordagens	Facilitação e capacitação	Direcionadoras e persuasivas
Direcionamento das medidas	Oferecidas à população	Impostas a grupos-alvo
Objetivos dos programas	Mudanças nas situações dos indivíduos e de seu ambiente	Focam principalmente em indivíduos e grupos de pessoas
Executores dos programas	Organizações não profissionais, movimentos sociais, governos locais, municipais, regionais e nacionais, etc.	Profissionais de saúde

FONTE: Adaptado de Buss (2009, p. 39)

Um dos objetivos das ciências da saúde e principalmente da epidemiologia há mais de 50 anos é como prevenir as causas (tanto no ambiente quanto nos comportamentos sociais) de várias doenças que podem evoluir geralmente para a morte (RESTREPO, 2001). Assim, entender como os aspectos socioculturais, econômicos, biológicos e de que a saúde e doença decorrem das condições de vida como um todo, passam a estar mais presentes nos debates sobre as formas de se promover a saúde (FARINATTI; FERREIRA, 2006).

Em 1974, o Governo canadense, publicou o Informe Lalonde, amplamente difundido, que influenciou fortemente o nascente movimento da Organização de Saúde e esse informe pode-se dizer que “foi a primeira declaração teórica geral de saúde pública surgida dos descobrimentos no campo da epidemiologia das enfermidades não infecciosas”. Definindo-se então o conceito do “Campo da Saúde” envolvendo quatro áreas da biologia humana, meio ambiente, estilos de vida e organização da atenção sanitária (RESTREPO, 2001, p. 25).

A promoção da saúde surgiu basicamente nos últimos 25 anos, em países como Estados Unidos, Europa Ocidental e Canada, englobando três conferências sobre o tema que estabeleceram as bases conceituais e políticas contemporâneas

da promoção da saúde, em 1986 (Ottawa), 1988 (Adelaide) e Sudsval (1991). “Em seguida tiveram as conferências de Jakara (1997), México (2000) e a Conferência Internacional de Promoção da Saúde na América Latina, em 1992, que em conjunto passam a representar um enfoque político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado” (BUSS, 2009, p. 19).

Essas Conferências foram implementando o significado do termo Promoção da Saúde, somando aos elementos já constituídos os valores da vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria e trazendo a “responsabilização múltipla”, tanto do Estado (políticas públicas saudáveis), como dos indivíduos e coletividades (desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas), do sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde) e das parcerias intersetoriais (BUSS, 2003, p. 15-18).

A promoção da saúde “não constitui responsabilidade restrita do setor saúde, mas de uma integração entre os diversos setores do governo municipal, estadual e federal, os quais articulam políticas e ações que culminem com a melhoria das condições de vida da população e da oferta de serviços essenciais aos seres humanos” (MACHADO et al., 2007, p. 336).

Devemos ter em mente, caro acadêmico, que ao desenvolver um programa para promoção da saúde e prevenção de doenças, a finalidade é proporcionar a mudança do exemplar assistencial vigente no sistema de saúde e a melhora da condição de vida dos indivíduos, aceito que grande parte das doenças que agride a população é passível de prevenção (FARINATTI; FERREIRA, 2006), sempre com redução dos gastos evitáveis, como resultado da aplicação de uma efetiva política de prevenção, com peso no reconhecimento e valorização de um novo conceito de saúde, mais abrangente, que contempla: o bem-estar físico, mental e social do indivíduo (FARINATTI; FERREIRA, 2006).

No espaço clínico, as atividades de promoção da saúde englobam além de intervenções de prevenção de doenças, outras como imunização, *screening*, tratamento quimioterápicos e principalmente abranger intervenções educativas sobre modificações de estilos de vida individuais. (FLORIN; BASHAM, 2000).



No parágrafo acima, você leu que a promoção da saúde envolve intervenções educativas. O Tópico 3 será exclusivamente dedicado à abordagem da educação na saúde.

Veja no quadro a seguir, caro acadêmico, o resumo de algumas ações, programas e orientações de prevenção e promoção da saúde, preconizada na página do Portal de Saúde do SUS. Alguns programas têm páginas específicas e outros informativos na própria página do SUS, com dicas de como ter uma

vida saudável e manter hábitos de promoção e proteção da sua saúde. Também estão disponíveis dados sobre algumas doenças, bem como políticas e ações do Ministério da Saúde para o controle dessas. Está disponível no endereço *on-line*: <<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/orientacao-e-prevencao>>.

QUADRO 7 - RESUMO DE ALGUMAS AÇÕES, PROGRAMAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO DA SAÚDE

Orientação e prevenção	
AIDS	Desde 1996, com a distribuição gratuita de medicamentos aos brasileiros em tratamento contra a aids, houve um acréscimo na sobrevida e uma melhoria na condição de vida dos portadores do HIV.
Tabagismo	Os números do tabagismo no mundo são alarmantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, a cada dia, 100 mil crianças tornam-se fumantes em todo o planeta.
Alimentação Saudável	Uma boa alimentação é sinônimo de vida saudável. Por ser um fator ligado diretamente à saúde das pessoas, o ministério tem o compromisso de zelar pela alimentação dos brasileiros.
Transplantes	A Política Nacional de Transplantes de Órgãos e Tecidos tem, entre suas diretrizes, a gratuidade da doação. Confira mais informações e seja, você também, um doador.
Diabetes	O diabetes já afeta cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo. A estimativa é de que, até 2025, esse número aumente para 380 milhões.
Medicamentos	Os medicamentos podem curar uma doença se usados corretamente, mas do contrário podem prejudicar. Por isso, não abra mão da receita. O Ministério fornece diversos produtos gratuitamente.
Hipertensão	Hoje, no Brasil, existem mais de 30 milhões de hipertensos e estima-se que apenas 10% façam o controle adequado da doença.
Doenças Reumáticas	Segundo estatísticas, 15 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de reumatismo. Se a doença for descoberta no início e tratada corretamente, o paciente pode levar uma vida normal e sem dores.
Exemplo de algumas Ações e Programas	
Provad	O programa leva mais médicos para mais perto da população. Amplia a assistência principalmente aos usuários do SUS que ainda têm dificuldades para acessar serviços e profissionais de saúde. Com isso, as desigualdades regionais relacionadas à presença e permanência de profissionais de saúde são reduzidas.
Academia da saúde	Lançado em abril de 2011, o Programa Academia da Saúde estimula a criação de espaços públicos adequados para a prática de atividade física e de lazer. O objetivo é contribuir para a promoção da saúde da população.
Farmácia Popular	Programa criado pelo ministério para ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, vendidos a preços mais baixos que os praticados no mercado. São medicamentos contra diabetes, hipertensão, entre outros.
HumanizaSUS	A Política Nacional de Humanização aposta em estratégias construídas por gestores, trabalhadores e usuários do SUS para qualificar a atenção e gestão em saúde.

Bancos de Leite Humano	A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, criada em 1998, pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), tem o objetivo de promover a expansão quantitativa e qualitativa dos bancos de Leite Humano no Brasil, mediante integração e construção de parcerias entre órgãos federais, iniciativa privada e sociedade.
------------------------	---

FONTE: Adaptado de <<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/orientacao-e-prevencao>>. Acesso em: 11 jul. 2016.

Outras iniciativas que fazem parte da Promoção da Saúde são: municípios saudáveis, vigilância ambiental em saúde, melhoria sanitária domiciliar, Agenda 21, desenvolvimento local integrado/sustentável e rede brasileira de habitação saudável (COHEN et al., 2004).

Caro acadêmico, agora que você compreendeu a importância da promoção da saúde, vamos entender os municípios saudáveis. “O Movimento Cidade Saudável é uma estratégia de promoção da saúde e tem como objetivo maior a melhoria da qualidade de vida da população”. (ADRIANO et al., 2000, p. 51).

3 POLÍTICAS PÚBLICAS SAUDÁVEIS (PPS) E MOVIMENTO CIDADES SAUDÁVEIS

“As ideias de Políticas Públicas Saudáveis (PPS) iniciaram-se na 8ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde, Ottawa, Canadá, em 1986, que considera a elaboração e implementação de PPS um dos cinco campos de ação social para a promoção da saúde, ao lado da criação de ambientes favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e a reorientação do sistema de saúde” (BUSS, 2003, p. 19) ao mesmo tempo que, no Brasil, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco do processo brasileiro de Reforma Sanitária.

A utilização do termo políticas públicas saudáveis é relativamente novo, surgindo no século XX e associando a tomada de consciência de que as condições sociais e políticas tinham um impacto, positivo ou negativo, na saúde das populações (PNS, 2011). Nas conferências internacionais, debate-se que o PPS deve ter, segundo Teixeira (2004a, p. 40):

vinculação entre as políticas econômicas e sociais, – participação democrática no processo de formulação de políticas, – responsabilização compartilhada entre o setor público e o setor privado, - proposta de estabelecimento de parcerias entre os diversos setores, – mobilização de pessoas e grupos para a organização, – desencadeamento de ações políticas coletivas voltadas à intervenção sobre os determinantes da saúde em diferentes contextos e territórios.

Segundo Buss (2003, p. 27), “as políticas públicas saudáveis (PPS) se expressam por diversas abordagens complementares, que incluem legislação, medidas fiscais, taxações e mudanças organizacionais, e por ações coordenadas

que apontam para a equidade em saúde, a distribuição mais equitativa da renda e políticas sociais”.

Segundo Teixeira (2004a, p. 41),

O planejamento e a gestão de PPS ocorrem nos níveis nacional, estadual e municipal, que são espaços privilegiados para a adoção de conceitos e experimentação de métodos, técnicas e instrumentos que incorpora a interdisciplinaridade na análise dos problemas, a intersetorialidade na definição das soluções e a horizontalidade.

Várias propostas do PPS levaram a formulação de políticas em vários níveis de governo, países, criando a ideia do “Movimento cidades saudáveis”, tática adotada pela OMS em 1984 para provocar a reorientação da gestão governamental em nível local (FERRAZ, 1999). Segundo a OPAS, considera-se um município saudável:

aquele em que as autoridades políticas e civis, as instituições e organizações públicas e privadas, os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da população; estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e expandem os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver a solidariedade, a cogestão e a democracia. (OPAS, 1996 apud ADRIANO et al., 2000, p. 54).

Veja, caro acadêmico, que a função dos movimentos das cidades saudáveis é levar no final ao desenvolvimento de comunidades saudáveis. As cidades saudáveis têm como base conduzir ao desenvolvimento de políticas públicas desenvolvimento de políticas públicas que acarretem a criação de ambientes saudáveis para a existência de comunidades também saudáveis (ADRIANO et al., 2000).

Segundo a OMS (1995) apud Adriano et al. (2000, p. 5):

para que uma cidade se torne saudável ela deve esforçar-se para proporcionar: 1) um ambiente físico limpo e seguro; 2) um ecossistema estável e sustentável; 3) alto suporte social, sem exploração; 4) alto grau de participação social; 5) necessidades básicas satisfeitas; 6) acesso a experiências, recursos, contatos, interações e comunicações; 7) economia local diversificada e inovativa; 8) orgulho e respeito pela herança biológica e cultural; 9) serviços de saúde acessíveis a todos e 10) alto nível de saúde.

Moysés, Moysés e Krempel (2004) apontam, no quadro a seguir, uma proposta teórica como referência para a construção de critérios de avaliação de ações de promoção de saúde desenvolvidas nos ambientes da cidade envolvidos no Programa Vida Saudável.

QUADRO 8 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Resultados sociais e de saúde	Qualidade de vida, independência, equidade mortalidade, morbidade, deficiência		
Resultados intermediários de saúde	Estilo de vida saudável (fumo, opções alimentares, atividade física, uso de álcool e drogas)	Efetividade dos serviços de saúde (provisão de serviços preventivos, acesso a serviços de saúde apropriados)	Ambientes saudáveis (ambiente físico, condições econômicas e sociais de suporte, bom suprimento de alimentos, acesso restritivo a fumo e álcool)
Resultados de Promoção de Saúde	Conhecimento sobre saúde (conhecimento, atitudes, motivação, comportamentos, habilidades pessoais, autoconfiança)	Influência e ação social (participação comunitária, empoderamento comunitário, normas sociais, opinião pública)	Políticas públicas de saúde e prática organizacional (legislação, regulação, prática organizacional)
Ações de Promoção de Saúde	Educação (educação escolar, educação do paciente, mídia, comunicação)	Facilitação (desenvolvimento comunitário, aconselhamento técnico, facilitação grupal)	Defesa da saúde (organização política e ativismo, combate à burocracia)

FONTE: Moysés, Moysés e Krempel (2004, p. 638)

4 EIXOS DE ATUAÇÃO DA SAÚDE (INTERSETORIALIDADE E INTEGRALIDADE)

Você sabe o que é integralidade, acadêmico? Para responder a essa pergunta Mattos (2001, p. 43) aponta que

a integridade em uma primeira aproximação, é uma das diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição de 1988, mas que no texto constitucional não tem a expressão integralidade, mas o texto fala em atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, então o termo integralidade tem sido utilizado correntemente para designar exatamente essa diretriz.

Veja, no quadro a seguir, os eixos de atuação que compõe a integralidade.

QUADRO 9 - EIXOS DE ATUAÇÃO QUE COMPÕEM A INTEGRALIDADE

1	Estimular e fortalecer práticas no campo da atenção à saúde que favoreçam o uso adequado de medicamentos e à desmedicalização sempre que possível.
2	Estimular e fortalecer a organização do trabalho em equipes multiprofissionais.
3	Estimular e fortalecer a relação dos serviços de saúde com os territórios em que se localizam.
4	Investir na construção de colegiados gestores nos serviços de saúde que incluam a participação da população.

5	Investir na inclusão dos usuários na elaboração de seus projetos de saúde (individuais e coletivos).
6	Investir em modos de organização dos serviços de saúde que reduzam as filas e o tempo de espera baseados na adoção de critérios de risco e no acolhimento.
7	Desenvolver estratégias de suporte ao trabalho das equipes de saúde da família que articulem/integrem diferentes áreas do saber conforme as necessidades de saúde locais/regionais.

FONTE: Adaptado de Campos, Barros e Castro (2004, p. 749)



Caro acadêmico, você verá na Unidade 2, especificamente, os princípios do SUS, mas já podemos entender que: “O conceito de integralidade é um dos pilares a sustentar a criação do Sistema Único de Saúde, princípio consagrado pela Constituição de 1988, em que seu cumprimento pode contribuir muito para garantir a qualidade da atenção à saúde”. (CAMPOS, 2003, p. 573).

Vários estudos trazem a noção de integralidade como se ela fosse sinônima de garantia de acesso a todos os níveis do sistema de serviços de saúde. Veja os sentidos do termo integralidade, segundo Mattos (2004, p. 1413): “Primeiro sentido: abrangência de respostas governamentais, no sentido de articular ações de alcance preventivo com as assistenciais. – Segundo sentido: aspectos da organização dos serviços de saúde. – Terceiro sentido: voltado para atributos das práticas de saúde”.

“O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos em todos os níveis de complexidade do sistema”, chama-se integralidade da Assistência (MACHADO et al., 2007, p. 338). Pergunto-lhes por que é importante abordar a assistência de forma integrada?

Pois a assistência de forma integrada está fundamentada na articulação de todos os passos na produção do cuidado e no restabelecimento da saúde. Propõe-se mapear a integralidade da assistência pelo acompanhamento da linha do cuidado, evitando-se assim a sua fragmentação. Cada usuário deverá ser acompanhado segundo determinado projeto terapêutico instituído, comandado por um processo de trabalho cuidador, e não por uma lógica “indutora de consumo”. (MACHADO et al., 2007, p. 338).

Além da “divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”. (MACHADO et al., 2007, p. 338). Veja, na figura a seguir, o que compõe a integralidade da assistência.

FIGURA 1 - INTEGRALIDADE DO SISTEMA



FONTE: Disponível em: <http://images.slideplayer.com.br/6/1658473/slides/slide_5.jpg>. Acesso em: 24 maio 2016.

Agora, caro acadêmico, vamos entender a **intersectorialidade** e sua importância na saúde. “Intersectorialidade é entendida como a articulação de saberes e experiências no planejamento, a realização e a avaliação de ações, com o objetivo alcançar resultados integrados em situações complexas, visando a um efeito sinérgico no desenvolvimento social”. (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1997, p. 26).

Caracteriza-se a intersectorialidade, segundo Moysés, Moysés e Krempel (2004), como a articulação entre os sujeitos de setores sociais, com poderes, conhecimentos e vontades diversos, para enfrentar vários problemas complexos; a intervenção na cidade, criando espaços de compartilhamento de saber e poder; a construção de novas linguagens e novos conceitos; o desenvolvimento da capacidade de escuta e negociação; o entendimento que nenhum setor tem poder suficiente para dar conta do problema sozinho; a possibilidade de uma ação mais potente e resolutiva.

Basicamente, “relatamos que no campo das políticas sociais os setores eram representações independentes e, no limite, apenas comunicantes entre si e que para organizar essa forma de estrutura segmentada, usa-se então a estratégia denominada intersectorialidade”. (ALMEIDA FILHO, 2000, p. 12). Podemos dizer que segundo a lógica da intersectorialidade, ocorre mais a participação do cidadão, tanto no planejamento quanto na avaliação, veja no quadro a seguir:

QUADRO 10 - COMPARAÇÃO DE MODELOS DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE GOVERNO, CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE DEPARTAMENTALIZAÇÃO, A MISSÃO E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA VISÃO DA INTERSETORIALIDADE

Parâmetro	Modelo Tradicional	Modelo na visão da intersectorialidade
Departamentalização	- secretarias por área de conhecimento ou intervenção; - saúde, educação, obras, transporte, etc.	- secretarias por área geográfica : regiões ou distritos.
Missão de cada secretaria	- Realizar ações e serviços da competência da prefeitura, específicos de sua área ou setor. - O município contribuir para melhorar as condições de vida da população.	- Realizar ações e serviços da competência da prefeitura, visando promover o desenvolvimento e a inclusão sociais da população da sua área geográfica.
Organização do trabalho	- Equipes especializadas para planejar, realizar e avaliar ações e serviços específicos, com objetivos, metas e indicadores setoriais.	- Equipes intersectoriais para identificar necessidades e demandas da população, planejar, orientar e avaliar ações integradas, com a definição de objetivos, metas e indicadores de qualidade de vida. Equipes especializadas para realizar serviços.

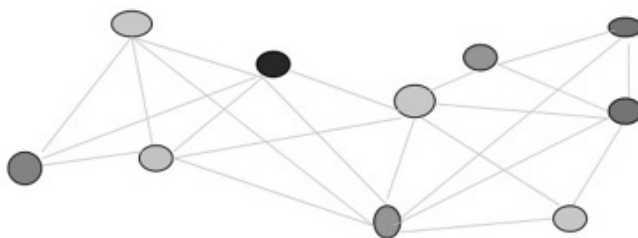
FONTE: Adaptado de Inojosa (1998, p. 42)

Veja o que Comerlatto et al. (2007, p. 268) aponta sobre a intersectorialidade: “A ação intersectorial se efetiva nas ações coletivas. Porém, a construção da intersectorialidade se dá como um processo, já que envolve a articulação de distintos setores sociais possibilitando a descoberta de caminhos para a ação”.

Comerlatto et al. (2007) vai além explicando que a ação intersectorial se efetiva nas ações coletivas e para que esse processo funcione, precisa a articulação de diversos setores sociais, “instituições e pessoas para articular saberes e experiências, estabelecendo um conjunto de relações, construindo uma rede” (JUNQUEIRA; INOJOSA; KOMATSU, 1997). Veja a definição de rede:

FIGURA 2 - DEFINIÇÃO DE REDE

O QUE SÃO AS REDES?
CONEXÕES ENTRE PESSOAS E/OU ORGANIZAÇÕES QUE SE
TECEM A PARTIR DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS
MOBILIZADAS POR UMA IDÉIA-FORÇA, ARTICULADA
EM FUNÇÃO DE UM OBJETIVO COMUM.



FONTE: Disponível em: <<http://goo.gl/cFnIQ1>>. Acesso em: 24 maio 2016.

Para Carvalho (1995, p. 10) “o conceito de rede se apresenta como elemento estratégico na administração dos negócios e no fazer público e se dá em nível municipal ou do microterritório que, de alguma forma, atuam para garantir a proteção e o desenvolvimento social e podem ser divididas em tipologias”.

Veja as tipologias de rede propostas por Comerlatto et al. (2007, p. 269):

- primeira tipologia são as redes sociais espontâneas (nascem do núcleo familiar ampliado: grupos de vizinhanças, clubes, igrejas e são marcadas pela reciprocidade, cooperação, solidariedade, afetividade e interdependência); segunda tipologia são as redes de serviços sociocomunitários (extensão das redes sociais espontâneas e atendem demandas mais coletivas no espaço local e são identificadas por estabelecer relações cidadãs e solidárias na produção de um bem comum); terceira tipologia são as redes sócias movimentalistas (redes nascidas na comunidade, na sociedade, considerando-se como movimentos sociais de defesa de direitos, de vigilância e lutas por melhores índices de qualidade de vida); quarta tipologia é a rede privada (oferece serviços mais especializados e de cobertura ampla e costumam ser estendidas: convênios, possibilitando-lhes outras opções de atendimento, que não somente aquelas ofertadas pelo estado); quinta tipologia são as que reúnem as redes setoriais públicas (aquelas que prestam serviços de natureza específica e especializada, resultantes das obrigações e dos deveres do estado para com seus cidadãos).

Para finalizar e complementar o conteúdo sobre a intersectorialidade, veja no quadro a seguir, os eixos de atuação que a compõem.

QUADRO 11 - EIXOS DE ATUAÇÃO QUE COMPÕEM A INTEGRALIDADE

1	Estabelecer parcerias intersectoriais, interinstitucionais e com entidades Não governamentais e da sociedade civil, visando: • fomentar o estabelecimento de políticas públicas integradas em favor da qualidade de vida; • incentivar a participação social no processo de decisão e gestão das políticas públicas em saúde; • reforçar o papel e a importância do controle social; • fortalecer processos de corresponsabilização na produção da saúde.
2	Monitorar políticas públicas ligadas aos diversos setores que causem impacto na saúde dos sujeitos e coletivos.
3	Subsidiar a construção e elaborar regulações e normas que visem à produção e melhoria da qualidade de vida.
4	Estimular, fortalecer e subsidiar a criação de redes de apoio social que trabalhem pela autonomia de sujeitos e coletivos.

FONTE: Adaptado de Campos, Barros e Castro (2004, p. 749)

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você viu que:

- As ações de saúde são práticas sociais e trazem as influências do relacionamento dos grupos sociais.
- As principais práticas sociais da saúde englobam a promoção, proteção, recuperação e reabilitação.
- A prevenção originou-se da saúde pública e foi organizada em três níveis (prevenção primária, secundária e terciária).
- As ações preventivas podem ser definidas como intervenções orientadas, reduzindo a incidência e prevalência das doenças.
- A epidemiologia age no controle da transmissão de doenças infecciosas, na redução do risco de doenças degenerativas e até em recomendações normativas de mudanças de costumes e comportamentos.
- A promoção da saúde constitui-se integração entre os diversos setores do governo municipal, estadual e federal.
- O SUS possui diversos programas e projeto de prevenção e promoção da saúde e outras iniciativas que fazem parte da Promoção da Saúde são os que envolvem os municípios saudáveis, vigilância ambiental em saúde, melhoria sanitária domiciliar etc.
- Uma das propostas do PPS é a ideia do “Movimento cidades saudáveis”. Um município saudável é aquele em que todos os envolvidos (autoridades, instituições, organizações públicas e privadas, empresários, trabalhadores e a sociedade) dedicam constantes esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da população.
- Alguns eixos de atuação da saúde são a intersetorialidade e integralidade.
- A integralidade seria em primeiro momento um atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- Para a assistência de forma integrada, cada usuário deverá ser acompanhado segundo determinado projeto terapêutico instituído, comandado por um processo de trabalho cuidador.

- A ação intersetorial se efetiva nas ações coletivas.
- A construção da intersetorialidade se dá como um processo, já que envolve a articulação de distintos setores sociais possibilitando a descoberta de caminhos para a ação.



1 Com relação aos três níveis de prevenção, assinale V para verdadeiro e F para falso sobre suas características:

- a) () Prevenção primária são medidas antes do desenvolvimento da doença.
- b) () Na prevenção secundária acontece a recuperação da doença.
- c) () Prevenção secundária ocorre após a identificação dos fatores de risco.
- d) () Prevenção terciária ocorre durante a doença, mas não reabilita, apenas ensina a conviver com ela.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – V – V – F.
- b) () V – F – F – F.
- c) () V – F – V – V.
- d) () V – F – F – V.

2 Podemos dizer que são práticas sociais da saúde, EXCETO:

- a) () Promoção.
- b) () Proteção.
- c) () Conversação.
- d) () Recuperação.

3 A saúde aproxima o campo na com as ciências e ao fazê-lo, colocam como elementos significativos do campo “a superação do dominante, da naturalização da vida social, da sua submissão à e da sua dependência ao modelo médico”. (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998, p. 310).

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a citação acima:

- a) () social, coletiva, saúde, humanas, biologismo, clínica, hegemônico
- b) () clínica, social, coletiva, saúde, humanas, biologismo, hegemônico
- c) () coletiva, humanas, social, clínica, saúde, biologismo, hegemônico
- d) () coletiva, social, saúde, humanas, biologismo, clínica, hegemônico

4 Conforme seus estudos, a prevenção pode ser individual ou coletiva. Sobre as características da prevenção, analise a sentença a seguir:

A prevenção é importante em atitudes individuais, para nos proteger contra as doenças como medidas preventivas de usar camisinha, vacinar-se, alimentar-se bem, usar cinto de segurança, não tomar sol depois das dez da manhã etc.

- a) () A primeira é uma afirmação verdadeira e a segunda, falsa.
- b) () Ambas afirmações são falsas.
- c) () As duas são verdadeiras, mas não tem relação entre si.
- d) () As duas são verdadeiras e a segunda é complemento e justificativa da primeira.

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO VERBAL EM SAÚDE

1 INTRODUÇÃO

A articulação entre Educação e Comunicação no âmbito da Saúde vem há alguns anos no meio científico levantando questões de como ocorre essa relação. Primeiro, acreditamos ser a Educação uma prática necessariamente transformadora, na qual os indivíduos e/ou o grupo constituem-se como sujeitos numa relação de troca (DONATO; ROSENBERG, 2003, p. 19). E, como ninguém aprende de uma forma isolada, a comunicação entra como um fundamento educacional nessa relação de troca entre as partes (educador e educando, entre o educando e o conhecimento (cultura) e também entre o educando e os demais educandos).

Neste tópico, você entenderá mais um eixo de ação da saúde, a educação e a comunicação verbal em saúde, que engloba os envolvidos no processo da comunicação que pelas diretrizes 2014 do Ministério da Saúde, permeia a atenção à saúde, a gestão em saúde e a educação em saúde.

Este tópico será dividido em dois itens. No primeiro, “Educação em Saúde”, apresentaremos suas características e formas de atuação na mudança de hábitos que favoreçam a manutenção da saúde, levando ao desenvolvimento da consciência crítica do indivíduo e conseqüentemente da comunidade. No segundo item será discutida a comunicação verbal em Saúde (com pacientes, integrantes das equipes de saúde e comunidade) apresentando que a comunicação verbal tendo como base o modelo biopsicossocial, envolvendo a comunicação com a equipe de saúde, familiares etc.

2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Educação em Saúde tem como base, ações dirigidas sobre o conhecimento das pessoas (conhecimentos em saúde para a população), para que ocorra intervenção sobre suas próprias vidas, mudanças comportamentais através da transferência de conhecimentos, sendo que essas ações foram iniciadas no século XX, voltadas à incorporação de hábitos higiênicos pela população de maneira totalmente impositiva pelas autoridades sanitárias (RODRIGUES; SANTOS, 2010). Atualmente um aspecto da política de gestão de serviços é a Educação Permanente em Saúde (EPS), “na qual a qualificação dos processos

de trabalho em saúde se dá a partir da problematização do cenário de práticas, tendo como objetivos a resolutividade, integralidade e humanização da atenção”. (CAVALCANTI; PADILHA, 2014, p. 171).

Educar em saúde é compreender os problemas de determinada comunidade e tentar levar consciência desses problemas buscando soluções, baseada no diálogo, na troca de experiências, havendo uma ligação entre o saber científico e o saber popular (VASCONCELOS, 1997). Programas de Educação em Saúde são importantes, pois levam ao conhecimento e uma atitude mais participativa nas ações educativas, conseguindo progressos nas suas condições de saúde e qualidade de vida (HILGER; ABEGG; PRETTO, 1999). Veja no quadro a seguir os eixos de atuação que compõem a educação em saúde.

QUADRO 12 - EIXOS DE ATUAÇÃO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO EM SAÚDE

1	Estabelecer parceria com os meios de comunicação de modo a veicular conteúdos informativos e educativos em saúde.
2	Investir em redes de educação popular, visando: • divulgar conteúdos informativos e educativos em saúde; • fortalecer os saberes e as práticas desenvolvidos pelas comunidades para melhoria da qualidade de vida; • estimular a construção compartilhada de estratégias de promoção da saúde.
3	Investir em metodologias de educação a distância voltadas para a formação dos profissionais de saúde dentro da perspectiva promocional de modo a facilitar o processo de reorganização da atenção e da gestão dos serviços de saúde no sentido da autonomia, integralidade, intersetorialidade e participação social.
4	Pesquisar as ações da promoção da saúde de modo a construir estratégias com crescente efetividade e eficácia.
5	Sistematizar, consolidar e divulgar informações e evidências no campo da promoção da saúde.

FONTE: Adaptado de Campos, Barros e Castro (2004, p. 749)

Segundo Kawamoto, Santos e Mattos (2009), nós podemos usar a educação em saúde como um instrumento importante por possibilitar o acesso às informações e assim proporcionar conhecimentos necessários à mudança de hábitos que favoreçam a manutenção da saúde, levando ao desenvolvimento da consciência crítica do indivíduo e consequentemente da comunidade.

A seguir, caro acadêmico, estaremos lendo sobre a educação da saúde bucal. A escolha desse exemplo se deu pelo fato dessa estratégia de promoção da saúde abordar com ações simples, como por exemplo, ir às escolas e ensinar às crianças a importância do ato de escovar os dentes, uma grande diferença social. Existem vários outros programas de educação em saúde que foram abordados no

Tópico 2, quando falamos sobre promoção da saúde, realizados pelo Ministério da Saúde. Para não ficar repetitivo, iremos nos aprofundar em dois deles: a educação em saúde bucal e o programa de combate ao tabagismo.

Exemplo de programas em Educação em saúde nº 1: Política Nacional de Saúde Bucal

Até meados de 1970, no campo da saúde bucal, a maioria das ações coletivas eram realizadas esporadicamente, como por exemplo, a semana dos bons dentes e em instituições de saúde mais bem estruturadas, buscava-se adotar como alicerce de um único procedimento de prevenção, por exemplo: ou a fluoração das águas de abastecimento público ou a realização de bochechos fluorados semanais (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 2004).

Mas a partir de 1989, a Divisão Nacional de Saúde Bucal, órgão da Secretaria Nacional e a Coordenadoria de Supervisão e auditoria de Odontologia do Inamps organizaram, a Política Nacional de Saúde Bucal para causar ações contínuas, com a intenção de incorporar progressivamente, ações de promoção e proteção em saúde, como fluoretação das águas de abastecimento, educação em saúde, higiene bucal supervisionada e aplicações tópicas de flúor (ALMEIDA; FERREIRA, 2000).

Como uma prática social que se volta ao coletivo, a educação em saúde bucal, busca ampliar a ação dos métodos de promoção da saúde bucal no ambiente público, com algumas medidas preventivas de combate à cárie, a doença periodontal, a higiene bucal, a fluoração e alimentação não cariogênica como medidas eficazes para fazer frente aos problemas bucais (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 2004). Essas ações conjecturam a necessidade de saúde bucal da população que, há anos, possui um modelo de saúde bucal assinalado como de limitada capacidade de resposta, impotente para interferir na prevalência das doenças bucais, individualista, de baixo impacto social e desconexo da epidemiologia nacional (FARIAS; MOURA, 2003).

É preciso perceber que a Saúde Bucal “é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, transporte, lazer, acesso aos serviços de saúde e à informação” (EMMI; BARROSO, 2008, p. 37). “Quem adoece, adoece como um todo, ou seja, uma cárie, uma dor de dente, repercute na boca, no corpo, na alma, na vida” (SANTOS; ASSIS, 2006, p. 55).

Uma das maneiras de se visualizar a eficácia de uma estratégia de promoção da saúde, é fazendo uma análise crítica da prática, além do cunho teórico. Veja estudos de campo no quadro a seguir, realizados com escolares que mostraram que a educação em saúde bucal foi efetiva.

QUADRO 13 - ESTUDO DE CAMPO DE PROGRAMAS VOLTADOS A PRÁTICAS EDUCATIVAS

Estudo/ referência	Sujeitos/ Idade (anos)/ sexo	Análise	Resultados
Aquilante et al. (2003)	44 crianças de pré-escola (18 a 27 anos)	Programa odontológico com bases educativa, preventiva e curativa. Cinco aulas de 15 em 15 dias utilizando material didático: macromodelos, cartazes, fantoches, gincanas e audiovisuais.	↑ 16% no nível de conhecimento sobre saúde ↓ 15,5% no índice médio de placa
Milori et al. (1994)	90 crianças (7 a 9 anos) ambos os sexos Ensino Fundamental.	G1 = aula sobre placa dentária bacteriana e inflamação gingival, aplicação tópica de flúor gel e escovação dentária supervisionada a cada 15 dias; G2 = educação sanitária, apoiada em palestras pontuais, orientações fundamentadas em normas de conduta; G3 = aplicação tópica de flúor gel e escovação supervisionada a cada 15 dias.	Comparando os resultados dos índices de gengivite e placa bacteriana obtidos após oito meses = G1 seguidos do G2 foram os mais beneficiados pelos programas propostos, mostrando que promoção deve ser aliado à educação.
Garcia et al. (1998)	682 escolares (ambos sexos) (7 e 12 anos) (1ª à 4ª séries do Primário) (escolas públicas de Araraquara/SP)	- 15 dias do programa, com palavras-chave no contexto da saúde bucal. - Programação, apoiada na avaliação neolingüística das informações, valorizou o trabalho com os sentidos: visual, auditivo e cenestésico. - Três modelos de práticas informativas: palestras, para estimular os sentidos visual e auditivo; atividade clínica de educação e higiene bucal, cujo principal estímulo foi o cenestésico e tátil-motor, além do estímulo auditivo e visual; e utilização de recurso (o Robô-Dente).	O sistema foi bem-aceito, e dentre as palavras-chave, as relativas ao método de escovação apresentaram um alto porcentual de citações.

FONTE: A autora

Exemplo de programas em Educação em saúde nº 2: Política Nacional de Controle do Tabagismo

“A OMS considera o tabagismo como um grande problema de saúde pública, devendo ser tratado como uma pandemia, responsável por cerca de cinco milhões de mortes (quatro milhões em homens e um milhão em mulheres) por ano em todo o mundo” (ANS, 2009, p. 46). Veja no quadro a seguir, as estratégias utilizadas pela ANS, nesse programa de controle do Tabagismo.

QUADRO 14 - EXEMPLO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DO TABAGISMO

Aspectos	Estratégias
População-alvo	- Todos os indivíduos tabagistas, independentemente da faixa etária. - Indivíduos tabagistas pertencentes a uma determinada faixa etária e/ ou grupos e situações especiais. - Indivíduos tabagistas que possuam doenças que tenham o fumo como importante fator de risco.
Formas de identificação da população-alvo	- Questionário sobre o perfil de saúde e doença. - Faixa etária. - Grupos e situações especiais (gestantes, nutrízes, adolescentes, indivíduos com doenças cardiovasculares etc.).
Tratamento para cessação de fumar	- Aconselhamento telefônico reativo para deixar de fumar.
Variáveis e indicadores para monitoramento e avaliação	- Número de consultas ao Disque pare de fumar (monitoramento mensal). - Número de beneficiários que pararam de fumar após o tratamento reativo. - Número de beneficiários que pararam de fumar após o tratamento ativo. - Proporção de beneficiários que pararam de fumar após contato com o Disque-pare de fumar. Número total de beneficiários que entraram em contato com o Disque-pare de fumar no período de avaliação) etc.
Ações complementares de divulgação e estímulo para adesão do beneficiário ao programa	- Comemoração de datas pontuais » Dia Mundial sem Tabaco: 31 de maio. - Dia Nacional de Combate ao Fumo: 29 de agosto. - Inserir tabagismo em outras datas comemorativas. - Realizar atividades comemorativas. - Elaborar e distribuir materiais educativos.

FONTE: Adaptado de (ANS, 2009, p. 46-51)

Caro acadêmico, agora que você viu a importância de se aliar a educação à saúde, em dois programas de educação e promoção da saúde, vamos ver que essa relação depende de uma comunicação entre as partes envolvidas nesse processo.

3 COMUNICAÇÃO VERBAL EM SAÚDE (COM PACIENTES, INTEGRANTES DAS EQUIPES DE SAÚDE E COMUNIDADE)

A palavra comunicar origina-se no latim *comunicare* (SILVA, 2009). A qualidade da comunicação depende “da compreensão do que queremos trocar com as pessoas, o que queremos colocar em comum, qual a nossa capacidade de trocar com o outro, qual o nível de troca que somos capazes de fazer com alguém que está precisando de ajuda, da disponibilidade e do conhecimento de alguém que se dispõe a ser um profissional de saúde” (SILVA, 2009, p. 76).

Assim, caro acadêmico, uma boa definição para comunicação em saúde seria Teixeira (2004b p. 37): “Comunicação em saúde diz respeito ao estudo e utilização de estratégias de comunicação para informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem a sua saúde”.

Segundo Silva (2009, p. 77) o conteúdo da comunicação está:

[...] ligado ao nosso referencial de cultura, e o profissional de saúde tem uma cultura própria, diferente do leigo, por isso é importante saber que quanto mais informações possuímos sobre aquela pessoa e quanto maior a nossa habilidade em correlacionar esse saber do outro com o nosso, melhor será o nosso desempenho no aspecto da informação e do conteúdo. Portanto a autora aponta que toda comunicação, tem duas partes a primeira é o conteúdo, o fato, a informação que queremos transmitir e a segunda seria o que estamos sentindo quando nos comunicamos com a pessoa (empatia).

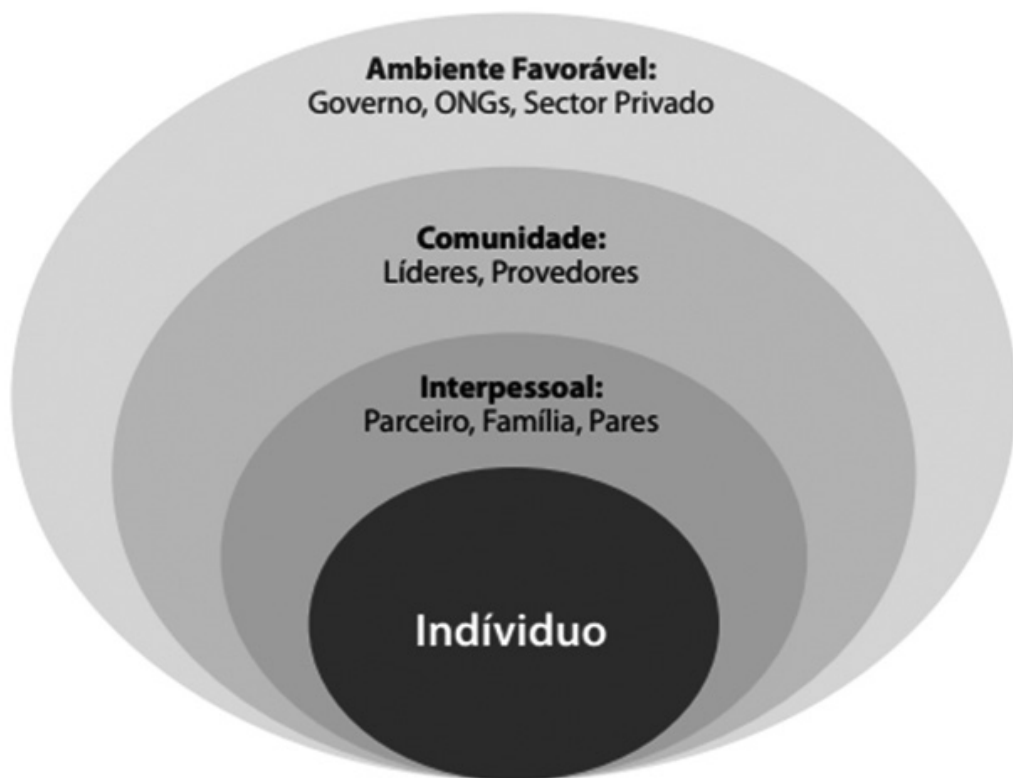
Veja, caro acadêmico, a importância dos processos de comunicação em saúde em seu caráter transversal, central e estratégico, segundo Teixeira (2004b, p. 616); transversal (diversas áreas e contextos de saúde, quer nos serviços de saúde como na comunidade); central (relação que os técnicos de saúde estabelecem com os usuários no quadro da prestação dos cuidados de saúde; estratégico (relacionado com a satisfação dos usuários).

Teixeira (2004b, p. 616) aponta também que a comunicação em saúde tem influência tanto individual como comunitária:

Individual (ajuda a tomar consciência das ameaças para a saúde, pode influenciar a motivação para a mudança que visa reduzir os riscos, reforça atitudes favoráveis aos comportamentos protetores da saúde e pode ajudar a adequar a utilização dos serviços e recursos de saúde) e comunitariamente (pode promover mudanças positivas nos ambientes socioeconômicos e físicos, melhorar a acessibilidade dos serviços de saúde e facilitar a adoção de normas que contribuam positivamente para a saúde e a qualidade de vida).

A comunicação existe em vários níveis, desde o individual até o coletivo. Engloba também a comunicação entre os profissionais, os gestores e as comunidades, sistema público, entre outros. Assim, a comunicação seria o alicerce das nossas relações interpessoais, do cuidado, tornando-se um instrumento de significância humanizadora. Veja na figura a seguir, os níveis que compõem a comunicação verbal.

FIGURA 3 - NÍVEIS DE COMUNICAÇÃO



FONTE: Disponível em: <https://www.fphighimpactpractices.org/sites/fphips/files/hip_comunicacao_em_saude_brief.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2016.

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você viu que:

- Educação em Saúde visa aprimorar o conhecimento das pessoas para que ocorra intervenção nas suas próprias vidas, mudanças comportamentais.
- Educar em saúde é compreender os problemas de determinada comunidade.
- Educação em saúde busca o diálogo, a troca de experiências, havendo uma ligação entre o saber científico e o saber popular para solucionar os problemas de saúde.
- Programas de Educação em Saúde são importantes, pois levam a maior informação e uma atitude mais participativa nas ações educativas, obtendo melhorias nas suas condições de saúde e qualidade de vida.
- Podemos usar a educação em saúde como um instrumento importante por possibilitar o acesso às informações e assim proporcionar conhecimentos necessários à mudança de hábitos que favoreçam a manutenção da saúde.
- A palavra comunicar origina-se no latim *comunicare*.
- Comunicação pressupõe o entendimento das partes envolvidas, que não existe entendimento se não houver, anteriormente, a compreensão.
- A qualidade da comunicação depende da compreensão do que queremos trocar com as pessoas, o que queremos colocar em comum, qual a nossa capacidade de trocar com o outro.
- O conteúdo da nossa comunicação está intimamente ligado ao nosso referencial de cultura.
- O profissional de saúde tem uma cultura própria, por isso é importante saber que quanto mais informações possuímos sobre aquela pessoa e quanto maior a nossa habilidade em correlacionar esse saber do outro com o nosso, melhor será o nosso desempenho no aspecto da informação e do conteúdo.
- Toda comunicação tem duas partes, que são o conteúdo, o fato, a informação que queremos transmitir e o que estamos sentindo quando nos comunicamos com a pessoa.

- Os processos de comunicação em saúde possuem caráter transversal, central e estratégico.
- A comunicação em saúde tem influência tanto individual como comunitária.



1 Com relação à educação em saúde, assinale V para verdadeiro e F para falso sobre suas características:

- a) () Educação em Saúde tem como base ações dirigidas sobre o conhecimento das pessoas (conhecimentos em saúde para a população).
- b) () Educar em saúde é compreender os problemas de determinada comunidade e tentar levar consciência desses problemas buscando soluções, baseada no diálogo.
- c) () Programas de Educação em Saúde são importantes, pois levam a maior informação e uma atitude mais participativa nas ações educativas.
- d) () Estabelecer parceria com os meios de comunicação de modo a veicular conteúdos informativos e educativos em saúde não é um dos eixos da educação em saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – V – V – F.
- b) () V – F – F – F.
- c) () V – F – V – V.
- d) () V – F – F – V.

2 Podemos dizer que a educação em saúde tem como eixos, investir, EXCETO:

- a) () Em redes de educação popular.
- b) () Em metodologias de educação a distância.
- c) () Na não divulgação de conteúdos informativos e educativos em saúde.
- d) () Na parceria com os meios de comunicação.

3 A qualidade dadepende “da do que queremos trocar com as pessoas, o que queremos colocar em, qual a nossa de estar trocando com o outro, qual o nível de troca que somos capazes de fazer com alguém que está de ajuda, da disponibilidade e do de alguém que se dispõe a ser umde saúde”. (SILVA, 2009, p. 76).

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a citação acima:

- a) () compreensão, comunicação, comum, capacidade, precisando, conhecimento, profissional.
- b) () comunicação, compreensão, comum, capacidade, precisando, conhecimento, profissional.

- c) () comunicação, capacidade, compreensão, comum, precisando, conhecimento, profissional.
- d) () comunicação, compreensão, conhecimento, comum, capacidade, precisando, profissional.

4 Conforme seus estudos, o acolhimento é uma etapa da humanização em saúde. Sobre as características do acolhimento, analise as sentenças a seguir:

I- O acolhimento passa a ser uma ferramenta, ou uma fase do atendimento nos serviços de saúde

que vêm ganhando importância

II - Como um arranjo tecnológico que busca garantir acesso aos usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () A primeira é uma afirmação verdadeira e a segunda, falsa.
- b) () Ambas afirmações são falsas.
- c) () As duas são verdadeiras, mas não têm relação entre si.
- d) () As duas são verdadeiras e a segunda é complemento e justificativa da primeira.

BASES LEGAIS E HISTÓRICAS DO SUS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade você deverá ser capaz de:

- conhecer todos os processos e movimentos que culminaram na formulação do SUS;
- saber a importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde para o SUS;
- visualizar e entender que a saúde é direito de todos e que esse direito está assegurado na Constituição Federal do Brasil;
- conhecer as leis que foram criadas a partir do SUS e como foi implantado o SUS;
- entender seus princípios e diretrizes tema de suma importância para concursos;
- compreender os pactos pela saúde;
- compreender os modelos assistenciais, Programa Nacional de Imunizações (PNI) e Plano Municipal de Saúde;
- entender a criação do Programa de Saúde da Família e Estratégia da Saúde da Família;
- compreender a divisão da equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família;
- entender a diferença entre as modalidades de atendimento domiciliar.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em três tópicos. Em cada um deles, você encontrará atividades que o ajudarão a fixar os conhecimentos abordados.

TÓPICO 1 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO SUS

TÓPICO 2 – MODELOS ASSISTENCIAIS, PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÓPICO 3 – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO SUS

1 INTRODUÇÃO

Uma das grandes conquistas das políticas públicas de saúde foi o Sistema Único de Saúde (SUS) resultante das mediações dos movimentos idealistas, sociedade e governos. O SUS é um sistema estruturado em serviços e ações de saúde que reúne diversas organizações públicas de saúde, contemplando todas as regiões do país, em nível nacional, estadual e municipal.

O SUS é fruto de uma árdua luta da segunda reforma sanitária, iniciada na década de 1970 e vigente até os dias atuais. Recordando que a primeira reforma sanitária ocorreu na época da República Velha, período entre 1889 até 1930, e dela surgiu o Sistema Nacional de Saúde, como uma esperança de transformação de um modelo de assistência médica que assistia somente os trabalhadores que exerciam atividade remunerada e seus dependentes, medicina previdenciária, para assim, assumir um modelo de assistência à saúde acessível a todos, independentemente de estar ou não trabalhando.

Neste tópico vamos estudar a história do SUS. Entenderemos toda sua trajetória, a luta, os ideais, a formulação, alguns fatos marcantes da trajetória de um importante nome para criação do SUS, Sérgio Arouca, a sua concretização, a partir da 8ª conferência nacional de saúde, a relevância para a criação do SUS, seu desenvolvimento e estratégias, alguns dos princípios e diretrizes, bem como a percepção de alguns desacertos e os pactos pela saúde. Assim, compreenderemos como foi a remodelação da saúde de uma sociedade que clamou por mudanças efetivas e seu maior feito foi a conquista de saúde como direito de cidadania.

2 FORMULAÇÃO DO SUS (CRIAÇÃO DO SUS EM 1988 E A SAÚDE COMO DIREITOS DE TODOS E DEVER DO ESTADO)

A saúde que antecedeu a criação do SUS era baseada na assistência médica especializada e hospitalar conveniada (Caixas de Aposentadoria e Pensão – CAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensão – IAP, Instituto Nacional de Previdência Social – INPS e Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS). Esses convênios eram limitados aos trabalhadores que cumpriam atividade remunerada, sendo estendida no final do período da Ditadura Militar

aos trabalhadores rurais. Estes moldes de atenção à saúde foram centrados na doença e em procedimentos, sendo de baixa qualidade e alto custo, conspirando para a falência do INAMPS posteriormente (CHIACHIO, 2011).

A saúde dos anos 80 viveu uma situação de intrínseca crise econômica, completamente estagnada no crescimento e com uma inflação gigantesca, onde o Estado articulava-se com as empresas privadas, mantendo a saúde nesta mesma linha. Ao assumir o cargo de presidente, José Sarney começou a redirecionar o país para fora dos resquícios das amarras da ditadura e traçar novos caminhos para o desenvolvimento político, econômico e social, e assim ocorreram grandes mudanças no setor da saúde, como a criação do SUS (CHIORO; SCAFT, 1999).



Aprofundaremos a seguir nosso estudo sobre o SUS.

Ao iniciarmos nosso estudo, caro acadêmico, e obtermos um entendimento satisfatório do processo de formulação do SUS, falaremos sobre a trajetória de um dos principais líderes e idealizadores do modelo de atenção à saúde no Brasil, e um dos fundadores do SUS, Antônio Sérgio da Silva Arouca, teórico que escreveu vários artigos, livros e sua tese de doutorado, intitulada “O dilema preventivista: contribuição para a compreensão e crítica da medicina preventiva”. Como você já pôde ter percebido, Arouca foi citado desde a Unidade 1, pois foi atuante para as conquistas de melhorias da saúde no país (AROUCA, 1975).

2.1 ALGUNS FATOS MARCANTES DA TRAJETÓRIA DE SÉRGIO AROUCA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUS

Para desvendarmos o que se passou na história da criação do SUS, iniciamos com Sérgio Arouca, militante nato, que concluiu seu curso de medicina em 1966, na cidade de Ribeirão Preto, formando-se médico sanitário e foi professor do departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade de Campinas (UNICAMP), fez doutorado em Medicina pela UNICAMP, tornando-se doutor em Saúde Pública, fundou o Centro de Medicina Comunitária em Paulínea (SP), cidade que residia ligado à Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, Centro esse que foi referência futuramente para a implantação do SUS (PRODOC 914 BRA, 2005).

Arouca foi perseguido pela ditadura, impedido de defender sua tese de doutorado, o que faz somente no ano seguinte. Participou da fundação do Centro

Brasileiro de Estudos da Saúde – CEBES que realizavam muitos debates, mesas-redondas para discutir os problemas da saúde. Nessa época, em 1978, chegou ao Brasil, para um debate, o italiano Giovanni Berlinguer, médico e político que trouxe informações sobre o andamento da Reforma Sanitária Italiana, o que muito contribuiu para a fomentação da Reforma Sanitária Brasileira (PRODOC 914 BRA, 2005).

Em 1979, Arouca chega à presidência do CEBES, sendo o núcleo do CEBES reconhecido pela sua atuação parlamentar e o resultado disso é o 1º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, quando discutiram e produziram um documento importante chamado “A questão democrática na área da Saúde” (PRODOC 914 BRA, 2005). Em 1980, muda-se para Nicarágua e torna-se consultor da Pan-Americana de Saúde (OPAS), trabalhando na reorganização do sistema de saúde do país. De volta em 1982, assume o departamento de Administração e Planejamento em saúde da Fiocruz, tornando-se presidente dessa, em 1985 (PRODOC 914 BRA, 2005).

Em 1986, assume a função de consultor da Organização Mundial da saúde (OMS), conduz a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), sendo um grande momento, pois é a primeira vez nessa conferência que há participação de utentes do serviço de saúde brasileiro. Em 1987, assume como secretário Estadual da Saúde, atua até o começo de 1988 quando deixa a administração estadual. Ainda em 1988, trabalha como representante da sociedade civil, participando diretamente na construção do capítulo sobre Saúde na Constituição Federal, fazendo valer as propostas idealizadas na 8ª CNS, aprovando-as pela Assembleia Nacional Constituinte, assegurando com isso, a partir da reforma sanitária, a formulação do SUS (PRODOC 914 BRA, 2005).

Em 1990 elege-se deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), atuando ativamente na Secretária Municipal de saúde e na secretária se gestão Participativa do Ministério da Saúde. Em 1991, assume a vice-presidência do PCB e em 1992 é um dos fundadores do Partido Popular Socialista (PPS), votando a favor do *impeachment* de Fernando Collor. Em 1994 é reeleito deputado federal e integra a Comissão de Seguridade Social e Família (PRODOC 914 BRA, 2005).

Nos anos seguintes, Arouca continuou atuante na política, tentou seu terceiro mandato, mas sem êxito; foi convidado pelo, na época, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para assumir a Secretária Municipal de Saúde em 2001; em 2002 coordenou o programa de saúde de Ciro Gomes do PPS. No ano seguinte, 2003, assumiu a coordenação geral de 12ª Conferência Nacional de Saúde e foi nomeado novamente para ser representante do Brasil na OMS, e no segundo semestre deste mesmo ano, morreu, vítima de câncer, aos 61 anos, sendo homenageado e por reconhecimento por lutar a vida inteira por melhores condições de saúde. A 12ª CNS passou a se chamar Conferência Sérgio Arouca (PRODOC 914 BRA, 2005).

Podemos concluir, caro acadêmico, nesta breve retrospectiva da carreira de Sérgio Arouca, que sua participação extremamente atuante foi de suma

importância para a Saúde Coletiva. Foi construída passo a passo, entre derrotas e vitórias, movimentando e organizando a sociedade civil, para que pudessem opinar como usuários das condições de saúde, contribuindo para a formulação política e implantação do SUS (TAMBELLINI, 2009). Compreendemos que seu legado não foi em vão, não mediu esforços na luta para alcançar sua utopia de transformar a saúde do país em uma saúde de qualidade, colaborando para assegurar a saúde como direito para todos e dever do Estado na nova Constituinte Federal (TAMBELLINI, 2009).

Leia a frase de Sérgio Arouca, na 8ª Conferência Nacional de Saúde (FIOCRUZ, 1998, s.p.):

É momento de pensar quais são as possibilidades reais e concretas que nós temos de mudar o sistema de saúde hoje no Brasil. [...] esse é o porquê da conferência. [...] assim ela nasce: no instante em que a discussão sobre a formulação do sistema de saúde no Brasil infelizmente quase foi tratada como uma simples reforma administrativa.

Essa, entre outras frases, caro acadêmico, proferidas na 8ª CNS, por Sérgio Arouca, fomentaram, juntamente com representantes de todos os seguimentos da sociedade civil, debater sobre um novo modelo de saúde para o Brasil, e a partir de agora estamos aptos para conhecer a trajetória histórica da formulação e criação do SUS (FIOCRUZ, 1998).

2.2 CRIAÇÃO DO SUS E A 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

Como vimos até agora, as articulações, idealizações e esboços para a criação de um novo modelo de assistência à saúde brasileira tiveram seus primórdios embasados na trajetória da reforma sanitária nos meados da década de oitenta. Essa década foi de grandes acontecimentos e inovações para a saúde do Brasil. No ano de 1985, o regime militar chega ao fim com a eleição indireta de José Sarney, desfazendo-se alguns arranjos políticos autoritários, e os caminhos para retomar a democracia são ampliados, mesmo com dificuldades por estar enfrentando uma crise econômica, onde a hiperinflação impedia crescimento do país, o Congresso Nacional, começa a elaboração de uma nova Constituição (PAIVA; TEIXEIRA, 2014).

Diante destas circunstâncias, a sociedade e seus líderes continuavam sua luta, até o acontecimento da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, onde foi possível pleitear e aprovar características essenciais oriundas da reforma sanitária, assim como, desenhar as bases do SUS. Formando inicialmente um Sistema Unificado e Descentralização denominado (SUDS) e posteriormente criado o SUS, que buscava traçar estratégias que iriam permear os recursos entre as organizações de saúde federais, estaduais e municipais (PAIM et al., 2011).

Da mesma forma, as deliberações conquistadas ainda na 8ª CNS desencadearam mudanças administrativas importantes que evoluíram para construção do SUS, entre as principais foram: conceder robustez para as competências da área da saúde; ampliar a abrangência de assistência para a população e um dos maiores ideais, realizar a junção da saúde pública e da medicina previdenciária, transformando-as em um sistema único (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). Essa conferência é considerada um marco histórico na formulação do SUS, por ter viabilizado debates, decisões e um aprofundamento dos ideais até então defendidos pelo movimento sanitário, que futuramente culminou na criação do SUS e concepção de suas leis. Sua relevância ganhou maiores proporções por ter sido a primeira conferência em que estavam presentes mais de cinco mil representantes de diferenciados setores da sociedade brasileira e que puderam expressar seus pensamentos e saberes, servindo como base para as discussões na Assembleia Nacional Constituinte, que mais tarde ficou garantido a saúde como direito na Constituição Federativa Brasileira (PAIM, 2008). As principais questões reivindicadas e discutidas nessa conferência para a transformação da saúde no país, segundo Paim (2008) foram: direito de saúde para todos os cidadãos; instituir dever do Estado; prover saúde para todos e reestruturação e unificação do sistema nacional de saúde.

Convencidos de que os objetivos da 8ª CNS foram alcançados, caro acadêmico, podemos fixar nosso aprendizado reforçando que, a partir da inquietação produzida pela reorganização setorial da saúde defendida pela reforma sanitária, juntamente com a população civil e seus líderes, sem influência de partidos, governo ou instituições internacionais foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS (PAIM et al., 2011). Como podemos constatar, acadêmico, o texto que segue é um recorte da Constituição Federativa do Brasil de 1988 (2016, p. 74), que expressa o princípio fundamental da política de saúde brasileira e organização do SUS: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ainda jubilosos com tamanha conquista, os defensores da saúde tinham pela frente um grande desafio, colocar em prática o tão almejado e planejado sistema único de saúde que propunha agilidade, organização preventiva e curativa, atenção ampla e coletiva, descentralização da gestão, prestação dos serviços de saúde, e participação da população. Sendo esses os seus objetivos básicos, o SUS foi pautado nos princípios da Universalidade, Integralidade e Participação Social (PAIM et al., 2011).

Como podemos observar neste outro artigo da Constituição Federativa do Brasil de 1988 (2016, p. 74), em que diz:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.

2.3 IMPLANTAÇÃO DO SUS

Diante da constatação da criação do SUS, as ações seguintes foram para realizar a sua implantação, desenvolvida de maneira gradual, lenta e longa. A sua organização primária foi baseada nos modelos de instituições sanitárias já definidas, bem como na área da saúde pública como na medicina previdenciária, que traziam aspectos autoritários, centrais, baseado em troca de favores, interesses políticos e reprovação da participação da população na gestão. Evidenciado isso, o que preponderou nesse momento foi o paradigma curativista centrado na figura do médico e do hospital, e somente aos poucos a implantação do SUS teve início, em função da resistência ao novo, a deixar o tradicional, ao peso da continuidade cultural histórica, sendo então marcada por muitas dificuldades de execução, a implantação do SUS seguiu a partir da descentralização (VASCONCELOS; PASCHE, 2006).

Sua estruturação decorre com o sistema unificado e descentralizado de saúde – SUDS, em julho 1987, gerido pelo INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), uma espécie de convênio firmado entre os governos estaduais, ministério da saúde e o INAMPS (prestava assistência médico hospitalar aos segurados do INPS e seus dependentes) (BRASIL, 1990). O INAMPS foi regulamentado pelo decreto nº 99.060, de março de 1990 (INAMPS – uma autarquia criada pelo art. 3º da Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977, que passou a ser vinculada ao Ministério da Saúde) (BRASIL, 1990).

O SUDS baseou-se nos princípios da reforma sanitária, em que os principais eram: universalização, integralidade, regionalização e hierarquização, descentralização, democratização das instâncias gestoras. Mas o SUDS sofre com as pressões e crise política que enfrentavam na época, não conseguindo dissolver os métodos de estadualização e municipalização da saúde, com isso o INAMPS perde força, juntamente com o SUDS, em função de astutos erros bem mais inclinados para uma tentativa de restauração administrativa do que propriamente uma transformação no sistema de saúde, sendo assim, chegam ao fim o INAMPS e o SUDS (CHIORO; SCAFT, 1999).

Enquanto isso, a Assembleia Nacional Constituinte trabalha para regulamentar a criação do SUS, a constituição de 1988 integra os princípios, definições e o novo método de organização da reforma sanitária, e no período de 1989/90 elaboram e aprovam as Leis Orgânicas da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e a Lei nº 8.142, de dezembro de 1990. Esta ação fortalece e fundamenta a criação do SUS, e assim estava oficialmente fundado e regulamentado o Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 1990).

Juntamente com formulação dessas leis, outras leis também foram elaboradas, como as Leis Orgânicas Municipais, que permitiam aos municípios implantar o Sistema Único de Saúde. Mas sua regulamentação foi palco de grandes dificuldades, entraves e morosidades em função de obstinadas disputas

de poder político e inúmeros interesses do setor privado, que não mediam esforços para procrastinar inserção desse novo modelo de assistência à saúde, até vetos de pontos estratégicos foram determinados pelo presidente Fernando Collor e aprovados no Congresso Nacional, que protelaram e interferiram na implantação do SUS (CHIORO; SCAFT, 1999).

Em resposta, o movimento da saúde se articula e conseguem concordância entre os partidos do Congresso Nacional e o Governo, regulamentando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que institui a participação social e a criação de um Fundo Nacional para a saúde, recursos federais que seriam distribuídos entre os estados e municípios que administrariam na saúde conforme suas necessidades (BRASIL, 1990).



Caro acadêmico, não é o foco do nosso aprendizado o aprofundamento nas leis orgânicas do SUS, mas sugiro uma leitura atenta nas duas principais leis, a Lei nº 8080 e a Lei nº 8142, que são de muita relevância para a saúde brasileira, e requisitadas nos concursos públicos. Você pode encontrá-las nos *links* a seguir:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>.

Não se esgota aqui a implantação do SUS. Como já vimos, ela acontece de maneira vagarosa, acompanhando os fatos políticos da época e encontrando muitas dificuldades pela frente. A partir de agora vamos aprofundar nosso estudo e entender as características de alguns princípios e diretrizes do SUS.

3 SUS: CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Depois de viajarmos no passado conhecendo a trajetória histórica e conceitual do Sistema Único de Saúde, é pertinente indagar a você, caro acadêmico, o que é o SUS? Defini-lo? Quais são seus princípios, no que estão pautadas suas diretrizes? Pois bem, essas são perguntas bem específicas e que geram algumas dúvidas, que foram surgindo ao longo de nossa caminhada e podem ser suas dúvidas também. Sendo assim, vamos respondê-las juntos enquanto vamos entendendo tudo o que envolve esse sistema único de atenção à saúde.

Então para responder à questão, vamos ler a definição estabelecida por Vasconcelos e Pasche (2006, p. 531), sobre o SUS:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em ação os princípios e diretrizes desta política. Compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e ações de saúde, e aglutina o conjunto das organizações públicas de saúde existente nos âmbitos municipal, estadual e nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram funcionalmente para a prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar, quando contratados ou conveniados para tal fim.

O SUS pode ser entendido por uma rede de responsabilidades que coordenam e unificam movimentos de prevenção, promoção e reabilitação da saúde, não é simplesmente um programa de prestação de serviços assistenciais (VASCONCELOS; PASCHE, 2006). O Ministério da Saúde tem o SUS como:

Uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, [...] que segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sendo de responsabilidade das três esferas autônomas de governo federal, estadual e municipal, é um sistema, um conjunto de unidades, de serviços e ações que integram para um fim comum. Referindo-se às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990, p. 4).

Vamos agora, caro acadêmico, desvendar como funciona toda a estruturação do SUS, no que ele está embasado, quais doutrinas, diretrizes e princípios que segue. Segundo o Ministério da Saúde (1990) os princípios do SUS são subdivididos em: doutrinários (universalidade, integralidade e equidade); organizacionais (regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização e participação dos cidadãos). Ademais, entendemos que o SUS está disposto em um conjunto de princípios e diretrizes ideológicas que conferem legitimidade, estão divididos em princípios doutrinários, são os princípios que pautam esse sistema e nos princípios organizacionais, que como o próprio nome revela, são as diretrizes, as bases de estruturação, e para tanto, tomaremos ciência de cada um deles a partir de agora, compreendendo como funciona.

3.1 UNIVERSALIDADE

Os princípios doutrinários que vamos ver a seguir estão inseridos dentro da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, no art. 7º, que tratam dos princípios e diretrizes, exercidas nas ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados conveniados ou contratados pelo SUS. A universalidade refere-se ao acesso, abrangência geral, todos têm direito à cidadania, tendo o Estado como provedor, o que significa dizer que todos os cidadãos têm o direito à saúde acessível a todos os serviços em todos os níveis de assistência. Saúde independente da cor, sexo, raça, religião, opção sexual, local de moradia, trabalho, renda, classe social, ou qualquer outro aspecto pessoal ou social, todos, absolutamente todos os indivíduos tem o direito de acesso à saúde (BRASIL, 1990).

3.2 INTEGRALIDADE

A integralidade como um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde deve ser entendida como ter à disposição um serviço completo, pleno, que contemple todas as suas necessidades no momento que precisar (CHIORO; SCAFT, 1999). É uma assistência à saúde que compreenda um conjunto de ações e serviços que sejam de caráter preventivo e curativo, que atendam aos individuais e os coletivos em todos os níveis de complexidade do sistema único de saúde (BRASIL, 1990).

O princípio da integralidade quer que o indivíduo seja atendido dentro de uma visão global, que ações de prestação de serviço enxerguem o indivíduo como um ser humano que além do corpo físico, está inserido numa sociedade, tem uma fisiologia funcionando e sentimentos psicológicos que também podem adoecer. O indivíduo não deve ser tratado como apenas mais um coração ou pulmão que necessita de tratamento, mas sim como um indivíduo que de maneira geral pode estar enfermo. É nesse sentido que a integralidade foi pensada para ser um dos pilares para exercidos nas ações e serviços do SUS (CHIORO; SCAFT, 1999).

E para garantir a integralidade é necessário que algumas ações e práticas sociais de saúde sejam estimuladas, como: a promoção, proteção e recuperação da saúde como já vimos na Unidade 1, Tópico 2, isso tudo configura uma prestação de serviço de atenção integral (CHIORO; SCAFT, 1999). Esta diretriz do Sistema Único de Saúde talvez seja um dos maiores desafios que o SUS enfrenta, por estar ligado diretamente ao tratamento com o ser humano, dentro de todos os níveis de atenção à saúde, sendo eles os primários, secundários e terciários e que depende de total compromisso dos profissionais que estão nas unidades de prestação de serviços e que tem o dever de tratar cada indivíduo como um ser único, exercendo uma assistência integral (SOUZA; COSTA, 2010).

3.3 EQUIDADE

O intuito desse princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde é fomentar diminuição das desigualdades, certos que todos nós não somos iguais, e para tanto temos necessidades diversas, o que significa dizer que a equidade dentro dos serviços do SUS é tratar os desiguais dentro de suas desigualdades (CHIORO e SCAFT, 1999). O princípio da equidade é baseado na seguinte lógica:

Regiões com condições piores de saúde requerem mais investimentos do que aquelas mais estruturadas; pessoas mais carentes merecem ser tratadas com prioridade no SUS; usuários de saúde com situações clínicas mais graves devem ser atendidos mais rapidamente que aqueles com situações clínicas mais leves (BRASIL, 1990, s.p.).

Para explicar melhor o que é tratar os desiguais e suas desigualdades, entendamos que todo e qualquer serviço de saúde prestados dentro do SUS, deve considerar que cada população, região, classe social, tem seus problemas específicos, com diferentes culturas e maneiras de viver e que a partir dessas diferenças, ocorrem dissemelhantes tipos de doenças e adoecidos. E exercer equidade nas prestações de serviço do SUS é estar preparado enfrentar tais diferenças de modo que todos os indivíduos consigam sanar satisfatoriamente suas necessidades (CHIORO; SCAFT, 1999).

3.4 REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO

Cabe ressaltar que esses princípios e diretrizes organizacionais constituem parte da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estão presentes no art. 7º e art. 8º, e são também denominados de princípios estratégicos (BRASIL, 1990). Ademais, entendemos que a rede de prestação de serviços do SUS abrange todos os âmbitos nacionais: federal, estadual e municipal. Neste contexto, está inserido o princípio de regionalização e hierarquização, onde a rede de serviços é estruturada de forma regional obedecendo a uma hierarquização. E de que maneira isso acontece? É o que iremos descobrir na sequência (CHIORO; SCAFT, 1999).

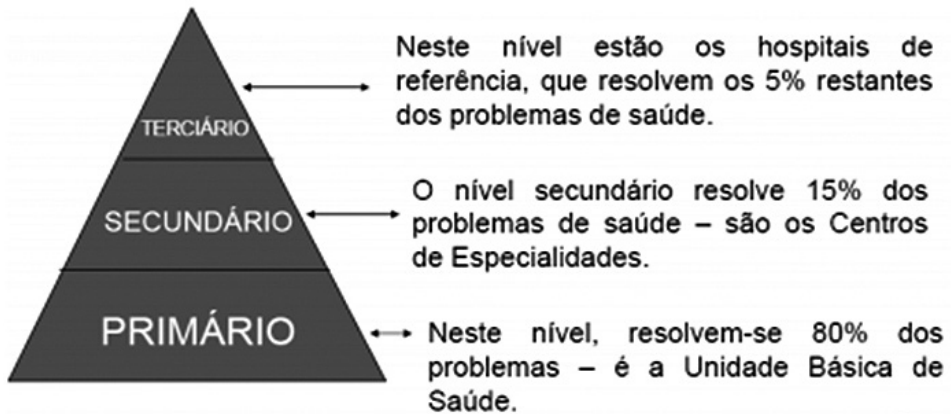
Este princípio de regionalização e hierarquização dos serviços nos concede uma noção de como o SUS é estruturado dentro do sistema, na construção institucional, como as unidades de atendimentos funcionam elas com elas mesmas e interagindo com a população e orientando o processo de descentralização das ações de saúde. A regionalização é a demarcação da localização territorial de uma unidade para o sistema de saúde, que são baseadas nas acomodações político-administrativas do país, que integra todas as organizações e subdivisões das ações de saúde, compreende a distribuição das unidades de saúde de acordo com as necessidades de cada região do país (TEIXEIRA, 2011).

Outro princípio de organização vinculado à regionalização é a hierarquização direcionada para os serviços, é o que se refere à organização das unidades, estruturando-as de forma simples ou complexas, no quesito tecnológico. São organizadas redes hierarquizadas, obedecendo aos níveis crescentes de complexidade dos serviços na rede de atendimento, e possibilitando acesso a essa complexidade que o caso exige, dentro dos limites dos recursos disponíveis em cada região. Um exemplo de unidade simples são as unidades de bairro que disponibilizam apenas consultas médicas e unidades mais complexas são as unidades de emergência e urgências que podem assegurar um atendimento mais específico e grave (TEIXEIRA, 2011).

As ações de serviços das unidades regionalizadas e hierarquizadas proporcionam um serviço que está estruturado em graduados estágios de

dificuldades, apoiados em aparatos tecnológicos de última geração, localizados e delimitados por região, conhecendo as especificidades da população local, possibilitando acesso e recursos. Estas ações de serviços das unidades estão dentro de hierarquias em nível primário, secundário e terciário, veja na figura a seguir estas subdivisões para suas necessidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).

FIGURA 4 - DEMONSTRAÇÃO DA HIERARQUIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE



FONTE: Disponível em: <https://www.enfconcursos.com/uploads/slides/2015/05/slides_1431988487555a690724664.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2016.

3.5 RESOLUBILIDADE

O princípio da resolubilidade está pautado única e exclusivamente na capacidade de a rede de prestação de serviço estar apta, capaz de resolver tal problema, seja de cunho individual ou coletivo. O que se espera é possuir um nível de competência que cumpra com seu papel e resolva, solucione de forma satisfatória tal necessidade. E para isso deve possibilitar cursos de atualizações para a sua equipe de profissionais e estar certo de que exercerão suas capacidades e competências assim que forem requisitadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).

3.6 DESCENTRALIZAÇÃO

O princípio da descentralização é compreendido como o remanejamento das responsabilidades que envolvem as ações e serviços de assistência à saúde pelas várias instâncias do governo, com o objetivo de diminuir a margens de erro de decisões, tendo em vista que é mais acertado administrar e gerenciar unidade do mesmo nível hierárquico do que ter que recorrer a aprovações de outros níveis. Um exemplo prático é o seguinte: O que é de incumbência do municipal deve ser resolvido no município, o que é de competência estadual deve ficar de responsabilidade do Estado e o que é dever federal deverá ser de responsabilidade federal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).

A descentralização em descrição, como política de saúde, passa por uma remodelação político-administrativa de gestão, ocorrendo uma delegação de poder, onde os serviços municipais são geridos pela Secretária Municipal de Saúde, os serviços de nível estadual ficam por conta da Secretaria Estadual de Saúde e os serviços federais são de responsabilidade do Ministério de Saúde, tendo cada instância recursos financeiros, humanos e materiais próprios para geri-lo (TEIXEIRA, 2011).

3.7 PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS

Este princípio assegura, constitucionalmente, a participação efetiva da população, por meio de representante, participar e opinar na formulação de políticas de saúde em todas as instâncias, nacional, estadual e municipal. E ainda a participação pode ser também realizada interagindo com os Conselhos de saúde, profissionais de saúde e prestadores de serviço, participação em conferências de saúde, periódicas e linhas de ações para a saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).

Caro acadêmico, estas doutrinas e diretrizes que acabamos de estudar fazem parte da implantação do SUS. Como vimos até agora, a saúde brasileira evoluiu muito desde seus primórdios, conquistou direitos, teve uma organização, não tem mais a obrigatoriedade de apenas ter a opção da saúde privada. Com o SUS todos tem direito e acesso à saúde. Existem sim muitos desafios a serem enfrentados até que todas as suas doutrinas e diretrizes sejam efetivadas em sua totalidade, mas temos que valorizar todos os avanços conquistados com o auxílio da ciência e tecnologia, capacitação dos recursos humanos e desenvolvimento da atenção básica que foi a área que o SUS mais se desenvolveu nesses últimos vinte anos de sua existência (PAIM et al., 2011).

Na ciência de tantos conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde, tão bem organizado e regulamentado, sabendo que é dever do Estado prover saúde, mesmo assim pode ocorrer uma indagação: e o financiamento do SUS? Como acontece esse custeio? Quais são as receitas destinadas para o Sistema Único de Saúde? O financiamento do SUS é suprido a partir de fontes de receitas estatais, com contribuições de orçamentos sociais, federal, estaduais e municipais, por meio de impostos gerais, contribuições sociais, a partir de programas específicos, e também por algumas fontes privadas. E até mesmo recursos oriundos da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, a antiga CPMF, lembram? Mas como todos sabemos que a receita destinada a saúde não é suficiente e está muito longe da ideal (PAIM et al., 2011).

Ainda no entendimento da implantação do SUS, cabe ressaltar que dentro deste contexto, a dissertarmos sobre um segmento de uma das diretrizes que muito se desenvolveu dentro do sistema brasileiro de atenção à saúde, que foi a hierarquização no setor da atenção básica, atenção primária. Este segmento é o que mais se evidenciou no SUS, porque ela trabalha no intuito efetivar o acesso

universal, fomentar a descentralização, oferecendo maior área de abrangência dos serviços disponíveis, principalmente os mais complexos, incorporando ações de prevenção de enfermidades e promoção da saúde (PAIM, et al., 2011).

Neste sentido foram desenvolvidas algumas estratégias governamentais para a realização desses objetivos, remodelando o SUS, enfatizando uma reorientação da assistencial ambulatorial e domiciliar, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS (BRASIL, 2001). O PACS foi desenhado em 1990 e instituído e regulamentado em 1997, com a consolidação da descentralização do SUS. E esse programa é considerado uma estratégia transitória para outro programa, o Programa Saúde da Família, o PSF, que será assunto no Tópico 2 (BRASIL, 2001).

O objetivo maior do PACS era auxiliar na reorganização dos serviços de saúde municipais, integrando profissionais, a população e as unidades de saúde. O serviço era realizado por pessoas escolhidas dentro da própria comunidade, justamente por ter amplo conhecimento daquele meio, e assim estava criado um novo cargo, o de Agente Comunitário de Saúde (ACS), e para assumi-lo era preciso passar no processo seletivo e para tanto preencher tais requisitos: ser maior de 18 anos, residir na comunidade pelo menos há dois anos, saber ler e escrever e ter disponibilidade de tempo integral. Uma vez selecionado, o agente receberia um salário mínimo, pago pela prefeitura municipal, com recursos oriundos das três esferas nacionais (BRASIL, 2001).

Caberia ao ACS atender em torno de 750 pessoas, conforme as necessidades de cada região, com visitas de pelo menos uma vez mensal, identificar algum risco de saúde, pesar e medir as crianças menores de dois anos, incentivar o aleitamento materno, acompanhar a vacinação das crianças e gestantes, identificar gestantes e encaminhá-las ao pré-natal, orientar sobre métodos de planejamento familiar e a prevenção de doenças, promoção à saúde com atividades educativas individuais e coletivas em domicílios dentro da comunidade, com supervisão (BRASIL, 2001).

Dentre todas as tarefas do ACS compreende: Cadastramento/diagnóstico, mapeamento, identificação de microáreas de risco, realização de visitas domiciliares, ações coletivas e ações intersetoriais. Sendo que o PACS foi devidamente legislado, dispondo de normas operacionais e portaria que fundamentava o programa. (BRASIL, 2001).



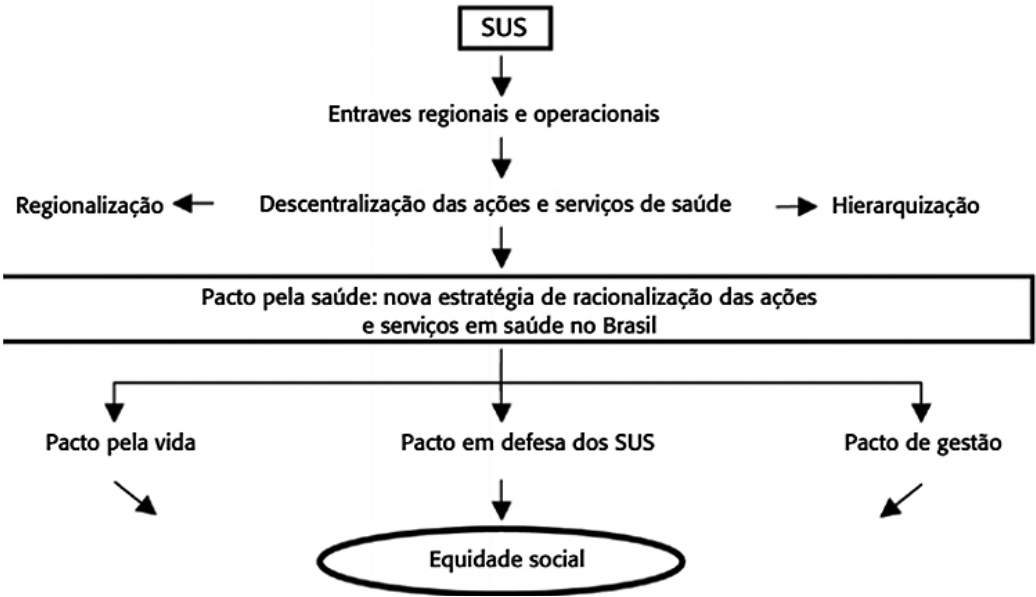
Caro acadêmico! Não se esgota aqui o estudo sobre as estratégias de reestruturação do SUS. Você ainda verá sobre o PSF no Tópico 2 desta mesma Unidade 2 do nosso caderno. Agora conheceremos como funciona o Pacto pela Saúde.

4 PACTOS PELA SAÚDE

Confirmando o que vimos anteriormente, a implantação e a concretização do Sistema Único de Saúde sofreram intensa lentidão, enfrentando várias dificuldades, como por exemplo, a desintegração das políticas e programas de saúde, a falta de maestria da gestão e do manejo social, assim como as deficiências da sistematização, tão bem traçada nas diretrizes (SOUZA; COSTA, 2010). Essas não conseguiram atingir uma organização de rede regionalizada e hierarquizada que efetivassem as ações e serviços de saúde, somadas aos problemas das competências em realizar a integração entre as redes estatais e municipais que comprometem as bases da universalidade e integralidade tornando-se sem dúvida, desafios contínuos no SUS, que podemos dizer, vive em divergência do que idealizado e regulamentado com a realidade da prática diária (SOUZA; COSTA, 2010).

Diante da constatação de que o Sistema Único de Saúde era passível de limitações e problematizações e que necessitava de mudanças e reformulações estratégicas, em 2006, as competências de todas as esferas do âmbito governamental instauraram uma nova medida na tentativa de alavancar e tentar solucionar tais dificuldades, denominado Pactuação de Compromissos pela Saúde, Pacto pela Saúde (PS) regulamentado pela Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006). Na figura a seguir podemos perfeitamente entender que o SUS passava por dificuldades e o porquê dessas estratégias serem criadas, observe.

FIGURA 5 - FLUXOGRAMA DE VIABILIDADE PARA A EQUIDADE DA SAÚDE



FONTE: FADEL et al., 2009, p. 450). Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a08.pdf>>. Acesso: 24 jun. 2016.

Este pacto pela saúde foi desenvolvido para cumprir com a consolidação do SUS e possibilitar equidade para a saúde brasileira, com os seguintes objetivos:

Qualificar e implementar o processo de descentralização, organização e gestão do SUS à luz da evolução o processo de pactuação intergestores; Aprimoramento do processo de pactuação intergestores objetivando a qualificação, o aperfeiçoamento e a definição das responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados no âmbito do SUS; Definição de compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira; Compromisso com [...] o avanço do processo de Reforma Sanitária Brasileira, explicitada na defesa dos princípios do SUS (BRASIL, 2006, s.p.).

Esses objetivos foram divididos em três partes: Pacto pela Vida (PV), Pacto em defesa do SUS (Pdsus) e Pacto de Gestão (PG) (BRASIL, 2006). E a seguir descobriremos o que significa cada um deles.

4.1 PACTO PELA VIDA (PV)

O PV corresponde a uma convenção firmada pelas competências que gerem o SUS para fazer valer as prioridades especificadas no âmbito nacional, estadual e municipal sobre a situação da atenção à saúde brasileira (BRASIL, 2006). As prioridades elencadas e pactuadas compõem seis divisões: saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, diminuição da mortalidade infantil e materna, fortalecimento de capacitação de respostas às doenças emergentes e endemias com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica (BRASIL, 2006).

4.2 PACTO EM DEFESA DO SUS

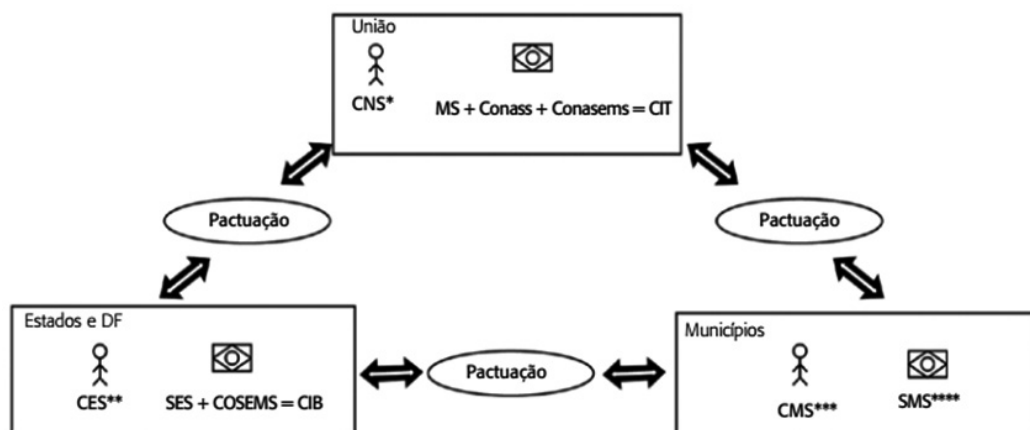
Essa pactuação compromete-se, juntamente com os gestores do SUS, promover ações para qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como uma política pública. Trabalhado para repolitizar a saúde numa perspectiva de enfrentamentos dos desafios atuais projetando acertos para o futuro do SUS, tais como novas modalidades de gestão, ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais em prol da saúde e da cidadania, controle social e transparência no processo de fiscalização, assim como o acolhimento da inserção da população nas tomadas de decisões da saúde (BRASIL, 2006).

4.3 PACTO DE GESTÃO (PG)

Este pacto estrutura “as diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos de descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação na saúde” (BRASIL, 2006, s.p.). O PG vem de encontro às antigas ideologias do já extinto movimento sanitário que pretendia estabelecer a equidade social na saúde brasileira, sendo esta gestão do SUS geridas pelos Conselhos de Saúde e pelo poder Executivo nas estâncias federais, estaduais e municipais (BRASIL, 1990).

Disposto em colegiados de negociação da seguinte maneira: Comissão Intergestores Tripartite (CIT), vinculada à direção nacional do SUS, é responsável pela pactuação e articulação de diretrizes e normas, nas três esferas do governo, União, estados, Distrito Federal e municípios. E a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que representa um espaço de articulação e pactuação para avaliar os termos operacionais do processo de descentralização. Quem faz parte de cada comissão? (FADEL et al., 2009). A CIT atua em pares de representantes na esfera nacional, paritária formada de quinze membros, em que cinco deles indicados pelo Ministério da Saúde (MS), mais cinco pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e ou outros cinco componentes indicados pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). E a CIB da mesma forma paritária na esfera estadual e municipal representada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) (FADEL et al., 2009). Na figura a seguir é possível entender melhor como funciona o pacto de gestão do SUS nas três esferas governamentais, analise.

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DO PACTO DE GESTÃO



MS= Ministério da Saúde; CNS = Conselho Nacional de Saúde; CES = Conselho Estadual de Saúde; CMS = Conselho Municipal de Saúde; CONASS = Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde; CONASEMS = Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde; COSEMS = Conselho de Secretários Municipais de Saúde

FONTE: (FADEL et. al., 2009, p. 453)

O pacto de gestão é “um processo que visa definir as programações de saúde em cada território e nortear a alocação dos recursos financeiros para a saúde a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os gestores” (BRASIL, 2006, s.p.). E segue as seguintes diretrizes:

A flexibilidade no planejamento, respeitando as prioridades fixadas pelos planos de saúde em cada esfera de gestão; a submissão à ordem hierárquica entre as ações básicas e às de maior complexidade; a integração com a programação da vigilância em saúde; a garantia de acesso aos serviços de saúde, subsidiando o processo regulatório da assistência; a avaliação periódica ao desenvolvimento das ações (BRASIL, 2006, s.p.).

Sendo assim, o pacto de gestão foi projetado numa perspectiva de possibilitar melhorias substanciais no acesso e qualidade dos serviços e na tentativa de solucionar os problemas operacionais elencados durante a execução da consolidação do SUS (FADEL et al., 2009).

LEITURA COMPLEMENTAR

Leia parte da lei orgânica dos SUS que define as diretrizes para organização e funcionamento do sistema de saúde brasileiro.



Se quiser visualizar essa lei na íntegra, veja em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>.

Sancionada pelo Presidente da República, Sr. Fernando Collor, e decretada pelo Congresso Nacional, foi publicada no Diário Oficial da União em 20 de setembro de 1990. Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Vigorando em todo o território nacional, para qualquer ação ou serviço de saúde realizado por pessoas ou empresas.

Todos os seres humanos têm direito à prestação dos serviços de saúde básica e de especialidades, sendo esse fornecido pelo Estado. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Entretanto, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Constituem o Sistema Único de Saúde (SUS) as ações e os serviços de saúde de instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e Fundações mantidas pelo Poder Público. Seus objetivos são: I. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; II. a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o dever do Estado de garantir a saúde; III. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Os campos de atuação do SUS, ainda, são: a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, farmacêutica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; a organização de políticas e ações de saneamento básico; sangue e hemoderivados; recursos humanos na saúde; vigilância nutricional; proteção ao meio ambiente; de medicamentos e insumos de interesse; de fiscalização (alimentos, produtos, transporte, guarda); desenvolvimento científico e tecnológico.

Seguem os princípios da universalidade de acesso; integralidade de assistência; preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; igualdade da assistência à saúde; direito à informação divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades; participação da comunidade; descentralização político-administrativa; integração das ações da saúde, meio ambiente e saneamento básico; conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; capacidade de resolução dos serviços de assistência; e organização para evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Os serviços de saúde serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em nível de complexidade crescente. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Essas comissões articulam as seguintes políticas e programas: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador.

São necessárias comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior, cuja finalidade é propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS. Coube a União, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Foram estabelecidos o atendimento domiciliar e a internação domiciliar, que são componentes do SUS, bem como o cumprimento obrigatório da presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

FONTE: Disponível em: <<http://hitechnologies.com.br/humanizacao/o-que-e-o-programa-humanizaus/resumo-da-lei-n8080>>. Acesso em: 24 jun. 2016.

ATIVIDADE PRÁTICA

Mesa Redonda para debater os acontecimentos da implantação do SUS estruturado numa linha do tempo.

Objetivo: Elaborar um material disposto em uma linha do tempo dos acontecimentos da implantação do SUS, trazer os fatos que se destacaram em cada momento, e formar uma mesa redonda na sala de aula para todos debaterem e exporem suas opiniões. **Tempo de duração:** 48 horas. **Material a ser utilizado:** material de pesquisa histórica, biblioteca, livros, apostilas, computador, internet. Cada aluno prepara sua pesquisa para estar apto no debate.

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, vimos:

- Como aconteceu a formulação do SUS nas décadas de 80/90 que marcou a história da saúde brasileira.
- Que o SUS surge como uma possibilidade de transformação na saúde, em meio a uma época que o país ainda vivia as consequências deixadas pela ditadura, a crise era evidente e o desenvolvimento político, econômico e social andava a passos lentos.
- Sérgio Arouca foi consultor da Organização Mundial da saúde (OMS), presidiu a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), sendo um grande momento, pois é a primeira vez que em uma conferência de saúde ocorre há participação de usuários do serviço de saúde brasileiro.
- A criação do SUS em 1988 e a importância que a 8ª Conferência Nacional de Saúde teve para essa conquista.
- 8ª CNS foi um consenso político que possibilitou instituir as idealizações projetadas pela Reforma Sanitária que resultou: em um conceito abrangente de saúde; saúde como direito de cidadania e dever do Estado e na instituição do SUS.
- Toda a longa e complexa implantação do SUS, passando pelas etapas do SUDS, INAMPS até realmente ser compreendida como SUS e regulamentada com as Leis Orgânicas da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e a Lei nº 8.142, de dezembro de 1990.
- O SUS com suas características e alguns de seus principais doutrinas e diretrizes.
- Princípios doutrinários e organizacionais do SUS: universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização e participação dos cidadãos.
- As estratégias dos PACS instituído e regulamentado em 1997, como o objetivo de reorganizar os serviços municipais integrando profissionais, a população e as unidades de saúde.
- Que a implantação e consolidação do SUS passaram por inúmeros entraves, problemas na execução de algumas diretrizes principalmente nos que se referia à universalidade e integralidade, e para tentar solucionar tais dificuldades foi desenvolvido algumas estratégias denominadas Pactos pela Saúde.
- Esse pacto pela saúde foi estruturado em três vertentes: Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão.



- 1 (HU-UFTM/EBSERH/IADES/2013) A organização do sistema de saúde brasileiro apresenta diversos marcos ao longo de sua história, até o estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) como é conhecido hoje. Acerca desse assunto, assinale a alternativa CORRETA.
 - a) O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) tinha como objetivo levar assistência à saúde aos trabalhadores rurais, até então excluídos das ações previdenciárias.
 - b) As Ações Integradas de Saúde (AIS), estabelecidas ao final da década de 1960 do século passado, formaram um movimento assistencial com base nas equipes multiprofissionais de saúde.
 - c) O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) surgiu como uma consolidação das AIS, mas não adotava os princípios da universalidade e da participação popular como pilares importantes do sistema de saúde.
 - d) O SUS tem a equidade como um princípio importante para buscar o equilíbrio entre as disparidades regionais no que diz respeito à saúde.
 - e) A regionalização e a hierarquização são princípios organizativos do SUS que dependem muito da União, e menos dos estados e dos municípios, para a sua implantação.

- 2 (FUNCAB - 2011) Ao longo da década de 1990, identificou-se a evolução de vários modelos de gestão. O avanço na consolidação do Sistema Único de Saúde se verifica no modelo segundo o qual:
 - a) () A gestão do sistema permanece com o Estado.
 - b) () O sistema é organizado com base na hierarquia de ações e serviços de saúde.
 - c) () A gerência das unidades é defendida em parceria pelo gestor estadual e municipal.
 - d) () Os municípios têm sua gestão fragmentada.
 - e) () As unidades de saúde do município não tem papel definido.

- 3 (FUNCAB – 2011) Considere as afirmações a seguir sobre os princípios do Sistema Único de Saúde.
 - I – Universalidade de acesso aos serviços de saúde apenas no nível primário de assistência.
 - II – Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso somente nos níveis de baixa e média complexidade do sistema.

III – Participação da comunidade.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmação III.
- b) Apenas a afirmação II.
- c) Apenas a afirmação I.
- d) As afirmações I e II.

4 (FCC - TRT - 2011) Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, específica em seu Art. 7º que são princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde:

- a) Universalidade do acesso aos serviços, igualdade da assistência à saúde e centralização das decisões no nível federal.
- b) Universalidade do acesso aos serviços, priorização da saúde suplementar e integralidade da assistência.
- c) Universalidade do acesso aos serviços, igualdade da assistência à saúde e integralidade da assistência.
- d) Centralização das decisões no nível federal, igualdade da assistência à saúde e integralidade da assistência.

MODELOS ASSISTENCIAIS, PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico vamos estudar os diversos tipos de modelos assistenciais, em seguida passaremos para o entendimento do Programa Nacional de Imunização (PNI) por ser um programa de relevância internacional e uma das grandes vitórias da saúde brasileira, contribuindo para a redução da morbimortalidade por doenças transmissíveis no país. E por fim, conheceremos o que é o Plano Municipal de Saúde (PMS), entendendo-se como um avanço e desafio, pois estrutura um planejamento de responsabilidades municipais, a saúde de toda uma população.

Este tópico que iniciaremos será dividido em três itens. No primeiro, “Os Modelos Assistenciais de Saúde” apresentaremos os vários modelos existentes e suas características e diferenças explicando um pouco de cada (Modelo Médico Assistencial Privatista, Modelo Sanitarista, Modelos Alternativos e Vigilância em Saúde). No segundo item será discutido o Programa Nacional de Imunização (PNI) detalhando a importância desse programa. E por fim, no último item, conheceremos o Plano Municipal de Saúde, suas bases de formulação, organização e funcionamento.

2 MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE (MODELO MÉDICO ASSISTENCIAL PRIVATISTA, MODELO SANITARISTA, MODELOS ALTERNATIVOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

Ao iniciarmos nosso aprendizado, caro acadêmico, vamos entender alguns conceitos, que facilitarão nossa compreensão dos fatos daqui por diante. Para tanto, vimos que a condição de saúde, como modo geral, avançou em largos passos desde suas primícias, e é fato que no decorrer da sua evolução, vários foram os modelos assistenciais utilizados como forma de organização tecnológica na metodologia de prestação de serviços (ROZENFELD, 2009).

Mas você, acadêmico, deve questionar: O que é um Modelo Assistencial de Saúde? Quais são as diferenças entre os modelos assistenciais? O que é Vigilância da Saúde?

É o que tentaremos responder a seguir:

Um **modelo assistencial de saúde**, segundo Paim (2003), é um agrupamento tecnológico aplicado pela organização dos serviços de saúde em espaços-populações delimitados, associando grupos populacionais, ações sobre o ambiente, equipamentos comunitários e usuários de distintas unidades prestadoras de serviços de saúde de múltiplas complexidades, como por exemplo, hospitais, postos e centros de saúde. É a forma de organização tecnológica do processo de prestação de serviços em saúde (TEIXEIRA et al., 1998).

Modelos assistenciais e/ou modelos de atenções e/ou modos de intervenções em saúde, e/ou modalidades assistenciais e ainda modelos tecnológicos são nomenclaturas destinadas à forma de adequar todas as técnicas e tecnologias a fim de solucionar problemas e assistir as necessidades de saúde individuais e coletivas, são modos de produzir saúde, é uma orientação para as ações de serviço, uma maneira de organização dos meios de trabalho efetuados na prática diária da saúde, uma ordem lógica entre os instrumentos e os saberes na mediação em saúde (PAIM, 2003).

Os serviços, a prestação de atenção de saúde, são compostos basicamente por cinco elementos essenciais, para a reorganização do sistema de serviços de saúde, sendo o foco das intervenções políticas de saúde ao fazer valer uma das diretrizes do SUS, a resolubilidade, assim que os problemas forem elencados. Esses elementos essenciais são os seguintes: Modelo assistencial; Organização de recursos; Infraestrutura dos recursos de saúde (humanos e tecnológicos); Financiamento e por fim, gestão (PAIM, 2003).

O Brasil concentra três tipos de modelos assistenciais que concorrem entre si, e, muitas vezes, se acrescentam, sendo eles: Modelo Médico-Assistencial Privatista, Modelo Assistencial Sanitarista e Modelo Alternativo (TEIXEIRA et al., 1998). O **Modelo Assistencial Privatista** é o mais difundido, conceituado e ainda vigente, utilizado pelos setores público (predominantemente curativo) e privado (medicina liberal, plano de saúde, cooperativa, medicina de grupo), é o modelo mais procurado no Brasil (demanda espontânea), de caráter curativo só exigido quando o indivíduo está doente, não tem uma cobertura integral da população, nem mesmo compromisso com o impacto de qualidade da saúde da população. Os recursos são atribuídos conforme a demanda desordenada. Essa forma de organização de ações da saúde está presente na demanda de uma assistência médico-hospitalar em serviços de urgência, emergência, ambulatorios, centros de saúde, consultórios e clínica (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).

Este modelo assistencial privatista também denominado de modelo médico hegemônico, ou ainda modelo biomédico hegemônico, está estruturado nos seguintes fundamentos: individualismo, saúde e doença como produto, destaque para o biologismo, histórico de prática médica, medicação dos

problemas, medicina curativa, consumismo médico, participação passiva dos consumidores (GIOVANELLA et al., 2012).

Já, caro acadêmico, o **Modelo Assistencial Sanitarista** é modelo que segue a saúde pública tradicional, baseada em campanhas de caráter temporário (vacinação e combate a endemias etc) programas especiais (saúde da criança, saúde da mulher, saúde mental etc), tem uma gestão centralizada, dispõem altos custos, não contempla a totalidade da situação de saúde e também não fomenta a integralidade da atenção à saúde. Este modelo está vinculado ao Ministério da Saúde, passando por diversas instituições como a Fundação de Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SESP, Fundação Nacional de Saúde e atualmente vigente como Vigilância Sanitária, sendo também reproduzidos nos âmbitos estaduais e municipais (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).

Este modelo sanitaria está fundamentado nas teorias bacteriológicas, tecnoassistencialista de campanhista e contínuo verticalista, focado no atendimento das necessidades e como isso passa pelas dificuldades em realizar a promoção e proteção da saúde, assim como a prestação de uma atenção de qualidade, efetiva e de equidade (PAIM, 1999). São exemplos de modelos assistenciais sanitaria que partem de ações planejadas por um determinado período de tempo incluindo educação, ambiente de suporte, recursos humanos e materiais: Ações programáticas de saúde (identificação das necessidades sociais, atividades casuais, objetivo no coletivo, atividades com equipes multiprofissionais); Programas de Saúde da Família (PSF, atividades educativas e prevenção de riscos e agravos); Acolhimento (integração entre cliente e profissional, recepção do usuário, agendamento de consultas e programação de prestação de serviços); vigilância de saúde (fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica, sanitária, nutricional a grupos de risco, saúde do trabalhador, ambiental e assistência médico-ambulatorial e hospitalar); o movimento cidades saudáveis (políticas públicas urbanas visando à melhoria da qualidade vida) e promoção de saúde (melhoria das condições e estilo de vida) (PAIM, 2003).

E o **Modelo Assistencial Alternativos**, caro acadêmico, são modelos que estão em construção ao longo do tempo, desde a primeira tentativa de descentralização da saúde com o SUDS (Sistema Único de Descentralização de Saúde) como já vimos na Unidade 1. Esses modelos alternativos foram experienciados posteriormente em nível municipal, onde incluíram métodos, técnicas e instrumentos originados da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais em saúde (TEIXEIRA et al., 1998).

Dentre os propósitos do Modelo Assistencial Alternativo estão a integralidade da atenção e a diminuição do impacto dos problemas de saúde, dispostos a consolidar os princípios e diretrizes do SUS. Os modelos assistenciais enfrentam árdua rivalidade entre os outros modelos assistenciais vigente no cenário da saúde brasileira, e por estar em contínua construção caminhando

juntamente com a evolução do SUS, almejam concretizar um modelo de atenção à saúde que proporcione efetivamente qualidade de vida para a população. Enquanto esses ideais não se confirmam, os diversos modelos assistenciais da saúde complementam realizando ofertas de serviços e ações programáticos, como podem observar nos exemplos acima (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).

Agora, caro acadêmico, que compreendemos as diferenças entre os modelos assistenciais, iremos entender a Vigilância em Saúde para o SUS. Como sabemos, o SUS está em construção desde sua criação em 1990. Vários sistemas foram implantados para organizar suas ações e colocar em prática seus princípios, pois bem a Vigilância em Saúde é mais um modelo de assistência, inserida normativamente no Pacto pela Saúde que estudamos no Tópico 1. Atua em todos os níveis de atenção da saúde, em que suas equipes de saúde, as atenções primárias, desenvolvem suas habilidades de programação e planejamento, organizando os serviços de ações programadas aumentando o acesso da população nas distintas atividades e ações de saúde (BRASIL, 2010).

Segundo a cartilha de diretrizes da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (2010, p. 16), tem como objetivos:

Observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde das populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Em seu conceito estão: “a vigilância e o controle das doenças transmissíveis (vigilância epidemiológica); a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador, vigilância sanitária, [...] e o cuidado integral coma a saúde das pessoas por meio da promoção da saúde” (BRASIL, 2010, p. 20). A Vigilância em Saúde está inserida na gestão local com um modelo assistencial, participando dos sistemas municipais de saúde, porque antes do SUS e da implementação da NOB (Normas Operacionais Básicas do SUS), número 001/93, os municípios tinham serviços de saúde, mas não tinham autonomia de gerencia das unidades e instituições de prestação de serviços de saúde em seu próprio município (TEIXEIRA et al., 1998).

Veja, no quadro a seguir, alguns dos modelos assistenciais vigentes no SUS e algumas de suas caraterísticas.

QUADRO 15 - MODELOS ASSISTENCIAIS VIGENTES NO SUS E CARATERÍSTICAS

MODELO	SUJEITO/ OBJETO	MEIOS DE TRABALHO	FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
MÉDICO ASSISTENCIAL PRIVATISTA	- Médico Especialização Complementariedade - Doenças, Doentes (clínica e cirurgias)	Tecnologia médica	Rede de serviços de saúde / Hospitais

SANITARISTA	- Médico Sanitarista, Auxiliares - Modos de transmissão - Fatores de risco	Tecnologia Sanitária	Campanhas sanitárias Programas especiais Sistema de Vigilância Epidemiológica e sanitária
ASSISTENCIAIS ALTERNATIVOS e VIGILÂNCIA EM SAÚDE	- Equipes de Saúde e População (cidadãos) - Danos, riscos, necessidade e determinantes do modo de vida e saúde (condições de vida e trabalho)	Tecnologias de comunicação social, de planejamento e programação local e tecnologias médico-sanitárias.	Políticas públicas saudáveis Ações intersetoriais Intervenções específicas (promoção, prevenção e recuperação) Operações sobre problemas e grupos populacionais

FONTE: Adaptado de Rozenfeld (2009)



Caro acadêmico, não se esgota aqui o tema dos modelos assistenciais, você poderá aprofundar seu conhecimento lendo o conteúdo do link: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf>, e a partir de agora, veremos como funciona o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

3 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI)

Este **Programa Nacional de Imunização (PNI)** do SUS foi uma vitória brasileira, com um século de história desde a primeira vacina, o PNI foi criado em 18 de setembro de 1973, com o objetivo de normatizar a imunização em nível nacional. É referência mundial, com quarenta e três anos de excelência comprovada, a partir de resultados e avanços notáveis, foi idealizado por Oswaldo Cruz, um dos fundadores da Saúde pública no país. Com o PNI, foram extintas e/ou mantidas sob controle doenças preveníveis por meio de vacinação (BRASIL, 2003).

Sua trajetória ao longo de mais de quarenta anos consolidou-se com uma significativa intervenção de Saúde Pública de caráter universal, que muito cooperou para a diminuição das morbidades e da mortalidade por doenças transmissíveis (SILVA JUNIOR, 2013). É marcada por ações planejadas e sistematizadas, diversas estratégias, campanhas, varreduras, rotinas e bloqueios que erradicaram doenças perigosas como a febre amarela, varíola, poliomielite, e conseguiram controlar

o sarampo, o tétano neonatal e o acidental, assim como as formas graves da tuberculose, difteria e a coqueluche. Atualmente, o PNI está controlando as infecções ocasionadas pelo *Haemophilus Influenzae* tipo b, da rubéola, a síndrome da rubéola congênita, hepatite B e A, as infecções pneumocócicas, a influenza e suas complicações para os idosos, HPV (BRASIL, 2003).

O PNI tem por finalidade imunizar toda a população, sem fazer nenhuma distinção, cobertura total de vacinação, tendo como meta operacional básica, vacinar 100% das crianças com menos de um ano de idade com todas as vacinas indicadas no calendário básico. São alvos das ações de vacinação do PNI: crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas, sem exceção alguma (BRASIL, 2003).

Ademais, grande parte dos indivíduos ainda pensa que a vacinação é só para crianças, apesar de existirem muitas campanhas de informação sinalizando a relevância de todos manterem atualizadas suas carteiras de vacinação em todas as idades para evitar o retorno de doenças já erradicadas, e muito se investe para que a população tome consciência da importância de acompanhar as campanhas e visitar regularmente as unidades de vacinação espalhadas por todo o país, pois o calendário nacional de vacinação sobre atualizações ano a ano (BRASIL, 2003).

A atualização do PNI é constante, sempre na busca de disponibilizar novos imunobiológicos (vacinas) para fortalecer os mecanismos e estratégias que suportem e aumentem o acesso da população às vacinas preconizadas, principalmente nos grupos vulneráveis, e ainda o PNI é apoiado por instituições acadêmicas que desenvolvem estudos de avaliação sobre o impacto das vacinas na morbimortalidade (doenças e morte), pesquisadores contribuem para avaliar o desempenho das ações de vacinação e conferir evidências científicas no aperfeiçoamento das campanhas e das vacinas (SILVA JÚNIOR, 2013). O PNI, atualmente, trabalha cada vez mais, investindo em pesquisas avançadas para descrever indicadores nacionais de máxima cobertura e homogeneidade para várias vacinas e redução da morbidade e mortalidade por doenças imunopreveníveis, conta com mais de trinta mil salas de vacinação distribuídas por todo o território brasileiro (SILVA JÚNIOR, 2013).



Acadêmico, este foi nosso aprendizado sobre o PNI. A seguir, você encontrará um link que o levará a uma viagem pelos fatos históricos da imunização. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/hcsm/v10s2/a07v10s2.pdf>>. E depois de estudarmos o PNI, agora passaremos para o entendimento do Plano Municipal de Saúde.

4 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

Caro acadêmico, como já vimos anteriormente, antes da criação do SUS, os municípios não tinham direito à autonomia de gestão sobre a saúde. Com a implantação do SUS, isso foi possível, e para gerir identificou-se a necessidade de um instrumento que fornecesse uma visão geral e detalhada da situação da saúde local, assim nasceu o Plano Municipal de Saúde (PMS), que faz parte do sistema de planejamento do SUS, onde cada município elabora suas linhas de gestão de acordo com a sua realidade, obedecendo aos princípios e diretrizes adotadas na legislação básica e dentro das normas do SUS (ORTIGA et al., 2011)

O que se entende por Sistema de Planejamento do SUS? Denominado também por PlanejaSUS, esse sistema compreende uma atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas do SUS, é uma estratégia relevante à efetivação do SUS. Tem por objetivo coordenar o processo de planejamento considerando as diversidades existentes de modo que possa contribuir na resolubilidade e na qualidade da gestão e da atenção à saúde, assim como também formular propostas e pactuar com a diretrizes, propor metodologias e modelos de instrumentos básicos do processo de planejamento, apoiar e participar da avaliação periódica relativa à situação de saúde da população e ao funcionamento do SUS, entre outros (BRASIL, 2009).

A Constituição Federal de 1988 e a Portaria GM nº 3.085, de 1 de dezembro de 2006, regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS) e a Portaria GM nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006, aprova as orientações gerais relativas aos instrumentos do PlanejaSUS (BRASIL, 2009). O objetivo maior do PMS é fazer uma análise situacional da saúde, traçar um perfil epidemiológico da população residente no município e a partir daí, definir suas intenções e perspectivas a serem percorridos pelo município num período de quatro anos. Nestes instrumentos são elencados as metas, objetivos e diretrizes para obter uma gestão de qualidade em saúde municipal. Dentro do PMS, é estruturado uma Programação Anual de Saúde, que auxilia na organização e elaboração de objetivos claros e precisos, deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, elabora uma ata de reunião e encaminhado ao prefeito para esse homologar (ORTIGA et al., 2011). Veja no quadro a seguir, caro acadêmico, um exemplo de PMS da cidade de Florianópolis, SC.

QUADRO 16 - EXEMPLO DE PMS DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC

Ações	Meta	Indicador	Programação				Recursos Orçamentários
			2010	2011	2012	2013	
Exemplo							
Implantar equipes de Programa de Saúde Familiar Bucal (PSFB)	Implantar 04 equipes de PSFB	nº de equipes PSFB/nº de equipes previstas x100	01	01	01	01	R\$ 402,00 incentivo mês (SES) R\$ 15.600 (MS incentivo) R\$ 1.300,00 (MS Mês)

FONTE: Ortiga et al. (2011)

O PMS é a locução da responsabilidade municipal com a saúde da população, integrando política, técnica e economia. É um documento articulado com o Pacto da Saúde que organiza um conjunto de propostas políticas do governo municipal para a área da saúde, um conjunto de ações para solucionar os problemas e as necessidades de saúde do município, seguindo as diretrizes gerais das políticas de saúde no âmbito estatual e nacional (TEIXEIRA, 2001). Após realizar o levantamento com os dados de identificação do município, que são os seguintes:

Apresentação do território, limites, área geográfica, economia, renda; População, estrutura etária, crescimento populacional, pirâmide etária, distribuição segundo área de residência (urbana/rural), índice de envelhecimento, esperança de vida ao nascer, grupos vulneráveis (indígenas, assentados, quilombolas); Educação (nível escolaridade, taxa de analfabetismo, rede de educação); Estrutura Sanitária (abastecimento de água, rede de esgoto, coleta de lixo); Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Recursos Humanos da SMS (ORTIGA et al., 2011).

Com relação à situação de saúde do município, as seguintes condições são analisadas: “Taxa de natalidade; Taxa de mortalidade infantil e materna; Taxa de mortalidade geral e por sexo; Morbidade hospitalar; Morbidade Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Imunizações e Doenças Imunopreveníveis; Série Histórica do Pacto pela Vida” (ORTIGA et al., 2011). No que diz respeito à Atenção Integral à Saúde é preciso verificar toda a estrutura das redes de assistência que o município possui, assim como os serviços de saúde ofertados: Na atenção básica (unidades básicas de saúde, funcionamento, organização, nº de equipes da Estratégia de Saúde em Família (ESF), Núcleos de apoio estruturados; CAPS, Saúde Bucal, humanização do atendimento). Na assistência Ambulatorial Especializada: (Assistência de Fisioterapia; Centros de Referência (oferta e demanda de serviços, resolubilidade); Diagnose; Laboratório Municipal; Serviço de Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Sistema de Informação utilizado no município;

Programas de Saúde (Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Saúde do homem, Saúde de hipertensos e diabéticos); Serviços de referência e contra referência; incorporações tecnológicas). Na Vigilância em Saúde: Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses. Assistência Hospitalar: Hospitais (organização, funcionamento, porte, número leitos destinados ao SUS, disponibilidade de equipamentos) serviços de referência e contra referência. Na Assistência de Urgência e Emergência: Unidade de Pronto Atendimento – UPA; Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) (Organização funcionamento, mecanismos de regulação). Na Assistência Farmacêutica: analisar a organização e a prestação da assistência – medicamentos básicos e excepcionais. (TEIXEIRA, 2001).

E com relação à Gestão de Saúde os itens para ser descritos são os seguintes: planejamento, descentralização/regionalização, financiamento e a participação social (TEIXEIRA, 2001). O próximo passo, caro acadêmico, na elaboração do PMS é identificar quais os problemas de prioridade dentro da realidade de cada município, que devem ser analisados seguindo três bases de orientação: Condições de Saúde da População; Determinantes e Condicionantes de Saúde; e a Gestão de Saúde. A seguir vem o planejamento das ações que são classificadas pelos aspectos: Magnitude, transcendência, vulnerabilidade e custos. Na sequência vem à formulação dos objetivos, diretrizes e metas, imediatamente, seguidos do levantamento da viabilidade e previsão orçamentária do PMS, identificar a disponibilidade de recursos para a continuidade das ações, incluindo as possibilidades políticas (querer político em enfrentar a situação), a possibilidade técnica operacional (recursos técnicos para realizar as ações) e por fim a viabilidade financeira (ORTIGA et al., 2011).

Então, caro acadêmico, vimos que para elaborar o PMS os conselheiros do município devem realizar uma análise situacional, formular os objetivos, diretrizes e metas e certificar-se da viabilidade para aí ser encaminhada ao prefeito para homologação e após execução. E assim, acadêmico, finalizamos o conteúdo do Tópico 2 desta unidade e como sugestão, por que não se esgotam aqui o entendimento do PMS, se você quiser aprofundar seu conhecimento ou se ficou curioso para saber como é o PMS de seu município, você pode entrar na página da prefeitura do seu município e procurar por: “Plano Municipal de Saúde de (nome do município)”.



RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, vimos:

- Os vários modelos assistenciais de saúde existentes no cenário da saúde brasileira e disputa entre eles. Falamos individualmente sobre cada um deles, o Modelo Médico Assistencial Privatista, o Modelo Sanitarista, os Modelos Alternativos e a Vigilância em Saúde.
- O PNI, seus conceitos, organização, relevância na erradicação das doenças transmissíveis e imunopreveníveis, funcionamento, nível de alcance e um pouco de sua trajetória resumidamente.
- O que é um PMS, como é elaborado, quais são os passos a serem seguidos para sua formulação, quais os principais aspectos a serem contemplados e toda a sua sistemática estratégica.



- 1 Entendemos que há vários modelos assistenciais no SUS, quais são:
 - a) () Os modelos assistenciais alternativos, sanitários, médico privatista e vigilância em saúde.
 - b) () Somente a vigilância em saúde.
 - c) () O modelo sanitarista e a vigilância em saúde.
 - d) () Somente o médico privatista.

- 2 Com relação ao Modelo Assistencial Privatista, assinale V para verdadeiro e F para falso sobre suas características: (medicina liberal, plano de saúde, cooperativa, medicina de grupo), é o modelo mais procurado no Brasil (demanda espontânea):
 - a) () Precisa identificar quais os problemas de prioridade dentro da realidade.
 - b) () É o mais difundido, conceituado e ainda vigente, utilizado pelos setores público, predominantemente curativo e privado.
 - c) () Preconiza campanhas sanitárias e programas especiais.
 - d) () Busca identificar os danos, riscos, necessidade e determinantes do modo de vida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – V – V.
 - b) () F – V – F – F.
 - c) () F – V – F – V.
 - d) () V – F – F – V.
-
- 3 Com relação ao Programa Nacional de Imunização – PNI. Assinale a alternativa VERDADEIRA:
 - a) () Sua trajetória ao longo de mais de cinquenta anos consolidou-se com uma significativa intervenção de Saúde Pública.
 - b) () De caráter universal, que muito cooperou para o aumento das morbidades e da mortalidade por doenças transmissíveis.
 - c) () É marcada por ações planejadas e sistematizadas, diversas estratégias, campanhas, varreduras, rotinas e bloqueios que erradicaram doenças perigosas como a febre amarela, varíola, poliomielite, entre outras.
 - d) () Em todos os seus cinquenta anos de existência, o PNI ainda não conseguiu controlar o sarampo, o tétano neonatal e o acidental, assim como as formas graves da tuberculose, difteria e a coqueluche.

4 De acordo com o que você estudou, neste tópico, analise o conceito a seguir:

A Constituição Federal de 1988 e a Portaria GM nº 3.085, de 1 de dezembro de 2006, regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS) e a Portaria GM nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006, aprova as orientações gerais relativas aos instrumentos do PlanejaSUS (BRASIL, 2009).

Essa informação corresponde a qual sigla, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () SUS.
- b) () PNI.
- c) () SMS.
- d) () PMS.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico vamos estudar a Criação do Programa de Saúde da Família (PSF) e a mudança para Estratégia da Saúde da Família (ESF), entendendo sua trajetória como modelo assistencial, além da compreensão da equipe multiprofissional que a compõe e como se dá o trabalho em equipe na ESF. E também compreenderemos o NASF, como um recente processo de construção, a fim de se adequar e produzir resultados em conjunto com a ESF no seu território de ação.

Este tópico será dividido em quatro itens. No primeiro, “Criação do Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia da Saúde da Família (ESF)”, apresentaremos os objetivos que nortearam a criação do PSF e depois a mudança para o ESF. No segundo item será discutida a equipe multiprofissional que compõe o ESF e como se dá esse trabalho em equipe. No terceiro item abordaremos a Política Nacional de Humanização (PNH) e o acolhimento, mostrando que ele se torna um dos modos de atuação da PNH e no último falaremos da assistência domiciliar na ESF entendendo-a como uma forma de instrumentalização dos profissionais para o conhecimento da realidade de vida da população.

2 CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Caro acadêmico, agora que você leu a história dos SUS, suas diretrizes e peculiaridades, vamos entender nesse tópico, o PSF suas características, propostas e principalmente compreendê-lo como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica que veio para contribuir com a construção e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Viana e Dal Poz (2005, p. 226) relembram que: “a implementação do SUS se iniciou nos anos 90, após a criação da Lei Orgânica da Saúde e de várias normas e portarias emitidas pelo Ministério da Saúde, as Normas Operacionais Básicas (NOBs), como instrumentos de regulamentação do sistema” e apontam que com o início da implantação do SUS vários problemas se colocaram para sua operacionalização, dos quais se destacam: “[...] o financiamento das ações de

saúde; a definição clara de funções para os três entes governamentais (federal, estadual e municipal); as formas de articulação público/privado no novo modelo de organização dos serviços; e a resistência do antigo modelo assistencial, baseado na doença e em ações curativas individuais, a uma mudança mais substantiva nas práticas assistenciais”.

O Brasil, acentuado por problemas econômicos e fiscais, levou a construção de um novo modelo assistencial, condizente com os princípios do SUS. Ou seja, em 1992 foi criado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) com a finalidade de reduzir a mortalidade infantil e materna, aumentar a acessibilidade e incrementar as ações de prevenção e promoção da saúde, principalmente, nas Regiões Norte e Nordeste (VIANA; DAL POZ, 2005).

O Ministério da Saúde percebeu a importância dos Agentes nos serviços básicos de saúde a partir da experiência no Ceará com o PACS e, começou a enfocar a família como unidade de ação programática de saúde, não mais somente o indivíduo, mas introduzindo a noção de cobertura por família. “Assim, o Programa de Saúde da Família (PSF) foi concebido a partir de uma reunião nos dias 27 e 28 de dezembro de 1993, em Brasília, DF, sobre o tema ‘Saúde da Família’, convocada pelo gabinete do Ministro da Saúde (MS) Henrique Santillo com apoio do UNICEF”. (ROSA; LABATE, 2005, p. 1030).

Em 1994, o MS lançou o PSF como uma estratégia para reordenação dos serviços da atenção básica com vistas na promoção a saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). Em 1995, o PACS e o PSF foram transferidos para a Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) e em meados de 1999, passaram para a Coordenação da Atenção Básica da Secretaria de Políticas de Saúde (SPS) e neste mesmo ano, o governo federal define as atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS), no Decreto nº 3.189, “estabelecendo que os ACS devem desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade” (BORNSTEIN; STOTZ, 2008, p. 259).

Bornstein e Stotz (2008, p. 260) discorrem sobre a relação entre PACS e PSF:

A partir de 1997, o PACS e o PSF passam a ser prioridades do Plano de Metas do Ministério da Saúde, sendo que em documento de sua Secretaria Executiva, o PACS é considerado uma estratégia transitória para o PSF. Por outro lado, nos documentos oficiais do Ministério da Saúde, o PSF é apresentado como uma estratégia que visa à reorientação do modelo assistencial, substituindo o modelo tradicional de assistência orientado para a cura de doenças e hospitalocêntrico, por um modelo cujas principais características são o enfoque sobre a família a partir de seu ambiente físico e social, como unidade de ação; a adscrição de clientela através da definição de território de abrangência da equipe; estruturação de equipe multiprofissional; a ação preventiva em saúde; a detecção de necessidades da população em vez da ênfase na demanda espontânea; e a atuação intersetorial com vistas à promoção da saúde.

Então, podemos concluir que o PSF foi fundamentado nos princípios da Atenção Primária à Saúde (APS), cujo desafio era concretizar a atenção integral, continuada e resolutiva à saúde da população brasileira, alicerçado nos propósitos de invasão de modelo com garantias de recursos de forma progressiva e ousada, além da ampliação conceitual do âmbito da atenção básica (LEVCOVITZ; GARRIDO, 1996).

“O PSF estimulou a municipalização e a descentralização dos serviços, propiciando que o gerenciamento municipal dos recursos seja realizado de forma mais adequada e resolutiva” (MARTINI, 2000, p. 72). Rompendo a tradição de programas conservadores, sua inovação é a possibilidade de reorganização das atividades através do trabalho em equipe (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários) que atuem dentro de um território definido e com uma população adscrita sendo que cada equipe deve se responsabilizar por no máximo mil famílias ou 4,5 mil pessoas (GIOVANELLA et al., 2009).

Segundo Rosa e Labate (2005, p. 1032), “as equipes de PSF, funcionando adequadamente, são capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, prestando atendimento de bom nível, evitando internações desnecessárias e melhorando a qualidade de vida da população”. Então, entende-se que em sua concepção, o PSF inicialmente tinha como objetivo tornar-se um instrumento de reorganização do sistema de saúde nacional e da municipalização e sua implantação seria apenas em áreas de risco, assim passou então a se chamar Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2013). O PSF então, caro acadêmico, pela Portaria nº 648/06, passou a ser denominado ESF, buscando transcender à lógica do grande número de programas verticalizados em uma tentativa de garantir a integralidade de assistência e a criação de vínculo de compromisso e responsabilidade, compartilhados entre os serviços de saúde e a população, favorecendo a consolidação do SUS (CARVALHO, 2008).



Se você quiser a Portaria nº 648/06 na íntegra, acesse o link: <http://dab.saude.gov.br/docs/legislacao/portaria_648_28_03_2006.pdf>.

“A ESF objetiva a elevada cobertura populacional, a facilidade no acesso e no atendimento integral dos indivíduos em seu contexto familiar” (FERNANDES; BERTOLDI; BARROS, 2009, s.p.), priorizando a “territorialização e a delimitação das áreas de abrangência das equipes, identificando as necessidades e os problemas de saúde da população, o monitoramento das condições de vida e de saúde das coletividades, facilitando a programação e a execução das ações sanitárias”. (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010, p. 92).

Mas, caro acadêmico, a implementação da ESF apresentou como uma das maiores dificuldades, à carência de profissionais para atender a esta nova realidade, desenvolvendo assim, um processo de formação e capacitação permanente de todos os profissionais envolvidos. Segundo Araújo e Rocha (2007, p. 456):

Para que a ESF desencadeie um processo de construção de novas práticas, considera-se imprescindível que os trabalhadores, envolvidos nessa estratégia, articulem uma nova dimensão no desenvolvimento do trabalho em equipe. Faz-se necessária a incorporação não apenas de novos conhecimentos, mas mudança na cultura e no compromisso com a gestão pública, que garanta uma prática pautada nos princípios da promoção da saúde.

Segundo Escorel et al. (2007, p. 165), a ESF traz ao constituir com uma equipe multiprofissional,

mudanças na dimensão organizacional do modelo assistencial, responsável pela atenção à saúde de uma população circunscrita, [...] e institui novos profissionais, a saber, os agentes comunitários de saúde, voltados para a ação comunitária, ampliando a atuação da equipe sobre os determinantes mais gerais do processo saúde-enfermidade.

Veremos a partir de agora as características dos profissionais que integram a equipe multiprofissional e como ocorre o trabalho em equipe na ESF.

3 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E TRABALHO EM EQUIPE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Você sabe, acadêmico, quais profissionais fazem parte da equipe multiprofissional e como se dá esse trabalho em equipe na ESF e as peculiaridades de cada profissão? A importância do trabalho em equipe na ESF (Estratégia Saúde da Família) é ressaltada, principalmente, pelo aspecto de integralidade, que contribui nessa organização e busca uma apreensão ampliada das necessidades de saúde da população atendida (ARAÚJO; ROCHA, 2007).

O trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde-doença baseada na ação interdisciplinar que “pressupõe a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro, ambos sendo transformados para a intervenção na realidade em que estão inseridos”. (ARAÚJO; ROCHA, 2007, p. 456). Segundo Brasil (2008), as equipes de saúde são responsáveis pela atenção integral continuada à saúde de uma população de até 4.000 mil pessoas residentes em seu território de abrangência e devem entre várias tarefas, ser proativas na identificação do processo saúde doença e no reconhecimento de agravos, que devem ser seguidos ao longo do tempo, mediante o cadastramento e acompanhamento contínuo e integral dos usuários e suas famílias (as ações programadas), bem como acolher integralmente as necessidades de uma comunidade definida por limites territoriais (as ações de atenção à demanda espontânea).

Segundo Campos e Wendhausen (2007, p. 273), o profissional em saúde tem grande importância no processo da ESF, pois ele pode:

Atuar como um mediador no momento em que a comunidade levanta seus problemas, dificuldades, reivindicações e prioridades; [...] criar um ambiente propício para que se levantem e defendam as ideias de modo participativo, submetendo-as à crítica da comunidade; [...] estimular a participação comunitária, para não correr o risco de manter a prática do modelo biomédico, centrado na doença, o qual tem se mostrado incapaz de atuar a partir da complexidade do processo saúde-doença, incluindo as várias dimensões (individual, social, econômica e cultural) que o permeiam.

Para Nascimento e Oliveira (2010, p. 93):

As equipes da ESF eram compostas por médicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e equipe de saúde bucal. Seu trabalho focaliza áreas estratégicas de atuação, que incluem a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, da hipertensão arterial e do diabetes *mellitus*, a saúde bucal, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, da mulher e do idoso.

Mas para o alcance de bons resultados no ESF e alcançar a integralidade da atenção e a interdisciplinaridade das ações, tornou-se necessária a presença de outros profissionais de saúde integrando as equipes da ESF. Assim, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) (Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008) “com objetivo de apoiar as equipes da ESF na efetivação da rede de serviços e ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, bem como sua resolubilidade”. (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010, p. 93).

Um NASF deve ser composto por uma equipe, na qual, profissionais de distintas áreas de conhecimento operam em conjunto com os profissionais da ESF (RODRIGUEZ, 2011).

O NASF busca qualificar e complementar o trabalho das equipes de ESF, atuando de forma compartilhada para superar a lógica fragmentada ainda hegemônica no cuidado à saúde, visando à construção de redes de atenção e cuidado e colaborando para que se alcance a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS. (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010, p. 93).

Segundo Nascimento e Oliveira (2010, p. 93):

as áreas estratégicas de atuação das equipes de Saúde da Família do NASF, são: – atividade física e práticas corporais, – práticas integrativas e complementares, – reabilitação, – alimentação e nutrição, – saúde mental, – serviço social, – saúde das crianças, do adolescente e do jovem, – saúde da mulher, – assistência farmacêutica.

Estas nove áreas de atuação das equipes de Saúde da Família do NASF, segundo Rodriguez (2011, p. 263) “são definidas pelos próprios gestores municipais e pelas equipes de ESF, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações sendo necessário no mínimo cinco profissionais”.

O NASF deve atuar dentro de algumas diretrizes relativas à APS, entre estes: ação interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e humanização”. (RODRIGUES, 2011, p. 263).

É constituído por equipes compostas por diversos profissionais de várias áreas de formação, e esses, além do seu conhecimento técnico, têm a responsabilidade por determinado número de equipes de Saúde da Família (ESF) e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à Saúde da Família, compondo o NASF 1 e NASF 2 (LIMA, 2013). Porém, em 20 de setembro de 2010, foi criado o NASF 3, Portaria nº 2.843/GM/MS que visava promover a atenção integral em saúde e saúde mental, prioritariamente para usuários de *crack*, álcool e outras drogas na Atenção Básica para Municípios com porte populacional menor que vinte mil habitantes. Entretanto, em outubro de 2011, acrescentaram-se as competências do NASF e o NASF 3 passou a ser NASF 2.

Veja como são divididos e compostos os NASF 1,2,3 no quadro a seguir:

QUADRO 17 - MODALIDADES DO NASF

Tabela III: Alterações nas modalidades do NASF

	Composto de:	Vinculado:	Profissionais que podem compor o NASF1 ou NASF2
NASF 1	No mínimo 5 profissionais de nível superior de diferentes áreas	Há no mínimo 8 eSF e no máximo 15 eSF.	Assistente Social; Fonoaudiólogo; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; Psicólogo; Médico Acupunturista; Médico Pediatra; Médico Homeopata; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Psiquiatra; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica); Médico do Trabalho; Médico Veterinário; Profissional com formação em Arte e Educação (arte educador)e Profissional de Saúde Sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas.
NASF 2	No mínimo 3 profissionais de nível superior de diferentes áreas	No mínimo a 3 eSF e no máximo 7 eSF.	
NASF 3	Passa a ser NASF 2		

FONTE: Lima (2013, p. 121)

A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do NASF dependem de algumas ferramentas já amplamente testadas na realidade brasileira, como é o caso do Apoio Matricial, da Clínica Ampliada, do Projeto Terapêutico Singular (PTS), do Projeto de Saúde no Território (PST) e a Pactuação do Apoio. (RODRIGUES, 2011, p. 263).

Vamos ver os objetivos e características de cada um deles no quadro a seguir:

QUADRO 18 - FERRAMENTAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DO NASF

	Características
Apoio Matricial ou matriciamento	- Arranjo tecnoassistencial que visa à ampliação da clínica das equipes da ESF, alterando a lógica de encaminhamentos indiscriminados para uma lógica de corresponsabilização territorial. - Busca maior resolubilidade em saúde, para assegurar, de uma forma dinâmica e interativa, retaguarda especializada às equipes. - Apresenta dimensão assistencial (cuidado direto aos indivíduos) e dimensão técnico-pedagógica (suporte para as equipes, com vistas à ampliação das possibilidades de intervenção).
Clínica Ampliada	- A qualidade e a resolubilidade são fatores que a regem. - Objetiva o sujeito doente e não a doença e é chamada de Ampliada porque amplia o repertório de ações, com produção de maiores graus de autonomia, autocuidado, capacidade de intervenção na realidade, desenvolvimento da sociabilidade e cidadania. - Os objetivos da clínica ampliada visam à produção de saúde nos distintos meios curativos, preventivos, de reabilitação e cuidados paliativos, como também à ampliação do grau de autonomia do usuário, família e da comunidade.
Projeto Terapêutico Singular (PTS)	- Levada em conta que, para cada paciente, há responsabilidade do cuidado, que se divide entre os profissionais. - É um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. - Todas as opiniões são importantes para ajudar a entender o sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde e, consequentemente, para definição de propostas de ações.
Projeto de Saúde no Território (PST)	- Objetivo de orientar pela regionalização, buscando parcerias e apoio levando saúde em escolas, igrejas, pastorais; entre outros, além da intersetorialidade. - Também objetiva o desenvolvimento de ações no território, pois quando a atenção se desloca do indivíduo para família, o conhecimento do território e ambiente em que vivem passa a ser necessário.
Pactuação do Apoio	- Dividida em duas atividades: Avaliação conjunta da situação inicial do território entre os gestores, equipes de SF e o Conselho de Saúde; e Pactuação do desenvolvimento do processo de trabalho e das metas, entre os gestores, a equipe do NASF e a equipe de ESF. - Por meio desta ferramenta os profissionais assumem sua responsabilidade na cogestão e os gestores coordenam os processos de trabalhos e metas.

FONTE: Adaptado de (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010; HAFNER et al., 2010; ABBADE; SILVA; OLIVEIRA, 2014; LIMA, 2013)

Finalizamos esse item, caro acadêmico, deixando claro que as ferramentas mostradas no quadro anterior, trazem um modelo inovador e aspectos diferentes dos conhecidos por muitos profissionais. E que o NASF não se constitui em porta

de entrada do SUS, mas deve atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes Saúde da Família (LIMA, 2013).

4 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO NA SAÚDE (PNH)

Iniciamos esse item, mostrando que a definição de humanização adotada no campo da saúde inclui os parâmetros definidos pela PNH e assim se pode dizer que a humanização seria

um conjunto de princípios e diretrizes que afirma a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde (usuários, trabalhadores e gestores); o fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; o aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; o estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão; a identificação das necessidades sociais de saúde, dos usuários e dos trabalhadores; e o compromisso com a ambiência, com a melhoria das condições de trabalho e de atendimento. (DESLANDES; MITRE, 2009, p. 641).

A proposta da PNH enfatiza a necessidade de assegurar atenção integral à população e estratégias de ampliar a condição de direitos e de cidadania das pessoas (SANTOS FILHO, 2007). Segundo Brasil (2013, p. 3), a PNH existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, “qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários”. O PNH trabalha com três macro-objetivos:

Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores e aos conselheiros de saúde, priorizando a atenção básica/fundamental e hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgências e universitários; Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores, dos conselheiros de saúde e das organizações da sociedade civil; Divulgar a Política Nacional de Humanização e ampliar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições. (BRASIL, 2013, p. 3).

Segundo Brasil (2004, p. 21), existem quatro marcas específicas de trabalho a serem consolidadas pela PNH:

1 Reduzir filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco. 2 Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial; 3 As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS; 4 As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários assim como educação permanente aos trabalhadores.

Para Brasil (2004, p. 6):

Para a viabilização dos princípios e resultados esperados com o HumanizaSUS, a PNH opera com os seguintes dispositivos, aqui entendidos como “tecnologias” ou “modos de fazer”: Acolhimento com classificação de risco; Equipes de Referência e de Apoio Matricial; Projeto Terapêutico Singular e Projeto de Saúde Coletiva; Projetos de Construção Coletiva da Ambiência; Colegiados de Gestão; Contratos de Gestão; Sistemas de Escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde: gerência de “porta aberta”, ouvidorias, grupos focais e pesquisas de satisfação; Projeto “Acolhendo os familiares/rede social participante”: Visita Aberta, Direito de Acompanhante e envolvimento no Projeto Terapêutico; Programa de Formação em Saúde e Trabalho e Comunidade Ampliada de Pesquisa; Programas de Qualidade de Vida e Saúde para os Trabalhadores da Saúde; Grupo de Trabalho de Humanização

Caro acadêmico, com a citação anterior, você entendeu que o acolhimento faz parte da humanização como um “modo de fazer”. Solla (2005) aponta que existe relação entre acolhimento e humanização, porque o acolhimento significa a humanização do atendimento, o que pressupõe a garantia de acesso a todas as pessoas. Diz respeito, ainda, à escuta de problemas de saúde do usuário, de forma qualificada, dando-lhe sempre uma resposta positiva e responsabilizando-se pela resolução do seu problema e vínculo necessário entre o serviço e a população usuária. Por consequência, o acolhimento deve garantir a resolubilidade que é o objetivo do trabalho em saúde, resolver efetivamente o problema do usuário. O acolhimento passa a ser uma ferramenta, ou uma fase do atendimento nos serviços de saúde que vem ganhando importância e conceitos próprios, como um arranjo tecnológico que busca garantir acesso aos usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os problemas mais simples e/ou referenciá-los se necessário, abrindo os serviços para a demanda (SCHIMITH et al., 2006).

Franco, Bueno e Merhy (1999, p. 347) descrevem alguns princípios do acolhimento enquanto diretriz operacional:

Propõe inverter a lógica da organização e do funcionamento do serviço de saúde e que este seja usuário centrado. Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a acessibilidade universal. Assim, o serviço assume sua função precípua, acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os problemas de saúde da população. Reorganizar o processo de trabalho, a fim de que desloque seu eixo central, do médico, para uma equipe multiprofissional, equipe de acolhimento, que se encarregue de uma escuta do usuário comprometendo-se a resolver seu problema de saúde.

O acolhimento é uma ferramenta assistencial, humanizadora de solidariedade e cidadania que qualifica a relação trabalhador-usuário, e deve ser desenvolvido antes, durante e após o atendimento por todos os profissionais, onde o usuário recebe uma assistência integral e multiprofissional adequada. O trabalho em equipe entra na humanização e acolhimento, e quando realizado com qualidade e eficiência, traz resultados mais satisfatórios em relação à saúde, como o bem-estar físico, psicológico, social e emocional dos pacientes (SCHIMITH; LIMA, 2004).

Cavalcante Filho et al. (2009, p. 321) propõe o acolhimento coletivo, partindo do pressuposto que o acolhimento se destina a “garantir a universalidade com escuta qualificada de todos que chegam à unidade de saúde e a agilidade do acolhimento se dá pelo fato de toda equipe fazer a escuta”. E vai fundo, argumentando que a tentativa do acolhimento coletivo em transformar o modelo, retirar a centralidade das consultas médicas e ampliar as potencialidades dos profissionais que compõem a equipe, enfatizam a mudança radical que o acolhimento provoca no processo de trabalho de uma Unidade de Saúde. A Equipe de Acolhimento passa a ser o centro das atividades no atendimento aos usuários e “os profissionais não médicos passam a usar todo o seu arsenal tecnológico, o conhecimento para a assistência, na escuta e solução de problemas de saúde, trazidos pela população usuária dos serviços de saúde da Unidade”. (CAVALCANTE FILHO et al., 2009, p. 321).

Agora que vimos a PNH e o acolhimento como uma ferramenta de operacionalização da saúde, vamos, caro acadêmico, entender também a assistência domiciliar à saúde, pois ela é prevista pela ESF:

Como forma de instrumentalizar os profissionais para sua inserção e o conhecimento da realidade de vida da população, bem como o estabelecimento de vínculos com a mesma; visando atender as diferentes necessidades de saúde das pessoas, preocupando-se com a infraestrutura existente nas comunidades e o atendimento à saúde das famílias (GIACOMOZZI; LACERDA, 2006, p. 646).

5 ATENÇÃO, ASSISTÊNCIA E VISITA DOMICILIAR À SAÚDE

Podemos definir as áreas de saúde domiciliares como aquelas realizadas na residência do sujeito ou do grupo familiar, alvo do cuidado sanitário. Assim, “a visita domiciliar em um primeiro momento, torna-se uma ação de prevenção e de precaução, em um segundo momento pode ser caracterizada como de extremo controle e vigilância do comportamento e dos hábitos individuais”. (ABRAHÃO; LAGRANGE, 2007, p. 157).

Em janeiro de 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) editou a Resolução nº 11/2006 para regulamentar o funcionamento dos serviços de atenção domiciliar, nas modalidades de assistência e internação domiciliar. “Essa resolução dá parâmetros para o funcionamento de serviços de atenção domiciliar que são os responsáveis pelo gerenciamento e operacionalização da assistência e/ou internação domiciliar”. (ABRAHÃO; LAGRANGE, 2007, p. 157).

Nesta Resolução (Anvisa, 2006), a atenção domiciliar é definida como o termo genérico que envolve áreas de promoção da saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação, todas desenvolvidas em domicílio.

Assistência domiciliar é definida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. [...] internação domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao usuário com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. (ABRAHÃO; LAGRANGE, 2007, p. 158).

Veja as características de cada um no quadro a seguir:

QUADRO 19 - CARACTERÍSTICAS DA ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

	Características
Atenção Domiciliar	- Constitui a modalidade geral da atenção à saúde prestada no domicílio. - Engloba e representa o atendimento, a visita e a internação domiciliares, cada qual com seus objetivos e características. - Considerada um componente do <i>continuum</i> dos cuidados à saúde, pois os serviços de saúde são oferecidos ao indivíduo e sua família em suas residências com o objetivo de promover, manter ou restaurar a saúde, maximizar o nível de independência, minimizando os efeitos das incapacidades ou doenças, incluindo aquelas sem perspectiva de cura.
Assistência Domiciliar	- Também denominada atendimento ou cuidado domiciliar. - Baseia-se na plena interação do profissional com o paciente, sua família e com o cuidador, quando esse existe. - Constitui um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio, e pode ser instrumentalizada pela visita ou internação domiciliar.

FONTE: Adaptado de (GIACOMOZZI; LACERDA, 2006)

A atenção domiciliar possui duas categorias:

O atendimento domiciliar [...] diretamente relacionada à atuação profissional no domicílio, que pode ser operacionalizada por meio da visita e da internação[...] a visita domiciliar [...] prioriza o diagnóstico da realidade do indivíduo e as ações educativas. É um instrumento de intervenção fundamental na saúde da família e na continuidade de qualquer forma de assistência e/ ou atenção domiciliar à saúde, sendo programada e utilizada com o intuito de subsidiar intervenções ou o planejamento de ações. A internação domiciliar, por sua vez, é uma categoria mais específica, que envolve a utilização de aparato tecnológico em domicílio, de acordo com as necessidades de cada indivíduo, sendo caracterizada pela permanência da equipe de saúde na residência por no mínimo quatro horas diárias, com acompanhamento contínuo. O indivíduo para ser internado em domicílio precisa apresentar quadro clínico estável, assim como a equipe profissional necessita de rede de suporte para as possíveis eventualidades. (GIACOMOZZI; LACERDA, 2006, p. 646-647).

Finalizamos este tópico, deixando claro que para que os cuidados domiciliares sejam efetivos e tenham sucesso, devem ser considerados alguns aspectos referentes à organização e à formação dos profissionais de saúde. Olhar o indivíduo e sua família em seu contexto, considerando seu meio social, suas inserções, seu local de moradia, seus hábitos e relações.

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, vimos que:

- Em 1992 foi criado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- Em 1994, o Ministério da Saúde (MS) lançou o PSF como uma importante estratégia para reordenação dos serviços da atenção básica com vistas na promoção à saúde.
- O PSF, pela Portaria nº 648/06, passou a ser denominado ESF, buscando transcender a lógica do grande número de programas verticalizados em uma tentativa de garantir a integralidade de assistência e a criação de vínculo de compromisso e responsabilidade, compartilhados entre os serviços de saúde e a população, favorecendo a consolidação do SUS.
- A implementação da ESF apresentou como uma das maiores dificuldades, a carência de profissionais para atender a esta nova realidade.
- O trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde-doença baseada na ação interdisciplinar.
- As equipes de saúde são responsáveis pela atenção integral continuada à saúde de uma população de até 4.000 mil pessoas residentes em seu território de abrangência e devem entre várias tarefas.
- Um NASF deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais da ESF.
- A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do NASF dependem de algumas ferramentas como o Apoio Matricial, Clínica Ampliada, Projeto Terapêutico Singular (PTS), Projeto de Saúde no Território (PST) e Pactuação do Apoio.
- A proposta da PNH enfatiza a necessidade de assegurar atenção integral à população e estratégias de ampliar a condição de direitos e de cidadania das pessoas.
- O acolhimento significa a humanização do atendimento, o que pressupõe a garantia de acesso a todas as pessoas.

- O acolhimento passa a ser uma ferramenta, ou uma fase do atendimento nos serviços de saúde.
- Áreas de saúde domiciliares são realizadas na residência do sujeito ou do grupo familiar, alvo do cuidado sanitário.
- Visita domiciliar é uma ação de prevenção e de precaução, e de extremo controle e vigilância do comportamento e dos hábitos individuais.



1 Com relação à ESF, assinale V para verdadeiro e F para falso sobre suas características:

- a) () Objetiva a elevada cobertura populacional, a facilidade no acesso e no atendimento integral dos indivíduos em seu contexto familiar.
- b) () Prioriza a “territorialização e a delimitação das áreas de abrangência das equipes.
- c) () Identifica as necessidades e os problemas de saúde da população.
- d) () Monitora as condições de vida e de saúde das coletividades, mas não objetiva a programação e a execução das ações sanitárias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – V – V – F.
- b) () V – F – F – F.
- c) () V – F – V – V.
- d) () V – F – F – V.

2 O PNH trabalha com três macro-objetivos, EXCETO:

- a) () Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores e aos conselheiros de saúde.
- b) () Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores do SUS na agenda dos gestores, dos conselheiros de saúde e das organizações da sociedade civil.
- c) () Não priorizar a atenção básica/fundamental e hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgências e universitários.
- d) () Divulgar a Política Nacional de Humanização e ampliar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.

3 O acolhimento é uma ferramenta, humanizadora de e cidadania que qualifica a relação, e deve ser desenvolvido antes, durante e após o atendimento por todos os, onde o usuário que recebe uma assistência e adequada.

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a citação acima:

- a) () solidariedade, assistencial, trabalhador-usuário, profissionais, integral, multiprofissional;

- b) () assistencial, solidariedade, trabalhador-usuário, profissionais, integral, multiprofissional;
- c) () assistencial, solidariedade, profissionais, trabalhador-usuário, integral, multiprofissional;
- d) () solidariedade, assistencial, integral, trabalhador-usuário, profissionais, multiprofissional.

4 Conforme seus estudos, a atenção domiciliar, ainda possui duas categorias. Sobre as características da atenção domiciliar, analise as seguintes sentenças:

A primeira categoria diz respeito ao atendimento domiciliar à saúde e como segunda categoria tem-se a visita domiciliar

Que

prioriza o diagnóstico da realidade do indivíduo e as ações educativas.

- a) () A primeira é uma afirmação verdadeira e a segunda, falsa.
- b) () Ambas afirmações são falsas.
- c) () As duas são verdadeiras, mas não tem relação entre si.
- d) () As duas são verdadeiras e a segunda é complemento e justificativa da primeira.

PLANEJAMENTO, ÁREAS E REDES DE ATUAÇÃO DE SAÚDE NO SUS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade você será capaz de:

- conhecer as áreas estratégicas de atuação, redes de atenção à saúde e programas especiais de atenção à saúde do SUS;
- compreender as diferenças e características das áreas estratégicas de atuação, redes de atenção à saúde e programas especiais de atenção à saúde do SUS;
- conhecer as Normas de Operacionais Básicas (NOB), o Plano Diretor Municipal (PDM), e todas as suas características, seu funcionamento e objetivos;
- entender as formas de organização do Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS e Instrumentos básicos de Planejamento do SUS;
- diferenciar e entender os diferentes sistemas de informações utilizadas pelo SUS.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em três tópicos. Em cada um deles, você encontrará atividades que o ajudarão a fixar os conhecimentos abordados.

TÓPICO 1 – ÁREAS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

TÓPICO 2 – PLANEJAMENTO DE SAÚDE NO SUS

TÓPICO 3 – PRINCIPAIS INDICADORES DA SITUAÇÃO DE SAÚDE

ÁREAS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE E PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

1 INTRODUÇÃO

Podemos dizer que a Atenção Básica é composta por um conjunto de ações práticas necessitando implementação, pluralidade de habilidades, atitudes e conhecimentos técnicos e científicos de relativa baixa complexidade, enfocando principalmente nos problemas mais prevalentes dos grupos sociais (crianças, jovens, adultos, idosos etc) atuando em diversas redes (unidades básicas de saúde, ambulatorios, hospitais e serviços de emergência), além de desenvolver projetos diferenciados.

Neste tópico, vamos estudar o planejamento e atuação do SUS. Será dividido em seis itens. No primeiro abordaremos “Saúde da criança, do adolescente e do jovem”; no segundo “Saúde do homem e da mulher”; no terceiro “Saúde do idoso” e no quarto “Saúde mental”, apontando as principais características de cada um deles. No quinto item, falaremos das Redes de atenção à saúde e por fim no sexto item dos Programas Especiais, Departamento de DST, AIDS, hepatites virais, cirurgia bariátrica e doação de órgãos/transplante.

2 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO JOVEM

Caro acadêmico! Você estudou na Unidade 2, Tópico 3, que o NASF tem um grande grupo de profissionais que auxiliam as equipes de trabalho da ESF e estas equipes, conjuntamente, atuam em várias áreas estratégicas, redes e programas. A saúde da criança, do adolescente e do jovem faz parte desta atuação multiprofissional. Modificar as atitudes e intervir nos problemas mais prevalentes dos grupos sociais é um dos objetivos da Atenção Básica, visando à modificação das “condições de vida da comunidade, em função do controle de fatores sociais e ambientais, além de hábitos e estilos de vida, com o propósito de estimular atitudes saudáveis e eliminar riscos”. (DEL CIAMPO et al., 2006, p. 740).

Assim, dentro da Atenção Básica, os programas direcionados à saúde da criança e adolescente objetivam promover saúde, prevenir doenças, tratar e reabilitar, garantindo a saúde e o bem-estar, a fim de garantir o crescimento e o

desenvolvimento adequados nos aspectos físico, emocional e social e proporcionar o pleno desenvolvimento do potencial genético da criança e adolescente, que levará a um adulto mais saudável (DEL CIAMPO et al., 2006).

Em uma ação coordenada entre o governo federal, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e o Ministério da Saúde (MS), fundamentado na análise das condições sanitárias e epidemiológicas da população, foi formado o **Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC)**, na década de 80, que objetivava o acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 5 anos de idade; a diminuição da morbimortalidade de crianças de 0 a 5 anos de idade, promovendo o aleitamento materno e orientação alimentar para o desmame, controle da diarreia, controle das doenças respiratórias na infância, imunização e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento (FIGUEIREDO; MELLO, 2003).

As políticas de saúde, na área da criança, a partir das décadas de 80 e 90, desenvolveram programas buscando oferecer atendimento mais qualitativo e efetivo à criança, dentre eles, destacam-se o PAISC, o PSF, disseminação do Cartão da Criança, como instrumento do monitoramento do crescimento e do desenvolvimento, a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso (Método Canguru), o Projeto Acolhimento mãe e bebê, o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno e mais recentemente a estratégia AIDPI (ERDMANN; SOUSA, 2009, p. 151).

As linhas de cuidado da criança, têm como base: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 1990; Estratégia da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), 1996; Pacto pela Redução da Mortalidade Neonatal, 2004; Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste – Amazônia Legal, 2009; Agenda de Compromisso da Criança – Atenção Integral, 2005; Pacto pela Saúde na dimensão do Pacto pela Vida, 2006; Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis – Primeiros Passos para o Desenvolvimento Nacional, 2008; PAC Saúde – Mais Saúde, 2008. Esses documentos formalizam algumas ações para promover:

- Atenção integral à saúde da criança.
- Atenção ao recém-nascido.
- Investigação do óbito infantil.
- Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
- Prevenção de violências e promoção da cultura de paz.

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde – OMS, na expectativa da Atenção Integral à Saúde da Criança, e para a coordenação da assistência, aponta como estratégias, segundo Erdmann e Souza (2009), as Linhas de Cuidado, ações que vão da anticoncepção à concepção, à atenção ao parto e ao puerpério, passando pelos cuidados com o recém-nascido (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, triagem neonatal, aleitamento materno, doenças prevalentes da infância e saúde coletiva em instituições de educação infantil). E as Linhas de Intervenção, que explicitam o conceito de integralidade por meio da oferta de

ações educativas, promocionais, preventivas, de diagnóstico e de recuperação da saúde.

O ECA foi importante, pois regulamentou a proteção da infância e da adolescência, reconhecendo as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos e portadores de necessidades especiais, institucionalizando um novo olhar sobre o adolescente, apresentando estrutura teórica que instiga a reflexão sobre novas considerações, táticas e ações na área de promoção da saúde voltada para esse grupo etário. O Estatuto da Criança e do Adolescente reserva capítulo próprio ao direito à saúde, que deve ser coberto por meio do SUS, prioritariamente: “atendimento médico, farmacêutico e outros recursos para tratamento e reabilitação; promoção de programas de assistência médica e odontológica para a prevenção dos agravos do segmento infantojuvenil; vacinação obrigatória; permanência dos pais ou responsáveis junto com a criança e o adolescente em casos de internação” (BRASIL, 2005, p. 32 apud RAPOSO, 2010, p. 120).

O ECA define adolescente como pessoa entre 12 e 18 anos. Especialmente com os adolescentes, as unidades de saúde devem oferecer atendimento individual ou em grupos de apoio, com diferentes linhas de cuidado, como: grupo de apoio a gestantes adolescentes, grupo de apoio e orientação a DST/AIDS, grupos de apoio e orientação a cultura de paz (englobando temas como violência doméstica, uso de drogas, superação de conflitos/resiliência), projeto de vida e futuro. Diferentes questões poderão ser trabalhadas, fortalecendo uma rede de exemplos e experiências entre eles, em que o profissional cumprirá um papel de facilitador, deverá se demonstrar solidário, nunca de maneira crítica ou julgadora, mediando conflitos e oferecendo informações de saúde. Destaca-se algumas Políticas Públicas em saúde do adolescente e jovem:

- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente e Jovens, 2007.
- Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e Jovens – MS 2007.
- ECA, 1990.
- Atenção à Saúde Mental de Adolescentes Privados de Liberdade, 2004.
- Programa Saúde na Escola, 2008 (BRASIL, 1990).

Outro programa que merece destaque, segundo Del Ciampo et al. (2006, p. 741) é o Programa de Puericultura (PPUE) que:

deve se estender a toda a população na faixa etária que vai do nascimento aos 20 anos incompletos, com seguimento longitudinal e distinto entre as diferentes idades, e ser realizado por meio de atendimento ambulatorial individualizado, visitas domiciliares e participação em grupos de educação e socialização [...] e com os objetivos:

- a) vigiar o crescimento físico e o desenvolvimento neuropsicomotor e intelectual;
- b) ampliar a cobertura vacinal;
- c) promover a educação alimentar e nutricional;
- d) promover a segurança e a prevenção de acidentes;
- e) promover a prevenção de lesões intencionais, principalmente no ambiente doméstico;

- f) estimular a promoção da saúde e a prevenção das doenças mais comuns na comunidade;
- g) promover a higiene física e mental e a prática de atividades de lazer adequadas às faixas etárias;
- h) propiciar a socialização, estimulação cultural e adaptação da criança e do adolescente em seu meio social.

Agora que você estudou sobre a assistência da saúde da criança, do adolescente e do jovem, vamos falar da saúde do homem e da mulher que também faz parte da área de atuação da atenção primária.

3 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM

Iniciaremos esse item falando da saúde da mulher. Apontando como principal norteador, o documento **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes (PAISM)**, elaborado pelo Ministério da Saúde com diversos setores da sociedade, em especial com o movimento de mulheres, o movimento negro e o movimento de trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação internacional (BRASIL, 2004).

O PAISM, segundo Brasil (2004, 20-36), implementa:

ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. [...] incorpora, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual. Agrega, também, a prevenção e o tratamento das mulheres vivendo com HIV/AIDS e das portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e de câncer ginecológico. Além disso, amplia as ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas nas suas especificidades e necessidades.

O PAISM traz a perspectiva de uma política de transformação de relações entre os gêneros, particularmente procurando fortalecer as mulheres, todos os seus ciclos da vida, com práticas educativas nos serviços de saúde, que devem abordar os cuidados com o corpo, numa perspectiva de fortalecimento da autonomia das mulheres (SOUTO, 2009).

De acordo com (BRASIL, 2004, p. 67), o PAISM tem, concretamente, três objetivos gerais:

- Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro.
- Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.

– Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde

Agora que você entendeu sobre a PAISM e suas características, vamos, caro acadêmico, entender a saúde do homem. Essa área temática foi criada em 2007 pelo Ministério da Saúde e os princípios e diretrizes da **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)** foram publicados em 2008: “sendo a política oficialmente lançada em 2009, com a publicação de uma Portaria Ministerial, [...] representa uma inovação na medida em que os homens são historicamente, sujeitos singularizados nas intervenções desenvolvidas pelo Estado brasileiro no campo da saúde” (LEAL; FIGUEIREDO; SILVA, 2012, p. 2.608).

Esta política PNAISH tem como objetivo diminuir a morbimortalidade dos homens por meio do aumento e facilitação do acesso e de ações de precaução e assistência a este grupo populacional (KNAUTH; COUTO; FIGUEIREDO, 2012). “A PNAISH vem sendo apontada como uma política pública de vanguarda no cenário mundial, sendo a primeira política pública de saúde voltada especificamente para os homens na América Latina e a segunda no continente americano, após o Canadá”. (MARTINS; MALAMUT, 2013, p. 431).

Garantindo a integralidade, equidade e humanização do atendimento, segundo Moura, Lima e Urdaneta (2012, p. 2.589):

o princípio básico da PNAISH é a orientação de ações e serviços de saúde para a população de homens entre 20 e 59 anos de idade. As diretrizes da PNAISH são fundamentadas num conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, nos diferentes níveis de atenção, com priorização da atenção básica, em especial da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Ainda para Moura, Lima e Urdaneta (2012, p. 2.589):

O Plano Nacional para o triênio 2009-2011 possibilitou a implantação da PNAISH em todas as Unidades Federadas [...] os eixos que compõe a PNAISH: I – implantação da PNAISH, II – promoção da saúde, III – informação e comunicação, IV – participação, relações institucionais e controle social, V – implantação e expansão do sistema de atenção a saúde do homem, VI – qualificação de profissionais da saúde, VII – insumos, equipamentos e recursos humanos, VIII – sistemas de informação, e IX – avaliação do projeto piloto.

Agora que você viu algo sobre a assistência da saúde da mulher e do homem, vamos falar da saúde do idoso que também faz parte da área de atuação da atenção primária.

4 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE DO IDOSO

Atualmente, tem se mostrado necessária a implementação de programas voltados à saúde do idoso, devido ao aumento da população idosa em todos países do mundo. No Brasil não é diferente, pois a previsão é de que até o ano

de 2025, o Brasil seja o sexto país no mundo, em número de idosos (COSTA; CIOSAK, 2010).

Várias medidas são implementadas para proteção dos idosos, como cidadãos cada vez mais presentes nas sociedades mundiais, como por exemplo:

No aspecto legislativo, os idosos foram mencionados em alguns artigos, decretos-leis, leis, portarias, entre outras [...] artigos do Código Civil (1916), do Código Penal (1940), do Código Eleitoral (1965), além da Lei Nº 6.179 de 1974, que criou a Renda Mensal Vitalícia, e de outros decretos-leis e portarias relacionadas, particularmente, com as questões da aposentadoria (RODRIGUES et al., 2007, p. 537).

No Brasil, pelo reconhecimento do envelhecimento populacional, Rodrigues et al. (2007, p. 538), continua mostrando que:

Foi aprovada a Lei Nº 8.842/1994, que estabelece a Política Nacional do Idoso, posteriormente regulamentada pelo Decreto Nº 1.948/96.6. Esta Lei tem por finalidade assegurar direitos sociais que garantam a promoção da autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade, de modo a exercer sua cidadania. [...] estipula-se limite de 60 anos e mais, de idade, para uma pessoa ser considerada idosa.

Na área da saúde, as políticas de saúde que tratavam dos idosos, nos anos 80, para atender a crescente demanda, criaram a:

Política Nacional do Idoso (PNI), a partir da regulamentação do SUS, com o objetivo de assegurar os direitos sociais à pessoa idosa, criar condições para promover sua autonomia e reafirmar seu direito à saúde, nos níveis de atenção à saúde. Em 2006, foi implementada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) que define a Atenção Básica (AB) como porta de entrada para a atenção à saúde do idoso e a referência para a rede de serviços especializados de média e alta complexidade, logo após, a Política Nacional de Atenção Básica, caracterizada por desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. A Atenção Básica deve estar voltada para o envelhecimento e a saúde da pessoa idosa através do desenvolvimento de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas e, sob a forma de trabalho. (COSTA; CIOSAK, 2010, p. 438).

A Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) consta na íntegra do anexo da Portaria 1.395/1999 do Ministério da Saúde e visa:

à promoção do envelhecimento saudável, à prevenção de doenças, à recuperação da saúde, à preservação/melhoria/reabilitação da capacidade funcional dos idosos com a finalidade de assegurar-lhes sua permanência no meio e sociedade em que vivem, desempenhando suas atividades de maneira independente”. (RODRIGUES et al., 2007, p. 541).

Veja no quadro a seguir algumas diretrizes essenciais da PNSI.

QUADRO 20 - ALGUMAS DIRETRIZES ESSENCIAIS DA PNSI

Promoção do envelhecimento saudável	- Ações de orientação em relação à importância da melhoria de suas habilidades funcionais, mediante a adoção precoce de hábitos saudáveis de vida, a eliminação de comportamentos nocivos à saúde, além de orientação aos idosos e seus familiares quanto aos riscos ambientais favoráveis a quedas.
Manutenção da capacidade funcional	- Referente às ações com vistas à prevenção de perdas funcionais em dois níveis: 1) prevenção de agravos à saúde, com ações voltadas para a imunização; 2) ações para a detecção precoce de enfermidades não transmissíveis, com a introdução de novas medidas, como a antecipação de dano sensoriais, utilização de protocolos para situações de risco de quedas etc.
Assistência às necessidades de saúde do idoso	- Extensiva aos âmbitos de assistência: 1) ambulatorial (embasada na consulta geriátrica fundamentada na coleta e no registro de informações); 2) hospitalar (idade como indicador na determinação da assistência ao idoso enfermo, e o estado funcional será o parâmetro mais fidedigno no estabelecimento de critérios específicos de atendimento); 3) domiciliar (estratégia importante para diminuir o custo da internação. O atendimento ao idoso enfermo, residente em instituições, terá as mesmas características da assistência domiciliar).
Reabilitação da capacidade funcional	- Foco na reabilitação precoce, ou seja, prevenir a evolução e recuperar a perda funcional incipiente, de forma a evitar que as limitações da capacidade funcional avancem e fazer com que essas limitações sejam amenizadas.
Capacitação de recursos humanos especializados	- Diretrizes que perpassarão todas as demais definidas nesta política, configurando mecanismos de articulação intersetorial, de forma que o setor saúde possa dispor de pessoal em qualidade e quantidade adequadas, e cujo provimento é de responsabilidade das três esferas de governo.
Apoio do desenvolvimento de cuidados informais	- Desenvolvimento de parcerias entre os profissionais da saúde e as pessoas próximas aos idosos responsáveis pelos cuidados diretos, necessários à manutenção das atividades da vida diária e pelo seguimento das orientações emitidas pelos profissionais.

FONTE: Adaptado de Rodrigues et al. (2007)

Não se esgota, no quadro anterior, as diretrizes essenciais da PNSI, mas podemos observar que as diversas propostas de Políticas de Atenção estão bem delineadas e traçadas, mas deixamos claro que é necessário uma ótima equipe multiprofissional para que elas tenham eficiência, ótima formação da equipe de saúde para essa área de conhecimento e, principalmente, adequar a realidade brasileira identificando problemas do “idoso dentro do contexto familiar e social e efetivando intervenções no ensino, na pesquisa e na assistência, respeitando suas potencialidades e diferenças individuais” (RODRIGUES et al, 2007, p. 540).

5 ÁREAS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO: SAÚDE MENTAL

Agora que você estudou a assistência da saúde do idoso, vamos falar da saúde mental que também faz parte da área de atuação da atenção primária. A perspectiva asilar marca a história da atenção à saúde mental no Brasil, quando no período da Ditadura Militar, ocorreu uma enorme expansão do número de leitos psiquiátricos contratados com hospitais privados, a ponto de, em 1978, cerca de 90% do orçamento do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) ser destinado a essa contratação (CESARINO, 1989).

Pela década de 1980, no período da cogestão Ministério da Saúde e Ministério da Previdência e Assistência Social, o “Plano do CONASP” procurou estimular a descentralização da assistência à saúde em geral, por meio das Ações Integradas de Saúde e no campo da saúde mental, em particular, colocou-se “a meta de reduzir em 30% as internações psiquiátricas, limitar o tempo médio de internação de 90 para 30 dias e expandir em 50% as consultas ambulatoriais, o que ocorreu de forma localizada e, ainda assim, com reação do setor privado” (AMARANTE, 1995).

A atual política de saúde mental brasileira é resultado do movimento de usuários, familiares trabalhadores da Saúde iniciada na década de 1980 com o objetivo de substituição de um modelo de saúde mental baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de serviços comunitários com forte inserção territorial, sendo que nas últimas décadas, esse processo de mudança se expressa especialmente por meio do Movimento Social da Luta Antimanicomial e de um projeto coletivamente produzido de mudança do modelo de atenção e de gestão do cuidado: a Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2001, p. 42).

A partir da Reforma Psiquiátrica (instituída pela Lei nº 10.216/2001) as práticas profissionais fundamentadas pela psiquiatria clássica passam a ser transformadas no espaço do manicômio, deslocando a centralidade da assistência hospitalar e do foco na doença para o sujeito em si, reconhecendo a sua subjetividade (SILVA; AZEVEDO, 2011).

Em 2002, surge a Política Nacional de Saúde Mental – PNSM, apoiada na Lei 10.216/02, além de novos modelos de saúde mental, denominados serviços substitutivos, que alicerçados pela Reforma, nomeiam ações e atividades na perspectiva e extensão comunitária, com o intuito de reintegrar o sujeito à sociedade, com enfoque na reinserção social dos usuários através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários, além de ofertar suporte à saúde mental na rede básica. Assim, para consolidação desse novo modelo de saúde, foram implementados serviços de saúde mental, tendo como base Serviço Residencial Terapêutico (SRT), o Programa de Volta para Casa (PVC – regulamentado pela Lei nº 10.708/2003), o Centro de Convivência e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em seus diferentes níveis (MESQUITA; NOVELLINO; CAVALCANTI, 2010; BATISTA, 2014).

O maior impacto na expansão da rede de atenção à saúde mental no País deu-se a partir de 2002, quando se iniciou a expansão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), implantação de residências terapêuticas (RT) e a partir de 2003, a inclusão de egressos de internações psiquiátricas de longa permanência no PVC. E, a Portaria nº 3.088/2011 estabeleceu a Rede de Atenção Psicossocial, utilizando o PVC para fundamentá-la, pois é considerado uma política pública de inclusão social que visa contribuir para o processo de desinstitucionalização e fortalecê-lo, somado com o Programa de Redução de Leitos Hospitalares de Longa Permanência e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) (LIMA; BRASIL, 2014).

Assim, de acordo com Furtado (2006, p. 787):

O Programa de Volta para Casa permite a obtenção de auxílio mensal, no valor de U\$80 dólares aproximadamente, para indivíduos com histórico de dois ou mais anos de internação psiquiátrica ininterrupta, desde que obtenham alta hospitalar. O Programa de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS (PRH) prevê a diminuição planejada e progressiva de vagas nos hospitais

Para que esses programas funcionem, caro acadêmico, é essencial que as Equipes de ESF tenham a oportunidade de compreender o tema saúde mental, desmistificando preconceitos e construindo “outros modos de atenção aos usuários, com quem se relacionam diariamente, podendo dessa construção, brotar sensibilidades com relação ao reconhecimento dos processos subjetivos como constituintes do processo saúde-doença”. (FIGUEIREDO; FURLAN, 2008, p. 162). Portanto, o SUS, a ESF e a Reforma Psiquiátrica se entrelaçam, levando a um diálogo promissor entre Saúde Mental e Atenção Básica, pois essas duas áreas trazem uma nova possibilidade ética, política e social para a saúde (LANCETTI, 2001).

Para que a saúde mental e atenção básica funcionem perfeitamente, é necessária uma boa comunicação e a construção de uma rede entre a atenção básica e outros dispositivos de saúde mental como, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), que são dispositivos estratégicos de referência e possibilitam ações integradas por equipes CAPS e ESF (DELFINI et al., 2009).

Cabe aos CAPS o acolhimento e a atenção às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. De fato, o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento (BRASIL, 2004b).

Segundo Brasil (2004b), os CAPS se diferenciam pelo porte, capacidade de atendimento, clientela atendida e organizam-se no país de acordo com o perfil populacional dos municípios brasileiros.

Veja no quadro a seguir as características de cada CAPS:

QUADRO 21 - DIFERENÇAS E CARACTERÍSTICAS ENTRE OS CAPS

CAPS I	- centros de menor porte; - demandas de saúde mental em municípios com população entre 20.000 e 50.000 habitantes; - equipe mínima de 9 profissionais, entre profissionais de nível médio e nível superior; - clientela: adultos com transtornos mentais severos e persistentes e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas; - funcionam cinco dias úteis da semana e têm capacidade para o acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês.
CAPS II	- serviços de médio porte; - cobertura a municípios com mais de 50.000 habitantes; - clientela de adultos com transtornos mentais severos e persistentes; - equipe mínima de 12 profissionais, entre profissionais de nível médio e nível superior e capacidade para o acompanhamento de cerca de 360 pessoas por mês; - funcionam durante os cinco dias úteis da semana.
CAPS III	- maior porte da rede CAPS; - cobertura aos municípios com mais de 200.000 habitantes; - serviços de grande complexidade, uma vez que funcionam durante 24 horas em todos os dias da semana e em feriados; - máximo cinco leitos, o CAPS III realiza, quando necessário, acolhimento noturno (internações curtas, de algumas horas a no máximo 7 dias); - equipe mínima para estes serviços deve contar com 16 profissionais, entre os profissionais de nível médio e superior, além de equipe noturna e de final de semana; - estes serviços têm capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de 450 pessoas por mês.
CAPSi	- atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais; - demanda em saúde mental em municípios com mais de 200.000 habitantes; - cinco dias úteis da semana e têm capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de 180 crianças e adolescentes por mês; - equipe mínima para estes serviços é de 11 profissionais de nível médio e superior.
CAPSad	- especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas; - previstos para cidades com mais de 200.000 habitantes, ou que, por sua localização geográfica (municípios de fronteira, ou parte de rota de tráfico de drogas) ou cenários epidemiológicos importantes; - funcionam cinco dias úteis da semana e têm capacidade para realizar o acompanhamento de cerca de 240 pessoas por mês; - equipe mínima composta por 13 profissionais de nível médio e superior.

FONTE: Adaptado de (BRASIL, 2004b)

O quadro mostra a diferença dos CAPS, mas para que sejam efetivas necessitam de profissionais de saúde mental e que as ações de saúde mental na atenção básica atendam aos princípios da universalidade preconizado pelo SUS, estimulando alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde além do tratamento. Agora, veremos as redes de saúde, que são os espaços onde acontecem os serviços de saúde.

6 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)

Na Unidade 1, você viu, acadêmico, o conceito e características das redes em geral. Aqui, na Unidade 3, vamos ver as redes específicas de atenção à saúde, portanto, iniciamos esse item diferenciando os termos região de saúde e rede de atenção à saúde. Define-se região de saúde “como o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado, a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”. (BRASIL, 2011, p. 2). “Para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: I – atenção primária; II – urgência e emergência; III – atenção psicossocial; IV – atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e V – vigilância em saúde”. (BRASIL, 2011, p. 2).

Rede de atenção à saúde pode ser definido “como um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde” (BRASIL, 2011, p. 2). A Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabelece as diretrizes para a organização da RAS, no âmbito do SUS, e define rede de atenção à saúde como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010).

As RAS, possuem conjuntos de serviços de saúde, “vinculados entre si por uma missão única e objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, ofertando uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde - prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada - e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população” (MENDES, 2010, p. 2300).

A população refere-se à:

habilidade de um sistema em estabelecer as necessidades de saúde de uma população específica, sob sua responsabilidade, segundo os riscos, de implementar e avaliar as intervenções sanitárias relativas a essa população e de prover o cuidado para as pessoas no contexto de sua cultura e de suas preferências. [...] a população deve ser segmentada, subdividida em subpopulações por fatores de riscos e estratificada por riscos em relação às condições de saúde estabelecidas”. (MENDES, 2010, p. 2.300-2.301).

A estrutura operacional:

é constituída pelos nós das redes e pelas ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes nós. [...] compõe-se de cinco componentes: o centro de comunicação, a atenção primária à saúde; os pontos de atenção secundários e terciários; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos; e o sistema de governança da rede de atenção à saúde (MENDES, 2010, p. 2.301).

O modelo de atenção à saúde seriam os:

sistemas lógicos que organizam o funcionamento das redes de atenção à saúde, articulando, de forma singular, as relações entre a população e suas subpopulações estratificadas por riscos, os focos das intervenções do sistema de atenção à saúde e os diferentes tipos de intervenções sanitárias, definidos em função da visão prevalecente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. (MENDES, 2010, p. 2.302).

Podemos citar as portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011): os serviços de atenção primária à saúde; serviços de atenção de urgência e emergência; serviços de atenção psicossocial, e serviços especiais de acesso aberto.

As redes caracterizam-se pela formação de relações horizontais entre os diversos pontos de atenção, como os domicílios, as unidades básicas de saúde, os ambulatórios especializados, as policlínicas, as maternidades, os hospitais, entre outros, tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como coordenadora do cuidado e ordenadora do acesso dos usuários aos demais pontos de atenção (PUPO et al., 2014).

7 PROGRAMAS ESPECIAIS: DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, CIRURGIA BARIÁTRICA E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS/TRANSPLANTE

Este item foi construído para mostrar alguns avanços e desafios dentre todas as ações e serviços de saúde implementados nas duas últimas décadas. Falaremos de alguns deles, como assistência terapêutica na DST/AIDS, cirurgia bariátrica, doação de órgãos/transplantes, como ações e/ou serviços que caracterizam bons exemplos de avanços e/ou desafios na história de implementação do SUS. No quadro a seguir você verá algumas características destes programas.

QUADRO 22 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS DE:

Assistência terapêutica na DST, AIDS e Hepatites Virais	- Objetivo de assistência de qualidade às pessoas que convivem com o HIV/AIDS. - Portaria Nº 291 de 17 de junho de 1992 que incluiu assistência à AIDS em nível hospitalar no Sistema de Procedimentos de Alta Complexidade (SIPAC). - Programa de Alternativas Assistenciais – definição de condutas terapêuticas, políticas de medicamentos, assim como a capacitação de profissionais no manejo clínico dos pacientes. - Rede ambulatorial de assistência aos portadores do HIV/AIDS, houve um crescimento progressivo em resposta à demanda assistencial crescente. - Serviços de Hospital-Dia (HD).
--	--

	- Assistência Domiciliar Terapêutica – encaminhamento de internações de longa duração, compreendendo desde cuidados curativos a paliativos, por meio de visitas domiciliárias. - Centros de testagem e aconselhamento, para promover a identificação precoce de pacientes HIV positivo para o imediato encaminhamento à rede de assistência, além da atuação em ações de prevenção. - Centros de Orientação e Apoio Sorológico (COAS) – oferecerem exames de HIV de forma gratuita, confidencial e anônima, e também finalidade de educação e aconselhamento daqueles que estivessem sob maior risco de infecção. - Unidades Dispensadoras de Medicamentos Antirretrovirais (UDM), que realizam gestão e dispensação de medicamentos antirretrovirais, bem como o acompanhamento e monitoramento dos pacientes.
Assistência terapêutica na cirurgia bariátrica	- No Brasil, o SUS oferece o procedimento na rede pública desde 2000. - A saúde suplementar no Brasil, de caráter privado, provê cobertura obrigatória para a cirurgia bariátrica desde 2000. - O tempo de espera na fila para a realização da cirurgia bariátrica no SUS pode variar entre 2,2 anos até 3,4 anos. - Critérios para indicação operatória são os mesmos para o SUS como para a saúde suplementar: obesidade estável há pelo menos cinco anos; tratamento clínico prévio com acompanhamento regular e duração mínima de dois anos, mas considerado não eficaz; índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 40 kg/m² ou IMC entre 35 e 39,9 kg/m² com comorbidades (orgânicas ou psicossociais) desencadeadas ou agravadas pela obesidade e que ameacem a vida.
Doação de órgãos/ transplante	- A partir de 1997, Lei nº 9.434/2 – regulamentou a remoção de órgãos e tecidos do corpo humano para transplante. - Para a Legislação Brasileira, a aquisição de partes do corpo humano, para fins terapêuticos ou humanitários, poderá ser feita apenas pela doação gratuita, em vida ou <i>post mortem</i>. - Em vida para transplante é permitida à pessoa juridicamente capaz para o cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau, ou para qualquer dispensada no caso da medula óssea. - A remoção <i>post mortem</i> de órgãos e tecidos destinados a transplante deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, conforme resolução do Conselho Federal de Medicina, e a doação dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive. - Sistema Nacional de Transplante (SNT), com o objetivo de desenvolver nacionalmente o processo de captação e distribuição de órgão e tecidos, sob a responsabilidade das três esferas de governo, nas suas competências específicas, e formado pelas Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO); os centros de transplantes; e as equipes especializadas credenciadas para a realização dos transplantes.

FONTE: Adaptado de Villarinho et al. (2013), Kelles et al. (2014) e Ribeiro e Schramm (2006)

LEITURA COMPLEMENTAR

O BÁSICO DA ATENÇÃO (ELVIRA MARIA VENTURA FILIPE)

Que trabalho este nosso!

Traz tanta tensão...

Demanda diagnóstico, dados, desempenho, tolerância, treinamento, tentativas, técnica.

E debates, diálogos, disponibilidade, tarefas, traquejo.

É dedicado, diferenciado, dinâmico, distinto, diverso, diferente,

E tentador...

Pra travestis, transeuntes, doutores, doentes, donzelas e dondocas.

Que trabalho o nosso!

De pesquisa, projetos, de pares.

Primário e pertinente, produtivo e principal.

Básico, banal e benéfico.

É político, público, presente, pioneiro, participante.

E promove, previne, protege, preconiza.

Para prostitutas, professores, pedreiros...

Que trabalho este nosso!

Paciente, constante, substancial e solidário.

De escuta, exigência, conquista.

É social, essencial, substantivo, sublime.

Exige sentimento, seriedade, simplicidade e alguma sorte.

É versátil, valioso, visceral e vital.

Forma, fortifica, afronta e fortalece.

Vem da visita, das viagens, da vontade.

É fraternal, frequente e firme.

Para vulneráveis, viciados, virtuosos, vagabundos valentes.

E fanáticos, favelados febris, fortes e fracos.

Que trabalho o nosso!

É mistura, modelo, mudança.

Um laço largo e liberal.

Para mães, meninas, moleques marginais, lunáticos e loucos.

Exige curiosidade, conhecimento, cuidado, coordenação e constância.

É compartilhar, construção, casamento, com compromisso...

Que trabalho este nosso!

Que enriquece, envolve, incrível, instigante, inventivo.

De atenção, básica, mas primordial.

De parceiros companheiros.

Pras grávidas, os cheios de filhos, os sem nenhum.
Pros velhos, os jovens os de qualquer idade.
Pras donas Marias, pros seus Josés.

Que trabalho! Nosso!

FONTE: PAULA, I. A.; GUIBU, I. A. (Org.). **DST/aids e rede básica**: uma integração necessária. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde, 2007. 137p. Disponível em: <http://www3.crt.saude.sp.gov.br/arquivos/arquivos_biblioteca_crt/atencao_basica_completo.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

ATIVIDADE PRÁTICA

Entrevista sobre os desafios das UBS para atendimento das diferentes áreas estratégicas de atuação da saúde

Objetivo: Vá a uma UBS e entreviste diversos profissionais para montar um quadro sobre os desafios encontrados para a implementação dos programas que envolvem as diferentes áreas de estratégias de atuação (criança, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos e saúde mental) e monte um quadro contendo os desafios desses.

Tempo de duração: Uma manhã.

Material a ser utilizado: material de entrevista para a UBS, computador para montagem do quadro de desafios. Cada aluno prepara sua pesquisa para depois apresentar ao grande grupo os desafios encontrados nas UBS.

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, vimos:

- Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) busca o acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 5 anos de idade.
- A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) garante os direitos das mulheres e reduzem a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis, consolidando avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual.
- A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) reduz a morbimortalidade por meio da ampliação e facilitação do acesso e de ações de prevenção e assistência a este grupo populacional.
- A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) visa à promoção do envelhecimento saudável, à prevenção de doenças, à recuperação da saúde, à preservação/melhoria/reabilitação da capacidade funcional dos idosos com a finalidade de assegurar-lhes sua permanência no meio e sociedade em que vivem, desempenhando suas atividades de maneira independente.
- A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) intuito de reintegrar o sujeito à sociedade, com enfoque na reinserção social dos usuários através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários, além de ofertar suporte à saúde mental na rede básica.
- Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde.
- Rede de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- Alguns avanços e desafios dentre todas as ações e serviços de saúde implementados nas duas últimas décadas são os programas especiais como assistência terapêutica na DST/AIDS, cirurgia bariátrica, doação de órgãos/transplantes.



- 1 Entendemos que há várias áreas estratégias de atuação, quais são:
 - a) () Os modelos assistenciais alternativos, sanitários, médico privatista e vigilância em saúde.
 - b) () Saúde da criança, do adolescente e do jovem, da mulher, do homem.
 - c) () Saúde da criança, do adolescente e do jovem, da mulher, do homem, do idoso e saúde mental.
 - d) () Somente a saúde da criança, do adolescente e do jovem.

- 2 Com relação ao Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC), assinale V para verdadeiro e F para falso sobre seus objetivos:
 - () Faz o acompanhamento esporádico do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 15 anos de idade.
 - () Diminuir a morbimortalidade de crianças de 0 a 5 anos de idade.
 - () Favorecer o desmame precoce e não promover o aleitamento materno e orientação alimentar para o desmame.
 - () Busca identificar os danos, riscos, necessidade e determinantes do crescimento e do desenvolvimento infantil, mas não faz o acompanhamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F – V – V.
 - b) () F – V – F – F.
 - c) () F – V – F – V.
 - d) () V – F – F – V.
-
- 3 Sobre os critérios para a realização da cirurgia bariátrica. Assinale a alternativa verdadeira:
 - a) () Obesidade estável há pelo menos dois anos.
 - b) () Tratamento clínico prévio sem acompanhamento regular e duração mínima de cinco anos, mas considerado eficaz.
 - c) () Índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 20 kg/m² ou IMC entre 15 e 29,9 kg/m².
 - d) () Possuir comorbidades (orgânicas ou psicossociais) desencadeadas ou agravadas pela obesidade e que ameacem a vida.

- 4 De acordo com o que você estudou neste tópico, as características a seguir fazem referência a que CAPS:

Utilizado em serviços de médio porte, com cobertura a municípios com mais de 50.000 habitantes e clientela de adultos com transtornos mentais severos e persistentes. Possui equipe mínima de 12 profissionais, entre profissionais de nível médio e nível superior e capacidade para o acompanhamento de cerca de 360 pessoas por mês e tem funcionamento durante os cinco dias úteis da semana.

A informação corresponde à qual sigla, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () CAPS II.
- b) () CAPS I.
- c) () CAPS III.
- d) () CAPSad.

PLANEJAMENTO DE SAÚDE NO SUS

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico estudaremos princípios do SUS: a descentralização e a regionalização da saúde. Iremos conhecer as Normas Operacionais Básicas (NOB), o Plano Diretor Municipal (PDM) e suas características, funcionamento, objetivos, e formas de organização. Em seguida entenderemos o Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS e os Instrumentos básicos de seu planejamento. Na sequência entenderemos que Programação Pactuada e Integrada possui uma estruturação a partir das redes de serviços regionalizadas seguindo os dispositivos de planejamento, programação e regulação chamada de “redes funcionais” com a finalidade de garantir para a população o acesso em todos os níveis de atenção à saúde estando coerente com o processo global de planejamentos. Aprenderemos sobre o financiamento do sistema público de saúde e por fim, conheceremos como foi a criação da ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar e seu funcionamento, regulamentação e seus meios de comunicação.

Este tópico será dividido em cinco itens. No primeiro, “Descentralização e regionalização da Saúde, Normas de Operacionais Básicas (NOB), Plano Diretor Municipal (PDM)”, apresentaremos seu desenvolvimento, definição e características. No segundo item será discutido sobre o “Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS e Instrumentos básicos de Planejamento do SUS”, detalhando toda a sua importância. No terceiro item conheceremos tudo o que diz respeito às “Pactuações e Programações, o (PPI)”; já no quarto item entenderemos a origem e o funcionamento do “Financiamento do Sistema Público de Saúde”. E por fim, no último item, conheceremos criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sua importância e suas competências.

2 DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE, SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS – PLANEJASUS

Ao iniciarmos nosso aprendizado, caro acadêmico, vamos conhecer como está o desenvolvimento de um dos princípios e diretrizes básicos do SUS, a descentralização, como vimos na Unidade 2, Tópico 1. Este princípio está evoluindo e se concretizando ao longo da trajetória do SUS, tendo como um dos fatores essenciais, a cooperação entre os três níveis de governo, que sinalizam ter superado e entendido que a competição e a tensão gerada no processo de descentralização não contribuíam para o avanço. Esse entendimento resultou

na fluidez no andamento do processo apoiado pela exigência da população tornando-se possível visualizar certa eficácia na construção da descentralização (OPAS, 2002).



Talvez, você, acadêmico, esteja se questionando e tentando entender como foi essa mudança, essa transição do poder de decisão, realizada de forma centralizada, suplantando para uma sistemática completamente oposta à convencional, a descentralização da gestão e das políticas de saúde do país? É o que tentaremos responder a seguir.

A descentralização da gestão e das políticas de saúde fazem parte dos princípios e diretrizes do SUS e são mais organizativos entre todos os demais princípios, também foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, regulamentada pelas Lei nº 8.080 e Lei nº 8.142 de modo integrado com as esferas nacional, estadual e municipal, em que ficou determinado que o poder, as competências e as responsabilidades seriam distribuídos entre as três esferas governamentais, tendo como prioridade a prestação de serviços muito mais eficiente, com qualidade e a intensificação, fiscalização e o controle colocando mais um princípio do SUS em ação que é a participação da sociedade nas questões da gestão no setor da saúde (SPEDO et al., 2009). A Constituição de 1988 definiu um novo cenário para o sistema de saúde, um sistema federalista cooperativo, que estimulava o processo de descentralização político-administrativa para as instâncias de governo (SPEDO et al., 2009).

Para fins de melhor entendimento, vamos conceituar a palavra descentralização dentro do contexto político. Dessa maneira, significa entendê-la como um processo de cedência de poderes políticos administrativos e fiscais para setores subnacionais do governo, ou seja, permitir que as competências de decisão sejam tomadas dentro de todas as esferas governamentais existentes no país e não mais o poder e as responsabilidades centradas em uma única esfera, reconhecendo o estado e principalmente os municípios como parte competentes do federalismo (sistema fundamentado na distribuição territorial de poder e autoridade entre as instâncias governamentais) e que cabia sim, aos municípios, gerir a saúde de sua população. Assim, o estado e os municípios foram incluídos e participaram da redistribuição do poder de decisão e gestão recebendo recursos da União (LAVRAS, 2011).

A descentralização tem por objetivo fortalecer e reconhecer o mérito dos executivos subnacionais, redefinir suas competências no gerenciamento das políticas de saúde e ainda delegar poder decisório e recursos financeiros para a gestão de prestadores (LIMA et al., 2012). E ainda almejam, com a autonomia, aprimorar a eficácia e os mecanismos de prestação de contas nas políticas públicas,

considerando o modelo nacional e contemplando os interesses territoriais do país. E é nesse contexto de convergência geográfica que está a maior complexidade de prestação de serviços, em razão das múltiplas realidades e diferenças de cada região. Assim, além da descentralização de poder, há a necessidade de estruturar combinações regionais de atenção à saúde que não interferem na gestão, mas que estabelecem interdependência entre os governos (LIMA et al., 2012).

Entendemos, caro acadêmico, que com a implantação da descentralização, a regionalização, que também configura um dos princípios do SUS, é colocada em prática, e percebemos que esse princípio é um processo político regular das relações firmadas entre múltiplos atores no cenário social, incluindo governos, organizações e o próprio cidadão. A regionalização dentro de seu território traça estratégias, desenvolve instrumentos de planejamento, gestão, regulação e recursos da sua rede de ações e serviços (LIMA et al., 2012).

O Ministério da Saúde, por meio de portarias, regulou esses dois processos, instituindo Normas Operacionais Básicas (NOB), sendo um instrumento institucional normativo, que ao longo do tempo foram complementados e substituídos, seguindo foco de continuidade, sempre decidida por meio de inúmeros debates nas três esferas governamentais, negociado e pactuado na tripartite e aprovado pelo Conselho nacional de Saúde. Iniciaram com quatro normas (NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/93, NOB-SUS 01/96, NOAS 01/2001) com os seguintes objetivos: normatizar o SUS; reorientar e aprofundar a implantação do SUS; regular as relações entre os gestores; definir novas estratégias, prioridades, diretrizes e movimentos táticos operacionais (LIMA et al., 2012). Em 2001 foi reformulada, trocando de nome para melhor abranger, tornando-se Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS), instituída e incorporada no Pacto pela Saúde em 2006 (LIMA et al., 2012).

A seguir, caro acadêmico, faremos uma breve conceituação de cada NOB:

NOB-SUS 01/91: Ainda inserida na gestão centralizada, o INAMPS, que foi extinto somente em 1993. Os estados já assumiam a gestão baseado no SUDS, todos eram prestadores de serviços. Trabalhavam com conselhos de saúde, fundos de saúde, consórcios intermunicipais, relatório de gestão, programação e orçamentação, planos de aplicação e prestação de contas. O repasse era condicionado à produção, financiamento centralizado, irregular e sem compensação.

NOB-SUS 01/93: Iniciam as mudanças, descentralização e municipalização da gestão, habilita os municípios como gestores, estabelecendo a terceira gestora do SUS. Criação das Comissões Intergestores Bipartites (CIBs estadual) e Tripartites (CTI nacional), tendo como finalidade a negociação, articulação, integração e pactuação entre os gestores. Possui modelo desigual de financiamento.

NOB-SUS 01/96: Estabelecem duas novas formas de habilitação nos municípios, a gestão plena da atenção básica (GPAB) e a gestão plena do sistema municipal (GPSM) e em nível estadual, a gestão avançada do sistema estadual e a gestão plena

do e sistema estadual. E os municípios que ainda não se habilitaram permanecem como prestadores de serviços. Esta normativa determinou os repasses específicos, os “pisos” dos recursos, piso da atenção básica (PAB), o piso básico para vigilância sanitária (PBVS) e também os “tetos” financeiros para a assistência (TFA), teto financeiro da Vigilância Sanitária (TFVS), teto de financiamento para as ações de epidemiologia e de controle de doenças (TFECD).

NOAS-SUS 01/2001: Esta normativa passou por reformulação e estabelece os tipos de gestão, a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPABA) e a Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM) onde instituíram novas estratégias para a descentralização, sendo criado o Plano Diretor de cada município (PDM), e atualização dos critérios para a habilitação dos municípios, e a ampliação das ações básicas, incluindo: controle da hipertensão arterial, tuberculose, diabetes, saúde da criança, da mulher e da saúde bucal, e a eliminação da hanseníase, assim como foi estudado no Tópico 1 desta unidade.



Acadêmico, você sabe o que é o Plano Diretor Municipal (PDM)? É um instrumento de planejamento e gestão dos municípios e prefeituras, de alta relevância para ambos, deve ser compatível com os regulamentos de ordem superior, a Constituição Federal, considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade (CIDADES, 2004). E deve conter: LEI nº 10.257:

Art. 42: I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei; II – disposições requeridas pelos Arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; III – sistema de acompanhamento e controle (BRASIL, 1988).

Assim, caro acadêmico, a descentralização vem sendo construída juntamente com o SUS ao longo do tempo, sendo aprimorado e evoluindo com as relações intergovernamentais, trabalhando para superar os problemas e as dificuldades com as desigualdades, tentando fortalecer sua lógica territorial, ampliando o processo de planejamento para poder satisfazer as necessidades de saúde, investindo em formulações de políticas setoriais com desenvolvimento estimado a médio e longo prazo (REZENDE; ULTRAMARI, 2007).

Caro acadêmico, dando continuidade ao nosso estudo, passaremos agora para o entendimento do Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS.

3 SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS – PLANEJASUS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO DO SUS

Caro acadêmico, você estudou na Unidade 2, Tópico 2, a definição de Sistema de Planejamento do SUS, e entendemos que este sistema, além de ser uma exigência legal, corresponde a uma incumbência gestora para estabelecer a unicidade e os princípios do SUS, e profere as competências de cada gestor diante das esferas governamentais associados à saúde da população em seu território integrando em uma organização sistemática. Sua maior responsabilidade é construir, idealizar, planejar as governanças das atividades de saúde do SUS, desde o município ascendo até a esfera nacional considerando a autonomia de cada ente federado. Um dos seus maiores desafios é o cumprimento da agenda desses macroprocessos de gestão e a realização compondo uma integração entre os entes federados e cada região (BRASIL, 2016).

O planejamento do SUS, também denominado **PlanejaSUS**, foi discutido e formulado considerando alguns conceitos ideológicos como pontos essenciais. Entre eles estão o federalismo, a organização territorial e suas características e funcionamento.

Federalismo é um modelo político que faz associação entre as pequenas comunidades políticas dentro de um sistema maior, ordenando o poder e os recursos dessas comunidades frente à União, protegendo-as quanto a sua existência e autoridade coletiva nas esferas nacionais e subnacionais, partilhando a tomada de decisões e da execução das ações governamentais (BRASIL, 2016). Cada regime federativo estabelece as suas características essenciais, o que pode variar de país para país. São exemplo de federações (estados, províncias, *Länder* (referente a todos os estados federados, utilizado na Alemanha), territorial nacional, distrito federal, capital federal, administrações territoriais, regiões, comunidades culturais, entes, cantões, municípios, emirados, regiões autônomas cidades federais, dependência federal, repúblicas, fronteiras) (BRASIL, 2016).

No Brasil, o modelo federativo adotado é o de organização político-territorial, desde a Proclamação da República em 1889, passando pela República Velha (1889-1930 eram unidades federadas – as províncias), de 1930-1945 foi Estado Novo, de 1946-1964 as competências e a autonomia passaram para Estados, em 1964 passou por um regime ditatorial centralizador, evoluindo com influência da democracia a partir dos anos 80, com a efetivação das eleições diretas, até conseguir um modelo de federação descentralizado, instituído pela Constituição Federal de 1988, vigente até os dias atuais (BRASIL, 2016).

O modelo de federação do Brasil é caracterizado em três esferas como estamos estudando, cada uma estabeleceu sua autonomia com suas competências definidas para gerir suas políticas públicas, no propósito de constituir um

controle democrático e um Estado descentralizado compartilhando entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, formando uma estrutura cooperativista, e suas competências foram divididas em: competências exclusivas, privatistas, concorrenciais e residuais (BRASIL, 2016).

Veja a seguir, acadêmico, a distribuição federativa brasileira de competências de cada esfera:

UNIÃO: Formular, apoiar a implantação e avaliar as políticas prioritárias em âmbito nacional; Elaborar o planejamento estratégico do SUS; Coordenar sistemas de alta complexidade; Coordenar sistemas de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária; Formular a política nacional de produção de insumos e equipamentos; Promover a descentralização de ações e serviços de saúde; Estabelecer e coordenar os sistemas nacionais de auditoria e ouvidoria (BRASIL, 2016).

ESTADOS: Promover a articulação sistêmica, o planejamento e coordenação regional das políticas, ações e serviços de saúde; monitorar e avaliar as redes regionalizadas e hierarquizadas no SUS; elaborar e sistematizar os planos de médio e longo prazo no âmbito estadual; fornecer apoio técnico e financeiro aos municípios nas ações de descentralização; coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros (BRASIL, 2016).

MUNICÍPIOS: Planejar, organizar e avaliar a provisão local de serviços de saúde; gerenciar as unidades públicas de saúde; executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador; implantar a política de insumos e equipamentos em saúde; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde (BRASIL, 2016).

COMPETÊNCIAS COMUNS: Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população; administrar recursos orçamentários e financeiros; estabelecer padrões e mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde; organizar e coordenar sistemas de informação; elaborar e atualizar os planos de saúde; relatório de gestão, relatório detalhado do quadrimestre anterior (RDQA) e Programação Anual de Saúde (PAS); elaborar normas para regular as atividades dos serviços privados de saúde; fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos; elaborar proposta orçamentária (Inciso X da Lei nº 8.080, de 1990) (BRASIL, 2016, p. 40).

Ademais, acadêmico, entendemos como é realizado a distribuição das competências em todas as esferas. Precisamos entender que essa distribuição é uma descentralização fomentada dentro do planejamento e programação da saúde no SUS, também conhecido como **GESTÃO DO SUS**, que é aplicado nas diferentes áreas dos saberes da política, administração e economia para o planejamento da saúde, buscando uma melhoria na organização das atividades, com consequentes resultados positivos, redução de conflitos e incertezas. Planejamento implica definir metas, objetivos, programações, ações, atividades regulatórias para execução na prática diária dos gestores, para tanto que essas são estabelecidas, formuladas, planejadas (BRASIL, 2016).

No Planejamento do SUS existem princípios e diretrizes normativas, as quais deverão seguir segundo Brasil (2016, p. 85):

Princípio 1: O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua.

Princípio 2: O planejamento no SUS deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental geral.

Princípio 3: O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestores regionais, bipartite e tripartite.

Princípio 4: O planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a gestão do SUS.

Princípio 5: O planejamento deve ser ascendente e integrado.

Princípio 6: O planejamento deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde.

Princípio 7: O planejamento deve partir das necessidades de saúde da população.



Quais são os instrumentos básicos de Planejamento do SUS? É o que descobriremos a seguir, acadêmico!

Na construção do planejamento do SUS fez-se necessário a utilização de alguns instrumentos para nortear sua elaboração, sendo divididos numa visão geral em: Plano de Saúde, Programações Anuais e Relatório de Gestão, sendo os mais específicos o planejamento e orçamento de governo, as leis de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual nas esferas, utilizadas como base de avaliação e monitoramento aos entes federados. Para a formulação destes instrumentos, alguns mecanismos de apoio são indispensáveis, como:

Análise da situação de saúde com base no mapa da saúde: é a identificação e priorização dos problemas de saúde de um determinado território);

Mapa da Saúde: é uma ferramenta eletrônica sanitária que disponibiliza a descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos e de ações e serviços de saúde do SUS. Permite o entendimento do georreferenciamento de informações que incluem os seguintes assuntos, de acordo com Brasil (2016, p. 119):

- estrutura do sistema de saúde;
- redes de atenção à saúde;
- condições sociossanitárias;
- fluxos de acesso;
- recursos financeiros;
- gestão de trabalho e da educação em saúde;
- ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão.

Definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores: o resultado do mapa possibilita uma visão ampla das necessidades de saúde da população. A partir daí é possível definir as diretrizes e os objetivos, que norteiam as metas e os indicadores.

Plano de Saúde: este instrumento é a prioridade do planejamento para implantação de todas as iniciativas no setor da saúde e todas as esferas governamentais da gestão do SUS para um período de quatro anos. É o Plano de Saúde que orienta a elaboração do planejamento e orçamentos do governo referente à saúde.

Programação Anual de Saúde: é o instrumento que operacionaliza o que foi elaborado no Plano de Saúde e prevê a destinação dos recursos orçamentários para ser executados, sendo detalhadas as ações e serviços do SUS.

Relatório de Gestão: este instrumento expressa os resultados obtidos na programação anual de saúde, é um instrumento de prestação de contas das ações do plano de saúde por parte dos gestores, que é analisado pelo Conselho de Saúde até dia 30 de março de cada ano, que emitem um parecer conclusivo e este é colocado à disposição para o acesso público.

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior: este instrumento faz o acompanhamento e o monitoramento da execução da programação anual de saúde.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária: este instrumento realiza a monitorização das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Saúde. (BRASIL, 2016).



Você pode aprofundar seus conhecimentos, acadêmico, lendo este Manual de Planejamento do SUS na íntegra. Disponível no link: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento_atual.pdf>. Esse é um assunto muito amplo e não se esgota aqui seu conteúdo. E de agora em diante iniciaremos nosso aprendizado sobre as Pactuações e Programações do SUS.

4 PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (PPI)

A PPI é uma ferramenta inserida no processo de planejamento do SUS, é uma nova lógica que nasceu junto com a Política Nacional de Regulação do SUS. Está inserida nos Pactos pela Saúde, com a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. Sua implantação ocorreu entre o período de 2001 e 2005, em sintonia

com as diretrizes das NOAS, numa tentativa de viabilizar o acesso universal e equânime para os serviços de saúde (BRASIL, 2006). A **PPI** foi estruturada a partir das redes de serviços regionalizadas seguindo os dispositivos de planejamento, programação e regulação chamada de “redes funcionais” com a finalidade de garantir para a população o acesso em todos os níveis de atenção à saúde, estando coerente com o processo global de planejamentos, considerando os acordos prévios inseridos no Plano de Saúde dos estados e municípios. “Na **PPI** são definidas e quantificadas as ações de saúde para população residente em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde”. (BRASIL, 2006, p. 13).

Os principais objetivos da PPI são, de acordo com Brasil (2006, p. 13):

Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade.
 Orientar a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento às necessidades de saúde da população.
 Definir que os limites financeiros para a assistência de média e alta complexidade de todos os municípios serão compostos por parcela destinada ao atendimento da população do próprio município em seu território e pela parcela correspondente à programação das referências de outros municípios.
 Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações de assistência à saúde.
 Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
 Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde.
 Possibilitar a transparência dos pactos intergestores resultantes do processo de programação pactuada e integrada da assistência e assegurar que estejam explicitados no Termo de Compromisso para Garantia de Acesso, conforme anexo1 da portaria GM nº 1097 de 22 de maio de 2006.

As pactuações possuem eixos orientadores no processo da PPI dispostas em: Centralidade da Atenção Básica; Aberturas Programáticas; Integração das Programações; Composição das fontes de recursos financeiros a serem programados e Processo de Programação e Relações Intergestores.

- **Centralidade da Atenção Básica:** reconhece a importância da integração do atendimento de urgência e emergência aos demais segmentos da rede de assistência, possibilitando um atendimento sistemático. A programação das ações é orientada pelas prioridades elencadas pelos gestores, observando as definições do Pacto pela Vida, sendo que as prioridades estaduais ou regionais podem ser incorporadas numa pactuação local.

São seis as áreas pactuadas dispostas por prioridades: saúde do idoso; controle do câncer do colo do útero e da mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.

A **PPI** segue algumas áreas estratégicas definidas pelo Ministério da Saúde, como já estudamos no Tópico 1 desta unidade, sendo elas: saúde da criança e do adolescente; saúde do homem e da mulher; saúde do idoso; saúde mental; saúde da pessoa com deficiência; saúde do trabalhador; saúde bucal; urgências; meningite; malária; hepatites virais; hanseníase; tuberculose; DST/AIDS.

A **PPI** utiliza dentro da centralização da atenção básica, os parâmetros assistenciais de referências para a programação das ações de saúde nas seguintes áreas:

Saúde da mulher: pré-natal; planejamento familiar; câncer de colo uterino; câncer de mama.

Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento; doenças preveníveis; afecções respiratórias; asma; diarreia.

Saúde Ocular: triagem auditiva neonatal.

Saúde do Adolescente.

Saúde do Adulto: diabetes Mellitus; hipertensão arterial.

Saúde do Idoso.

Saúde Bucal: procedimentos coletivos e individuais.

Saúde Nutricional: desnutrição leve, moderada e grave.

Anemia.

Hipovitaminose A.

Obesidade em adultos e crianças.

Saúde do trabalhador: dermatoses ocupacionais, exposição a materiais biológicos, lesão de esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – LER/DORT; pneumoconioses; perdas auditivas induzidas por ruído – PAIR; exposição ao chumbo; exposição ao benzeno; intoxicação por agrotóxicos.

Saúde Mental: saúde mental na atenção básica; centros de atenção psicossocial; ambulatórios; desinstitucionalização; leitos integrais em saúde mental.

Urgências: demandas espontâneas e pequenas urgências; atendimento pré-hospitalar.

Hepatites Virais: hepatite B; hepatite C.

DST/AIDS: diagnóstico: sífilis em gestantes/parturientes, HIV em gestantes, HIV em parturientes, HIV na população geral; acompanhamento clínico em portadores HIV.

Hanseníase.

Tuberculose.

Meningite e Malária.

- **Abertura Programáticas:** níveis de agregação das ações de saúde que atende:
 - o **Atenção Básica e de Média Complexidade Ambulatorial:** segue os parâmetros e estratégias priorizadas pelo Ministério da Saúde.
 - o **Alta Complexidade Ambulatorial:** disposta em dois grupos:

Procedimentos com finalidade diagnóstica: Patologia clínica especializada: exames para diagnóstico e acompanhamento das hepatites virais, entre outros exames; radiodiagnóstico (neuroradiodiagnóstico e angiografias); medicina nuclear (sem densitometria); densitometria óssea; ressonância magnética; tomografia; radiologia intervencionista; hemodinâmica).

Procedimentos para tratamento clínico que compõem redes de serviços: nefrologia, oncologia, reabilitação, saúde do trabalhador, litotripsia (eliminação de cálculos renais), hemoterapia;

- o **Média Complexidade Hospitalar:** Nesse tipo, a programação é ascendente, os municípios programam as internações da sua população e se o caso doente não for contemplado no serviço de saúde do próprio município, será encaminhado para outros municípios que disponibilizem tal serviço:

Cirúrgicas.

Clínicas.

Cirurgias.

Obstétricas.

Pediátricas.

Clínicas: AIDS; cardiologia; clínica geral; dermatologia; geriatria; hansenologia; hematologia; nefrologia/uropatologia; neonatologia; neurologia; oncologia; pneumologia.

Outras especialidades: crônicos; psiquiatria; reabilitação; pneumologia sanitária.

Hospital dia: cirurgia; AIDS; fibrose cística; intercorrência pós-transplante; geriatria; saúde mental.

- o **Alta Complexidade Hospitalar:** Nesse caso a programação segue orientação de acordo com a distribuição de leitos do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) para os seguintes serviços: cardiologia; neurocirurgias; oncologia e traumatologia.

As internações de alta complexidade são programadas sob a lógica descendente, definidas a partir de municípios que realizam o tipo específico de atendimento, mantendo conforme a regionalização.

Leitos Complementares: As programações das internações para leitos complementares também seguem o CNES, de forma descendente por estarem concentradas em alguns polos, de acordo com a pactuação de cada região, sendo eles: UTI adulto; UTI infantil; UTI neonatal; Unidade intermediária; Unidade intermediária neonatal; Unidade de isolamento. Todas essas orientações, caro acadêmico, fazem parte da Abertura Programada.

- **Integração das Programações:** Em decorrência de certas resistências houve iniciativas isoladas de programação resultando em várias

programações, e o objetivo é possibilitar aos gestores a integração dessas programações, unindo as ações de vigilância e assistência para melhorar atender os principais agravos como: tuberculose, hanseníase, AIDS, sífilis congênita, meningite, hepatites virais e malária.

- **Composição das fontes de recursos financeiros a serem programados:** Os serviços de assistência à saúde devem ser financiados com recursos dos três níveis de governo, seguindo as modalidades de financiamento utilizadas pela programação:
 - o Cofinanciamento de serviços financiados globalmente (como no SAMU, hospitais de pequeno porte etc.).
 - o Recursos alocados para compra de serviços privados cobertos exclusivamente pelos tesouros municipais ou estaduais.
 - o Recursos dos tesouros estaduais ou municipais alocados para complementação de valores das s SIA (Sistema de Informação Ambulatorial) e SIH (Sistema de Informação Hospitalar).
 - o Outras modalidades de alocação como subsídios globais a serviços específicos (hospitais filantrópicos).
- **Processo de Programação e Relações Intergestores:** Este processo está dividido em subitens:
 - o Etapa Preliminar de Programação: o gestor estadual juntamente com os gestores municipais, define por fórum de Intergestores Bipartite a agenda de necessidades e prioridades do estado, as diretrizes gerais, o formato da proposta de regionalização, o levantamento das capacidades de cada município da região e faz uma macroalocação dos recursos financeiros federais e estaduais, definindo os recursos a serem programados pelos municípios e os recursos a serem utilizados na reserva técnica e para alguns incentivos permanentes de custeio.
 - o Etapa de Programação Municipal: aqui o gestor municipal define: A agenda de prioridades do município, a serem contempladas pela programação; as diretrizes da programação municipal; programação por distrito de saúde, se necessário; a macroalocação dos recursos financeiros municipais; o nível de agregação das aberturas programáticas para as ações de média complexidade ambulatorial não prevista nas áreas estratégicas; os parâmetros para a população residente no município, correspondentes aos níveis de agregação definidos nas aberturas programáticas.
 - o Pactuação regional (Intermunicipal/Intra e Interestadual): a pactuação regional não é considerada uma etapa e sim um pacto que estabelece que regiões formadas por municípios de mais de um estado, deverão participar

dos estados com aprovadas as respectivas CIBs, e os municípios envolvidos receberão a mediação do gestor federal. Os serviços não ofertados na região deverão ser discutidos e pactuados com as outras regiões, assim, os recursos pactuados e aprovados na CIB poderão ser transferidos para o custeio dessas ações e serviços de saúde.

- o Etapa de Consolidação da PPI Estadual: esta etapa serve para consolidar todos os processos que compõem os quadros da PPI estadual, com identificação dos recursos financeiros municipais. Nessa etapa, os municípios iniciam a programação intramunicipal, partindo para o processo de contratualização; os gestores devem implantar mecanismos de monitoramento, regulação e avaliação do processo assistencial que propicie os fluxos determinados. E ainda constitui o Processo de Programação e Relações Intergestores a atualização das Programações; a Consolidação das Programações Estaduais; a Periodicidade da Revisão Global da Programação Pactuada e Integrada.

FONTE: Adaptado de: <<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/DiretrizesProgPactuadaIntegAssistSaude.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

Para tanto, acadêmico, após conhecermos toda a estrutura da PPI, podemos dizer que é um instrumento de alta relevância para a efetivação e complementação do planejamento e compartilhamento da gestão do SUS, para o aperfeiçoamento das ações, para a conquista do acesso equânime da população em todos os níveis de assistência (MOLESINI et al., 2010). A seguir conheceremos mais um tema muito pertinentes do SUS que é o financiamento do Sistema Público de Saúde.

5 FINANCIAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e seu financiamento é de responsabilidade comum das três esferas de governo, assegurada pela Emenda Constitucional 29 (EC-29), que fixou nexo de receita dessas esferas, realizou a vinculação de recursos orçamentários da União, estados e municípios, para as despesas com as ações e serviços públicos de saúde, com a finalidade de permitir mais estabilidade aos recursos da saúde, idealizando aumento na participação das esferas subnacionais no financiamento do SUS (RIBEIRO et al., 2007).

A maior parte dos recursos da seguridade social em que a saúde está inserida é de competência da União Federal, em torno de 70% oriundos do Fundo Nacional de Saúde, e o restante do financiamento é viabilizada pelos fundos estaduais e municipais habilitados. Mesmo a esfera federal sendo a maior financiadora, há muitas expectativas junto à EC-29 de que os recursos estaduais e municipais aumentem significativamente (BRASIL, 2002).

Veja a seguir algumas das competências das esferas governamentais para o financiamento.

QUADRO 23 - COMPETÊNCIAS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS PARA O FINANCIAMENTO

Financiamento do SUS		
Federal	Estadual	Municipal
Representa maior parte dos recursos	Define as prioridades estaduais.	Garante a aplicação de recursos próprios.
Função redistributiva	Garante a alocação de recursos próprios, arrecadação de impostos, contribuições e taxas.	Estabelece critérios claros de aplicação de recursos federais, estaduais e municipais.
Busca a equidade na alocação	Define critérios precisos de alocação de recursos federais e estaduais entra as áreas da política e entre municípios.	
Define as prioridades nacionais e critérios de alocação entre áreas e entre estados		

FONTE: Adaptado de Brasil (2002)

O Sistema Público de Saúde brasileiro segue um modelo pluralista de financiamento, dividido em formas de organização de atenção à saúde e de fontes de financiamento, disposta em quatro vias de acesso populacional: **SUS** com acesso universal, gratuito, subsidiado por recursos públicos; Planos e seguros privados de saúde, de associação eletiva, patrocinado pelos recursos familiares ou de empregadores; Segmento de atenção aos servidores públicos, civis e militares de acesso restrito a essa clientela custeado pelos recursos públicos e contribuições dos próprios servidores, denominados “sistemas de clientela fechada”; e por fim o Segmento de provedores privados autônomos de saúde, denominados “pagamento particular”, onde o próprio indivíduo financia a sua saúde (RIBEIRO et al., 2007).

O cenário de incertezas levou à criação de novos impostos, como o Imposto Provisório sobre a Movimentação Financeira (IPMF) em 1994, posteriormente redefinida como Contribuição sobre a Movimentação Financeira (CPMF) em 1996, deixando de ser contribuição em 1998 e para solucionar este déficit, o Ministério da Saúde recorreu ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) o que gerou oneração para os próximos anos e a situação do financiamento da saúde viveu e vive situações críticas. Várias são as propostas na busca da estabilidade o que configura um dos maiores desafios do SUS atualmente (RIBEIRO et al., 2007). O financiamento do sistema de saúde é originado também de dois tipos de tributos os diretos e os indiretos. Os tributos diretos são: aqueles que têm maior peso no financiamento setorial são eles o IRPF, IPVA, IPTU e parte da CPMF. Já os tributos indiretos são: IPI, ICMS, ISS, COFINS (UGÁ; SANTOS, 2006).

Ademais, caro acadêmico, entendemos que as fontes de financiamento do sistema público de saúde ainda são extremamente frágeis, não apresentando um padrão de estabilidade, sempre trabalhando com flutuações intensas nas distribuições de recursos. E é possível compreender que o financiamento da saúde evoluiu muito ao longo da história, e que o sistema de saúde brasileiro faz uma mescla de quatro modelos de segmentos de seguridade social. Observa-se também a redistribuição dos recursos entre as três esferas governamentais numa perspectiva de aumentar a participação dos estados e municípios aumentando assim o financiamento (RIBEIRO et al., 2007).

Piola et al. (2012) sugere a situação do financiamento do sistema público de saúde, necessidade de debates e estudos aprofundados para melhorar o cenário financeiro da saúde, discutindo, principalmente, a definição de um único modelo de financiamento, estudar as tendências dos investimentos do setor privado, criar novas estratégias de fontes de financiamento, aprofundar a pesquisa sobre as prioridades e necessidades para a estruturação de um modelo efetivo de financiamento e favorecer as informações entre município e estado.

Finalizamos esse item entendendo que o financiamento do SUS faz parte do sistema de seguridade social setorial mediante Orçamento da Seguridade Social e dos Tesouros das três esferas governamentais, e que este sistema de financiamento vem sofrendo por ajustes macroeconômicos desde sua implantação, aliás, a saúde brasileira como um todo enfrenta arduamente o desafio melhorar seu financiamento, na busca de um estado de bem-estar universal, de caráter progressivo e de acesso igualitário, cientes de que há um longo caminho a ser percorrido (UGÁ; SANTOS, 2006). A seguir entenderemos como foi a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, quais suas competências, objetivos, quando surgiu e como funciona.

6 CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS)

O sistema de saúde brasileira é dividido em público e privado. O público representado pelo SUS, que utiliza subsídios públicos com a participação das esferas governamentais, articulando com outras áreas de governo e também conta com os serviços privados conveniados ou contratados, e o sistema privado, que é dividido em dois setores, o subsector saúde suplementar e o subsector liberal clássico. O liberal clássico compreende os serviços particulares autônomos, os profissionais liberais que possuem clientela própria específica com um sistema de captação informal, com definições de tratamento e remuneração elaborados diretamente pelos profissionais (BRASIL, 2007).

Podemos entender por Saúde Suplementar os serviços financiados pelos planos e seguros de saúde que estão inseridos nesse grupo de classificação do subsistema privado. O setor que gerencia os planos de saúde é denominado como “suplementar”, que muitas vezes deveria ser denominado de “complementar” porque o sistema privado complementa o sistema público com a cobertura

de alguns serviços (PIETROBON et al., 2008). O Brasil segue um modelo de regulação para o setor saúde suplementar, um modelo de assistência à saúde com a finalidade de preservar a competitividade do mercado e corrigir as distorções quanto às seleções de riscos (PIETROBON et al., 2008). Veja na figura a seguir a evolução do modelo de seguridade social do país.

FIGURA 7 - EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE SEGURIDADE SOCIAL DO PAÍS

IAPs → CASSI → INPS → SINPAS → INAMPS → SUS

FONTE: Pietrobon et al. (2008)

Até 1988, essa regulação não tinha cunho legal, o que se fazia necessário, para reparar e debelar os equívocos nos planos como mensalidades abusivas e exclusões de atendimento, e assim para preservar os beneficiários dos planos de saúde foi instaurada a Lei nº 9.656/98, só que essa lei sozinha não resolveu todos os problemas e outras ações de regulamentação foram incorporadas, como a Medida Provisória que passou por várias republicações e agora atende pelo nº 2177-44, mais os reforços com a implantação do SUS com a Lei nº 8.080/90, somado a Lei nº 9.961/00, foi criado a **Agência Nacional de Saúde (ANS)** que lhe conferiu as atribuições de regular o setor, configurando um marco legal da regulação setorial, e a partir daí os esforços foram para consolidá-la (PIETROBON et al., 2008).

Então, caro acadêmico, a **ANS** é uma agência reguladora, uma autarquia atrelada ao Ministério da Saúde, e tem como principal função controlar o setor de planos de saúde do país, com administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, com competência institucional para promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais e suas relações com prestadores e consumidores, controlar e fiscalizar os segmentos, as ações e medidas do governo, criação e aplicação de normas de penalidades para contribuir com o desenvolvimento das ações de saúde no país (BRASIL, 2000). A ANS é estruturada da seguinte forma: a Diretoria Colegiada tem instância máxima de decisão, conta também com Procuradoria, Corregedoria e Ouvidoria, além de unidades especializadas, imbuídas de diferentes funções, de acordo com o regimento interno (BRASIL, 2000).

A ANS é formada por cinco diretorias:

Diretoria de Gestão: cuida de todo o funcionamento da ANS, a gestão pessoal, financeira e patrimonial.

Diretoria de Desenvolvimento Setorial: responsável pela operacionalização do ressarcimento; pelo desenvolvimento e integração dos sistemas de informação e pela interface com o SUS.

Diretoria de Fiscalização: é responsável pelo *call center*, pela interface com os órgãos de defesa do consumidor e as ações de fiscalização.

Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras: é responsável pela autorização de funcionamento, registro e monitoramento das operadoras; pela operação dos regimes especiais (Direção Fiscal e Técnica), e do processo de liquidação extrajudicial.

Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos: é responsável pelo registro dos produtos, monitoramento da assistência prestada, instrução dos processos de alegação de doença ou lesão pré-existente, acompanhamento dos programas de promoção e prevenção, e ainda pelo monitoramento de preços e notas técnico atuariais e autorização dos reajustes anuais dos planos individuais e, eventuais processos de revisão técnica (BRASIL, 2000).

A ANS desenvolveu e aprimorou diversos instrumentos para a geração e difusão de informações relativas ao setor de Saúde Suplementar, com o objetivo de instituir canais de comunicação com os segmentos do mercado para esclarecimento de dúvidas específicas e receber denúncias dos beneficiários. Entre eles estão: o disque ANS, Central de Atendimento (08007019656), o portal na internet <<http://www.ans.gov.br/>> e o correio eletrônico institucional, bem como os meios de comunicação convencionais, cartas, telefones, fax e atendimento individual, além de criar núcleos regionais de fiscalização, os NURAFs, espalhados pelo país para melhorar atender. A ANS tem sede no Rio de Janeiro, e o gabinete da presidência fica localizado em Brasília.

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, vimos que:

- As competências de decisão são tomadas dentro de todas as esferas governamentais.
- A regionalização dentro de seu território traça estratégias, desenvolve instrumentos de planejamento, gestão, regulação e recursos da sua rede de ações e serviços.
- As Normas Operacionais Básicas (NOB) são um instrumento institucional normativo, composta de quatro normas (NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/93, NOB-SUS 01/96, NOAS 01/2001).
- O Plano Diretor Municipal é um instrumento de planejamento e gestão dos municípios e prefeituras, de alta relevância para ambos.
- O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS e seus Instrumentos básicos auxiliares.
- O Federalismo é um modelo adotado no Brasil que determina a organização político-territorial, caracterizado nas três esferas e suas competências comuns.
- No planejamento do SUS existem sete princípios e diretrizes normativas.
- Os instrumentos que auxiliam no planejamento do SUS:
 - o Análise da situação de saúde.
 - o Mapa da Saúde.
 - o Definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores.
 - o Plano de Saúde.
 - o Programação Anual de Saúde.
 - o Relatório de Gestão.
 - o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior.
 - o Relatório Resumido de Execução Orçamentária.
- A Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde (PPI) é uma ferramenta inserida no processo de planejamento do SUS.

- As pactuações possuem eixos orientadores no processo da PPI dispostas em:
 - o Centralidade da atenção básica.
 - o Aberturas programáticas.
 - o Integração das programações.
 - o Composição das fontes de recursos financeiros a serem programados.
 - o Processo de programação e relações intergestores.
- O Processo de Programação e Relações Intergestores é subdividido em: Etapa Preliminar de Programação; Etapa de Programação Municipal; Pactuação Regional (Intermunicipal/Intra e Interestadual) e a Etapa de Consolidação da PPI Estadual.



1 (Secretaria de Saúde do DF – cargo de Enfermagem (2003)) Associar as colunas com informações sobre as Normas Operacionais Básicas do SUS e marcar a alternativa CORRETA:

- 1 NOB 01/91 () Define o Plano Diretor de Regionalização.
- 2 NOB 01/93 () Cria as Comissões Intergestores Tri e Bipartite.
- 3 NOB 01/96 () Condiciona repasses financeiros a Conselho, Fundo e Plano de Saúde.
- 4 NOAS 2001 () Define instrumentos para a programação regionalizada.

- a) () 1 – 2 – 3 – 4.
- b) () 4 – 2 – 3 – 1.
- c) () 2 – 3 – 4 – 1.
- d) () 3 – 2 – 4 – 1.

2 A ANS é formada por cinco diretorias: Assinale a alternativa verdadeira:

- a) () Diretoria de Gestão, Diretoria de Desenvolvimento Setorial, Diretoria de Fiscalização, Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras e Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos.
- b) () Diretoria de Abastecimento, Diretoria de Desenvolvimento Geral, Diretoria de Fiscalização, Diretoria Habilitação Veicular e Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos.
- c) () Diretoria de Gestão, Diretoria de Desenvolvimento Setorial, Diretoria de *Marketing*, Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras e Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos.
- d) () Diretoria de Gestão, Diretoria de Desenvolvimento Setorial, Diretoria de Fiscalização, Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras e Diretoria de Adjunta de Coordenação Educacional.

3 Quais são os instrumentos que auxiliam no planejamento do SUS?

- a) () Análise da situação da descentralização; Mapa da Saúde; Definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores; Plano de Saúde; Programação Anual de Saúde; Relatório de Gestão; Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior; Relatório Resumido de Execução Orçamentária.
- b) () Análise das pactuações; Mapa da Saúde; Definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores; Plano de Saúde; Programação Anual de Saúde; Relatório de Gestão; Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior; Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

- c) () Análise da situação de saúde; Mapa da Saúde; Definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores; Plano de Saúde; Programação Anual de Saúde; Relatório de Gestão; Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior; Relatório Resumido de Execução Orçamentária.
- d) () Análise da situação de doença; Mapa da Saúde; Definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores; Plano de Saúde; Programação Anual de Saúde; Relatório de Gestão; Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior; Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

4 Quais são as seis áreas de pactuações? Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () Saúde do idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, esquistossomose, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- b) () Saúde do idoso; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, febre tifoide tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- c) () Saúde do idoso; controle do câncer do colo do útero e da mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, lúpus eritematoso sistêmico, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.
- d) () Saúde do idoso; controle do câncer do colo do útero e da mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica.

PRINCIPAIS INDICADORES DA SITUAÇÃO DE SAÚDE

1 INTRODUÇÃO

Conhecer as características da população onde se atua e os fatores de risco e os determinantes do processo saúde-doença é importante na atenção à saúde para subsidiar o planejamento, a organização, a tomada de decisões e a avaliação de ações e serviços. Assim os sistemas de informação colaboram para que os dados se transformem em informação e, em seguida, em conhecimento para a equipe de saúde.

Este tópico será dividido em sete itens. Cada item abordará um Sistema de Informação (SIS) entre eles: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), e por fim, Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA), definindo-os e caracterizando-os.

2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O sistema de informação em saúde pode ser entendido como um instrumento para adquirir, organizar e analisar dados necessários à definição de problemas e riscos para a saúde, avaliar a eficácia, eficiência e influência que os serviços prestados possam ter no estado de saúde da população, além de contribuir para a produção de conhecimento acerca da saúde e dos assuntos a ela ligados (BRANCO, 1996, p. 68).

Para Barros e Chaves (2003, p. 41):

O processo de descentralização da Saúde tem ampliado a utilização dos sistemas de informação como instrumentos de planejamento e gestão. A consulta a bancos de dados sobre desenvolvimento social (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M e censo) e saúde (Sistemas de Informação em Saúde – SIM, SINASC, SINAN, SAI, SIA-SUS, SIAB etc.) permite recuperar informações relacionadas à esfera municipal que são importantes na implementação de políticas sociais e programas de saúde.

2.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS (SINASC)

O Ministério da Saúde implantou o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) de forma lenta e gradual em todas as unidades da Federação e em muitos municípios já apresenta um número de registros maior do que o publicado pelo IBGE com base nos dados de cartórios de Registro Civil (JORGE et al., 1993). O SINASC utiliza como instrumento de coleta de dados a Declaração de Nascido Vivo (DN) que seria um “documento individualizado e padronizado em nível nacional, preenchida nos estabelecimentos de saúde para aqueles nascimentos vivos ali ocorridos ou para aqueles que, ocorridos em outro local, tenham tido atendimento imediato nessa instituição e, ainda, para os nascimentos domiciliares, nos Cartórios de Registro Civil, no momento do registro” (JORGE et al., 1993, p. 3).

Além de seu objetivo na obtenção do perfil epidemiológico, as informações também estão registradas na Declaração de óbito (DO), tornando possível a obtenção de coeficientes específicos de mortalidade infantil. “O processamento dos dados e análise de consistência do SINASC são de responsabilidade dos órgãos estaduais de estatística (Secretarias Estaduais de Saúde ou Fundações das Secretarias de Planejamento), sendo enviados, posteriormente, ao Ministério da Saúde para a consolidação dos dados em nível nacional” (JORGE et al., 1993, p. 3).



O endereço a seguir, mostra o manual de Instruções para o Preenchimento da Declaração de Nascidos Vivos que tem como objetivo fornecer instruções para o preenchimento do documento padrão do SINASC: <http://www.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/88/2015/11/inst_dn.pdf>.

A Coordenação Geral de Análise de Informação em Saúde (CGAIS) orienta os profissionais que estão envolvidos com a operacionalização do SINASC. Disponibiliza procedimentos do sistema, incluindo fluxo dos documentos e rotinas decorrentes do processamento dos dados, bem como as diversas atribuições de cada instância (federal, estadual e municipal).



Nesse endereço *on line*, você consegue visualizar como se entram com esses dados na Datasus: <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/eventos-v/sinasc-sistema-de-informacoes-de-nascidos-vivos>>. Veremos no quadro a seguir algumas características do SINASC.

QUADRO 24 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SINASC

Criado	1990.
O que é?	“Esse é um sistema alternativo ao do Registro Civil, que possibilita a análise dos nascimentos vivos segundo novas e importantes variáveis (peso ao nascer, duração da gestação, grau de instrução, Índice de Apgar no primeiro e quinto minutos), acrescidas daquelas provenientes das informações do Registro Civil, por força de lei (Lei nº 6.015)”. (JORGE et al., 1993, p. 3).
Objetivo	- Reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo o território nacional.
Organização	Em três vias com finalidades diferentes: - A primeira destina-se aos órgãos regionais das Secretarias Estaduais de Saúde e tem a finalidade estatística. - A segunda destina-se à família para posterior apresentação ao Cartório, no momento do registro do nascimento. - A terceira também destinada à família, foi concebida com a finalidade de ser entregue ao serviço de saúde no momento da primeira consulta da criança para que ele tenha acesso a informações fidedignas relativas àquele nascimento.

FONTE: Adaptado de (JORGE et al., 1993)

2.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM)

Considera-se, acadêmico, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) como um dos mais antigos dos sistemas de informação em saúde de abrangência nacional do Brasil, com modificações e aprimoramentos até hoje (SENNA, 2009). “A base de informações do SIM é a Declaração de Óbito (DO), que possui um modelo único padronizado para todo o país. Este modelo é o mesmo tanto para óbitos em geral quanto para óbitos fetais. Segundo a legislação brasileira, a DO deve ser preenchida por médicos e, nos casos de morte, por causa não natural, por peritos legistas, após necropsia”. (SENNA, 2009, p. 89). Primeiro são feitas as impressas pelo MS do DO e distribuídas às secretarias estaduais de saúde (SES), para na sequência serem fornecidas às secretarias municipais de saúde (SMS) e essas repassam as DO aos estabelecimentos de saúde, aos institutos de medicina legal (IML), aos serviços de verificação de

óbitos (SVO) e aos cartórios de registro civil. Atualmente, as SMS também controlam a distribuição das DO aos hospitais e médicos (SENNA, 2009). Veremos no quadro a seguir algumas características do SIM.

QUADRO 25 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SIM

Criado	1975.
O que é?	Sistema nacional de vigilância epidemiológica e de um modelo único de declaração de óbito (DO), o Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Os dados constantes na declaração de óbito (DO), depois de coletados e apurados, têm importante papel no planejamento local, regional e nacional, pois, ao permitirem a elaboração de indicadores sensíveis que identificam grupos de risco, possibilitam a implantação de programas especiais de saúde e de desenvolvimento.
Objetivo	Assim como o SINASC, o SIM também tem como objetivo compilar os dados de nascimentos e óbitos ocorridos no território nacional e permitir a construção de indicadores demográficos e de saúde da população.
Organização	A DO é preenchida em três vias, desde 1994: - A primeira via (cor branca) é recolhida dos estabelecimentos de saúde e institutos de medicina legal, pelos órgãos responsáveis pelas estatísticas de mortalidade (em geral, as secretarias de saúde), ou enviada a estes pelos estabelecimentos referidos. O destino dessa via é o processamento de dados nas instâncias municipais ou estaduais. - A segunda via (cor amarela) é entregue pelo médico ou pelo estabelecimento que a preencheu à família da pessoa falecida, para que seja levada ao cartório de registro civil, onde deve ficar arquivada para os procedimentos legais. - A terceira via (cor rosa) permanece na unidade notificadora, junto à documentação do paciente. Nos casos de óbitos domiciliares, em que o falecimento é, em geral, atestado por um médico particular, essa via também é entregue à família e segue o mesmo fluxo da segunda via.

FONTE: Adaptado de (SENNA, 2009)

2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SIA/SUS)

O SIA/SUS é um sistema que, de acordo com Medeiros et al. (2005, p. 435):

Apresenta vantagens para o estudo da oferta de serviços, englobando todos os procedimentos de assistência à saúde que não exijam internação, sendo amplamente descentralizado nos estados e municípios, além de refletir a produção mensal das unidades do SUS. Neste sistema, também estão disponíveis as Fichas de Programação Físico Orçamentária (FPO) e as Fichas de Cadastro das Unidades (FCA) que, [...] permitem a caracterização das unidades e dos gestores. Estas informações garantem ao SAI/SUS condições e capacidade de disponibilizar elementos referentes ao desempenho dos gestores na seleção e implementação de prioridades assistenciais [...] e caracterização da rede, num quadro geral de disponibilidade de recursos tecnológicos e humanos por município, mesorregião municipal, Estado ou região.



Nesse endereço *on line*, você consegue visualizar no Datasus as informações acerca do SIA/SUS: <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/ambulatoriais/sia>>. Veja no quadro a seguir algumas características do SIA/SUS.

QUADRO 26 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SIA/SUS

Criado	1992 e implantado a partir de julho de 1994.
O que é?	Sistema que contém dados da produção nacional de atendimentos em nível ambulatorial.
Objetivo	Financiar os atendimentos ambulatoriais.
Organização	- Recebe a transcrição de produção nos documentos BPA e APAC, faz consolidação, valida o pagamento contra parâmetros orçamentários estipulados pelo próprio gestor de saúde, antes de aprovar o pagamento, pelo FPO. Mensalmente, os gestores, além de gerar os valores devidos a sua rede de estabelecimentos, enviam ao DATASUS-RJ, uma base de dados contendo a totalidade dos procedimentos realizados em sua gestão. Também mensalmente, o DATASUS – RJ gera arquivos para tabulação contendo estes atendimentos. Complementando as informações do sistema SIHSUS, fornece ao SAS/DRAC os valores do Teto de Financiamento a serem repassados para os gestores.

FONTE: Adaptado de <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/ambulatoriais/sia>>. Acesso em: 25 jul. 2016.

2.4 SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES (SIH/SUS)

O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) foi idealizado, com a finalidade de substituir o Sistema Nacional de Controle e Pagamentos de Contas Hospitalares (SNCPCH), que era utilizado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social para compensar as despesas dos hospitais contratados e pagos com recursos estatais, mas o SIH-SUS não contém as internações realizadas nos hospitais privados que não prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, o que limita a sua cobertura (PEPE, 2009).

Observa-se alguns aspectos positivos do sistema SIH/SUS, como:

Identificação do paciente; caracterização do hospital e gestor (número de leitos, clínicas disponíveis, meios diagnósticos e terapêuticos); [...] agilidade (disponíveis na internet em até 60 dias) e a característica de ser a única fonte regular e universal sobre morbidade no país. Estas características fazem deste sistema uma importante ferramenta para avaliação e criação de indicadores de desempenho da rede assistencial e de avaliação de sistemas de saúde, identificando gastos, oferta de serviços, demanda e cobertura assistencial. (MEDEIROS et al., 2005, p. 435).

Nesse endereço *on-line*, você consegue visualizar no Datasus as informações acerca do SIH/SUS: <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/hospitalares/sihsus>>. Veja, no quadro a seguir, algumas características do SIH/SUS.

QUADRO 27 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SIH/SUS

Criado	1991.
O que é?	Sistema que contém dados da produção nacional de atendimentos no âmbito hospitalar. Ele é considerado um banco de dados administrativo de saúde, cujo principal objetivo é o pagamento de procedimentos aos hospitais que prestam assistência à população e que fazem parte do Sistema Único de Saúde.
Objetivo	- Registrar todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares que foram financiadas pelo SUS, e a partir deste processamento, gerar relatórios para que os gestores possam fazer os pagamentos dos estabelecimentos de saúde.
Organização	- O formulário de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é o instrumento pelo qual são pagas as internações hospitalares. A distribuição das AIHs para os estados é realizada num quantitativo anual que corresponde a 9% da população residente, podendo ser estabelecido um teto financeiro para o pagamento das internações nos estados. Cabe aos estados distribuir as AIHs para os municípios de acordo com o estipulado por meio de pactuação entre as instâncias governamentais denominada de Programação Pactuada Integrada (PPI). - O pagamento é efetuado quando da apresentação das AIHs, pelos hospitais, às secretarias de saúde, que por sua vez realizam o processo de crítica para a autorização do pagamento.

FONTE: Adaptado de <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/hospitalares/sihsus>>. Acesso em: 25 jul. 2016.

2.5 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (SIAB)

Este sistema foi criado como um instrumento para gestão de sistemas locais de saúde, possibilitando um sistema de informação de dados e assim construindo indicadores populacionais referentes a áreas de abrangências definidas (FREITAS; PINTO, 2005).

Composto por módulos, o SIAB contempla o cadastramento das famílias, por meio do qual são levantados dados de escolaridade, condições de moradia, saneamento básico e problemas de saúde referidos na ficha A. Em outro módulo, refere-se à situação de saúde e acompanhamento de grupos de risco nas fichas B e C. Finalmente, contempla um módulo para notificação de agravos e registro de produção na ficha D. Para consolidação dos dados, existem relatórios denominados SSA2, SSA4, PMA2 e PMA4. A finalidade desses relatórios é permitir o conhecimento da realidade socio sanitária da população acompanhada, avaliar a adequação dos serviços de saúde oferecidos e readequá-los, sempre que necessário, visando melhorar a qualidade prestada pelos mesmos.

Além desses, o SIAB ainda cadastra as equipes que atuam no PSF, sendo a base para o repasse dos incentivos financeiros do MS para os municípios. Todos os membros que compõem essa equipe manuseiam as fichas do SIAB. (FREITAS; PINTO, 2009, p. 549).



Nesse endereço *on-line*, você consegue visualizar no Datasus as informações acerca do SIAB: <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/epidemiologicos/siab>>. Veja no quadro a seguir, algumas características do SIAB.

QUADRO 28 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SIAB

Criado	1998.
O que é?	- Sistema que foi implantado para o acompanhamento das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família – PSF. O SIAB foi desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua formulação conceitos como território, problema e responsabilidade sanitária.
Objetivo	- Subsidiar as três esferas administrativas do SUS com informações, visando à agilização e consolidação dos dados coletados. - Objetiva também detectar desigualdades, microlocalizar problemas sanitários, avaliar intervenções, agilizar o uso da informação, produzir indicadores a partir da identificação de problemas e consolidar progressivamente as informações. - Usar os dados para planejar as ações e tomar decisões locais, uma vez que sua finalidade é produzir informações que possibilitem conhecer e analisar a situação de saúde, acompanhar a execução das ações e avaliar a transformação da situação de saúde.
Organização	Utiliza três formulários de entrada dos dados: - um para o cadastramento familiar; - um para as informações de saúde e - um para as informações de produção e marcadores para avaliação.

FONTE: Adaptado de <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/epidemiologicos/siab>>. Acesso em: 25 jul. 2016.

2.6 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN)

O SISVAN é um importante sistema, pois contribui para que se conheçam a natureza e a magnitude dos problemas de nutrição, caracterizando grupos sociais de risco e dando subsídios para a formulação de políticas e estabelecimento de programas e intervenções. “A partir do SISVAN, são embasadas decisões políticas

no sentido de auxiliar no planejamento, monitoramento e gerenciamento de programas relacionados com a melhoria dos padrões de consumo alimentar e nutricionais da população” (VENÂNCIO et al., 2007, p. 214).

Em 1998, com a criação do programa de Incentivo de Combate às carências Nutricionais (ICCN), a implantação do SISVAN nos municípios da Federação passou a ser um dos requisitos básicos para o repasse de recursos financeiros federais mediante transferência dos recursos do Piso Assistencial Básico (PAB) (Portaria nº 709 de 11/06/1999 do Ministério da Saúde) (VENANCIO et al., 2007, s.p.).

O sistema está concebido por uma combinação de estratégias de Vigilância Epidemiológica. Os sistemas informatizados correspondem a um conjunto de sistemas de informações que tem como objetivo principal promover dados contínuos sobre as condições nutricionais e alimentares da população. Atualmente, abrangem o SISVAN Web e o SISVAN módulo de gestão (Bolsa Família). Veja a seguir, algumas características do SISVAN.

QUADRO 29 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SISVAN

Criado	Portaria nº 1.156 de 31/08/1990.
O que é?	Sistema de coleta, processamento e análise contínuo dos dados de uma população, possibilitando diagnóstico atualizado da situação nutricional, suas tendências temporais e, também, dos fatores de sua determinação.
Objetivo	- Coletar, analisar dados e informações para descrever as condições alimentares e nutricionais da população.
Organização	- Sistema de informações alimentado no nível local. - Os dados de consumo alimentar registrados no sistema são provenientes do preenchimento de determinadas questões, em formulários próprios do SISVAN Web, diferenciadas segundo a fase da vida.

FONTE: Adaptado de (VENANCIO et al., 2007)

2.7 SISTEMA DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA)

Através do Sistema HIPERDIA é possível descrever o perfil epidemiológico dos pacientes cadastrados, bem como os referentes de controle de hipertensos e diabéticos podem ser uma ferramenta importante para os gestores e planejadores de saúde na formulação e avaliação de políticas públicas. Esse sistema foi desenvolvido em 2001 e permite cadastrar e acompanhar os portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes mellitus (DM), em todas as Unidades Básicas do SUS; e também possui o propósito de gerar informações para os trabalhadores e gestores de saúde, para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos a todos os usuários cadastrados (ZILLMER et al., 2010).



Nesse endereço *on-line*, você consegue visualizar no Datasus as informações acerca do HIPERDIA: <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/epidemiologicos/hiperdia>>. Veja no quadro a seguir algumas características do HIPERDIA.

QUADRO 30 - ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO HIPERDIA

Criado	2001.
O que é?	- Sistema Informatizado de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos.
Objetivo	- Gerar informações para a aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos, de forma regular e contínua, a todos os pacientes cadastrados no programa.
Organização	- O fluxo das informações ocorre a partir do preenchimento da Ficha de Cadastro do paciente hipertenso e/ou diabético pelos profissionais de saúde. Os dados são digitados, sendo então possível a obtenção de diversos Relatórios e Gráficos, através da internet, a partir das bases nacional, estadual ou municipal de dados. - Informações como o número de pacientes com HAS, DM tipo 2, DM tipo 1, HAS associada a DM tipo 2 e HAS associada a DM tipo 1, além do número de pacientes obesos, tabagistas, sedentários, com dislipidemia ou com complicações crônicas, discriminados por sexo e idade são possíveis de serem extraídas nestes relatórios. - Também tem a Planilha de Acompanhamento do paciente hipertenso e/ou diabético no HIPERDIA que permite a monitorização dos pacientes cadastrados, através dos exames laboratoriais realizados, de variações de prescrições e o aparecimento de complicações.

FONTE: Adaptado de (CHAZAN; PEREZ, 2008)

Concluimos esse item apontando que não se esgotam aqui os Sistemas de Informação de Saúde (SIS) que temos no Brasil, hoje no controle da Saúde. Abordamos alguns para mostrar que “avaliar a qualidade das informações em saúde, nos SIS, é imprescindível, na medida em que eles são instrumentos importantes para o diagnóstico da situação de saúde, pois caracterizam populações em risco e possibilitam planejar estratégias terapêuticas de acordo com as necessidades e especificidades de cada grupo populacional” (ZILLMER et al., 2010, p. 241).

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, vimos que:

- O sistema de informação em saúde pode ser entendido como um instrumento para adquirir, organizar e analisar dados.
- O processo de descentralização da Saúde tem ampliado a utilização dos sistemas de informação como instrumentos de planejamento e gestão.
- Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) reúne informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo o território nacional.
- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) objetiva compilar os dados de nascimentos e óbitos ocorridos no território nacional e permitir a construção de indicadores demográficos e de saúde da população.
- Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) contém dados da produção nacional de atendimentos em nível ambulatorial e assim financiar os atendimentos ambulatoriais.
- Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) objetiva registrar todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares que foram financiadas pelo SUS, e a partir desse processamento, gerar relatórios para que os gestores possam fazer os pagamentos dos estabelecimentos de saúde.
- Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) objetiva detectar desigualdades, microlocalizar problemas sanitários, avaliar intervenções, agilizar o uso da informação, produzir indicadores a partir da identificação de problemas e consolidar progressivamente as informações.
- Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) contribui para que se conheçam a natureza e a magnitude dos problemas de nutrição, caracterizando grupos sociais de risco e dando subsídios para a formulação de políticas e estabelecimento de programas e intervenções.
- Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) gera informações para a aquisição, dispensação e distribuição e de medicamentos, de forma regular e contínua, a todos os pacientes cadastrados no programa e descrever o perfil epidemiológico dos pacientes cadastrados, bem como os indicadores de controle de hipertensos e diabéticos.



- 1 Entendemos que o sistema de informação em saúde pode ser entendido como um instrumento para:
 - a) (☐) Adquirir, organizar e analisar dados necessários à definição de problemas e riscos para a saúde.
 - b) (☐) Inventar dados necessários à definição de problemas e riscos para a saúde.
 - c) (☐) Inventar e organizar os dados necessários à definição de problemas e riscos para a saúde.
 - d) (☐) Receber e guardar dados necessários à definição de problemas e riscos para a saúde.

- 2 Com relação ao Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), assinale V para verdadeiro e F para falso sobre seus objetivos:
 - (☐) Faz análise dos nascimentos vivos.
 - (☐) Faz análise dos nascimentos vivos segundo novas e importantes variáveis entre elas, o índice de massa corporal e força muscular.
 - (☐) O grau de instrução e o Índice de Apgar no primeiro e quinto minutos não são usados como variáveis de medidas no SINASC.
 - (☐) As variáveis de medidas usadas no SINASC são: peso ao nascer, duração da gestação, grau de instrução, Índice de Apgar no primeiro e quinto minutos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) (☐) V – F – V – V.
- b) (☐) F – V – F – F.
- c) (☐) F – V – F – V.
- d) (☐) V – F – F – V.

3 Sobre SIA/SUS. Assinale a alternativa verdadeira:

- a) (☐) Sistema que foi implantado para o acompanhamento das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família – PSF.
- b) (☐) Sistema nacional de vigilância epidemiológica e de um modelo único de declaração de óbito (DO).
- c) (☐) Sistema de coleta, processamento e análise contínuo dos dados de uma população, possibilitando diagnóstico atualizado da situação nutricional, suas tendências temporais e, também, dos fatores de sua determinação.

d) () É um sistema com grandes vantagens para o estudo da oferta de serviços, pois envolve todos os procedimentos de assistência à saúde que não exijam internação.

4 De acordo com o que você estudou neste tópico, as características a seguir fazem referência a que sistema de informação?

É organizado em três vias com finalidades diferentes:

- A primeira destina-se aos órgãos regionais das Secretarias Estaduais de Saúde e tem a finalidade estatística.
- A segunda destina-se à família para posterior apresentação ao Cartório, no momento do registro do nascimento.
- A terceira também destinada à família, foi concebida com a finalidade de ser entregue ao serviço de saúde no momento da primeira consulta da criança para que o mesmo tenha acesso a informações fidedignas relativas àquele nascimento.

Essa informação corresponde a qual sigla? Assinale a alternativa CORRETA:

- a) () SIM.
- b) () SIA/SUS.
- c) () SINASC.
- d) () HIPERDIA.

REFERÊNCIAS

ABBADE, W. G. G.; SILVA, G. B.; OLIVEIRA, M. T. Projeto Terapêutico Singular (PTS). In: **11º Congresso Internacional da Rede Unida**, 2014.

ABRAHÃO, A. L.; LAGRANGE, V. **A visita domiciliar como uma estratégia da assistência no domicílio**. Modelos de atenção e a saúde da família. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, p. 151-71, 2007. Disponível em: <<http://xa.yimg.com/kq/groups/17147601/427644752/name/EPSJV+-+Modelos+de+Atencao+e+SF.pdf#page=151>>. Acesso em: 26 jun. 2016.

ADRIANO, J.R. et al. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida. **Ciência saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 53-62, 2000. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v5n1/7079.pdf>>. Acesso em: 23 maio 2016.

ALMEIDA FILHO, N. Intersetorialidade, transdisciplinaridade e saúde coletiva: atualizando um debate em aberto. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 6, p. 11-34, 2000. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Naomar_AlmeidaFilho/publication/40227369_Intersetorialidade_transdisciplinaridade_e_sade_coletiva_atualizando_um_debate_em_aberto/links/0a85e5347d2008524c000000.pdf>. Acesso em: 24 maio 2016.

ALMEIDA, G.C.M.; FERREIRA, M.Â.F. Oral health in the context of the Family Health Program: preventive practices targeting individual and public health. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 24, n. 9, p. 2131-2140, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2008000900019&script=sci_arttext>. Acesso em: 5 jul. 2016.

AMARANTE, P. Novos sujeitos, novos direitos: o debate sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 491-4, 1995. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1995000300024> Acesso em: 6 jul. 2016.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. **Manual técnico de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar**. 3. ed. Rio de Janeiro: ANA, 2009. 244p. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewi3wliJ9arNAhWGVyYKHbjVCEAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Ffaa.edu.br%2Fportal%2FPDF%2Flivros_eletronicos%2Fodonto%2Fsaudefcoletiva%2Fmanual_promocao_saude.pdf&usg=AFQjCNHMeZ9hnZA7Ra9fAw0E7LPn8pBy3g&bvm=bv.124272578,d.eWE>. Acesso em: 15 jun. 2016.

AQUILANTE, A.G. et al. A Importância da educação em saúde bucal para pré-escolares. **Revista de Odontologia da UNESP**, São Paulo, v. 32, n.1, p. 39-45, 2003. Disponível em: <<http://revodontolunesp.com.br/files/v32n1/v32n1a06.pdf>>. Acesso em: 24 maio 2016.

ARAÚJO, M. B. S.; ROCHA, P. M. Trabalho em equipe: um desafio para a consolidação da estratégia de saúde da família. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 455-464, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csc/v12n2/a22v12n2.pdf>> Acesso em: 26 jun. 2016.

AROUCA, A. S. S. **O dilema preventivista**: contribuição para a compreensão e crítica da Medicina Preventiva. 1975. 197 f. Tese de doutoramento. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 1975. Disponível em: <<http://teses.icict.fiocruz.br/pdf/aroucaass.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

AROUCA, S. Movimento sanitário brasileiro (MSB): um projeto inovador. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, n. 35, p. 94, 1992. Disponível em: <<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=150852&indexSearch=ID>>. Acesso em: 1 jun. 2016.

BARROS, S. G.; CHAVES, S. C. L. A utilização do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) como instrumento para caracterização das ações de saúde bucal. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 12, n. 1, p. 41-51, 2003. Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742003000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 7 jul. 2016.

BATISTA, M. D. G. Breve história da loucura, movimentos de contestação e reforma psiquiátrica na Itália, na França e no Brasil. **Política e Trabalho**, João Pessoa, v. 1, n. 40, p. 391-404, 2014. Disponível em: <<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/16690>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

BEZERRA Jr., B.; SAYD, J. D. **Um mestrado para um momento preciso**. Rio de Janeiro, UERJ/IMS, 1993 (Estudos em saúde coletiva, 47).

BIRMAN, J. A. Physis da Saúde Coletiva. **Revista saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, p. 11-16, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/physis/v15s0/v15s0a02.pdf>>. Acesso em: 27 maio 2016.

BORNSTEIN, V. J.; STOTZ, E. N. Concepts involved in the training and work processes of community healthcare agents: a bibliographical review. **Ciência e saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v.13, n. 1, p. 259-268, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000100029>. Acesso em: 26 jun. 2016.

BRANCO, M. A. F. Sistemas de informação em saúde no nível local. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 67-270, 1996. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csp/v12n2/1512.pdf>> Acesso em: 7 jul. 2016.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **III Conferência Nacional Saúde Mental**: Relatório Final. Brasília, Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: <<http://bvs-ms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0210IIIcnsm.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Art. 2. **Legislação do SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde**. - Brasília: CONASS, 2003. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas constitucionais nos 1/1992 a 91/2016, pelo Decreto legislativo n. 186/2008 e pelas Emendas constitucionais de revisão nos 1 a 6/1994. 49. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016. (Série textos básicos; n. 140). Disponível em: <<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/15261>>. Acesso em: 1 jun. 2016.

BRASIL. Constituição (Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9961.htm>. Acesso em: 7 jul. 2016.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. DOU, 16. jul. 1990. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/camara/estatuto_crianca_adolescente_9ed.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

BRASIL. Lei Orgânica, nº 8.080, Lei Orgânica, nº 8.142, 1990. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 23 jun. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **8ª Conferência Nacional de Saúde**: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde, 1987. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Saúde Suplementar**. CONASS, 2007, 234 p. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro11.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. **Departamento de atenção básica**. Atenção básica e a saúde da família, 2013. Disponível em: <<http://dab.saude.gov.br/atencabasica.php>>. Acesso em: 24 jun. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. **Diretrizes nacionais da vigilância em saúde**. Série B. Textos básicos de saúde. Série pactos pela saúde, v. 13, 2010. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacto_saude_volume13.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. **HumanizaSUS**: política nacional de humanização: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizaSUS_politica_nacional_humanizacao.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. **Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde**. Saúde da família. 2. ed. Brasília, DF, 2008. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html>. Acesso em: 24 jun. 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Manual de planejamento no SUS** / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, v. 4, 2016. 138 p. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/articulacao_interfederativa_v4_manual_planejamento_atual.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **O Sistema Público de Saúde Brasileiro**, 2002. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_sau-de.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. **Programa Nacional de Imunização, 30 anos**. Série C. Projetos e Programa e Relatórios. 2003. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/livro_30_anos_pni.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher**: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Saúde Mental no SUS**: Os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde, 2004b. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. **Diretrizes para a programação pactuada e integrada da assistência à saúde**. Série B. Textos Básicos de Saúde v. 5, 2006. 148 p. Disponível em: <<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/DiretrizesProgPactuadaIntegAssistSaude.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria Executiva. **Programa agentes comunitários de saúde (PACS)**, Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: <<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacs01.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. **Sistema de planejamento do SUS (PlanejaSUS)**: uma construção coletiva - trajetória e orientações de operacionalização. Organização Pan-Americana da Saúde. Série B. Textos Básicos de Saúde, 2009. 318 p. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/planejaSUS_livro_1a6.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. SUS. Redes de atenção psicossocial. **DECRETO Nº 7.508/11, Brasília, 2011**. Disponível em: <<http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/RAPS.pdf>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. Portaria GM/MS nº 399 de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006. Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. **Diário Oficial** [da União], 2006. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html>. Acesso em: 24 jun. 2016.

BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. **Estabelece diretrizes para organização da rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)**, 2010. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html> Acesso em: 7 jul. 2016.

BURDANDY, L.; BODSTEIN, R. C. A. Política e saúde coletiva: reflexão sobre a produção científica (1976-1992). **Caderno Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 543-554, 1998. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csp/v14n3/0091.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2016.

BUSS, P. M. Uma introdução ao conceito de promoção da saúde. In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (Org.). **Promoção da Saúde**: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. p. 15-38.

BUSS, P. M. Uma introdução ao conceito de promoção da Saúde. In: CZERESNIA, D. e FREITAS, C.M (Orgs.). **Promoção da Saúde**: conceitos, reflexões, tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. p. 19-40.

CAMPOS, C. E. A. O desafio da integralidade segundo as perspectivas da vigilância da saúde e da saúde da família. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 569-584, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n2/a18v08n2>>. Acesso em: 24 maio 2016.

CAMPOS, G. W.; BARROS, R. B.; CASTRO, A.M. Avaliação de política nacional de promoção da saúde. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 745-749, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csc/v9n3/a20v09n3.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2016.

CAMPOS, L.; WENDHAUSEN, A. Participação em saúde: concepções e práticas de trabalhadores de uma equipe da estratégia de saúde da família. **Texto e contexto em enfermagem**, Florianópolis v. 16, n. 2, p. 271-279, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/tce/v16n2/a09v16n2>>. Acesso em: 27 jun. 2016.

CARVALHO, M. C. B. **Gestão municipal dos serviços de atenção à criança e ao adolescente**. São Paulo: IEE/PUCSP/CBIA, 1995.

CARVALHO, S. T. R. F. **Conhecimentos e percepções dos usuários da estratégia saúde da família sobre a Fisioterapia**. 2008. Dissertação (Mestrado em Saúde na Comunidade) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008.

CARVALHO, S.R. Saúde coletiva e promoção da saúde: Sujeito e mudança. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 241-246, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csp/v23n1/28.pdf>> 21.05.2016>. Acesso em: 21 maio 2016.

CARVALHO, Y.M.; CECCIM, R.B. **Formação e educação em saúde**: aprendizados com a saúde coletiva. Disponível em: <<http://lrc-ead.nutes.ufrj.br/constructore/objetos/Forma%E7%E3o%20e%20educa%E7ao.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2016.

CASTRO, J.L., GERMANO, J.W. A difusão da medicina social no Brasil: o protagonismo de Juan César Garcia e da OPAS1. **Cronos**, Natal, v.11, n.3, p. 219-233, 2012. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufrn.br/cronos/article/viewFile/1697/1169>>. Acesso em: 22 maio 2016.

CAVALCANTE FILHO et al. Acolhimento coletivo: um desafio instituinte de novas formas de produzir o cuidado. **Interface – comunicação, saúde, educação**, Botucatu v. 13, n. 31, p. 315-328, 2009. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832009000400007>>. Acesso em: 20 maio 2016.

CAVALCANTI, Y.W.; PADILHA, W.W.N. Qualificação de processos de gestão e atenção no município de Caaporã, PB: relatos de tutoria de educação permanente em saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 38, n.100, p.170-180, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042014000100170>. Acesso em: 25 maio 2016.

CESARINO, A. Uma experiência de saúde mental na prefeitura de São Paulo: Projeto de Ações Integradas de Saúde Mental na zona norte do município de São Paulo – uma gestão democrática de um projeto público de saúde mental. In: LANCETTI, A. (Org.). **Saúde Loucura**. São Paulo: Hucitec, 1989. p. 3-32.

CESTARI, M. E. W.; ZAGO, M. M. F. A prevenção do câncer e a promoção da saúde: um desafio para o Século XXI. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 58, n. 2, p. 218-21, 2005. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1tp3P8ujMAhWBIJAKHeNiBM4QFgqeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0034-71672005000200018&usg=AFQjCNH0gvdXqz-D6HD1Z_Ws9qRhblg_hg>. Acesso em: 20 maio 2016.

CHAZAN, A. C.; PEREZ, E. A. Avaliação da implementação do sistema informatizado de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos (HIPERDIA) nos municípios do estado do Rio de Janeiro. **APS**, Juiz de Fora, v. 11, n. 1, p. 10-16, 2008. Disponível em: <<http://www.ufjf.br/nates/files/2009/12/010-016.pdf>>. Acesso em: 8 jul. 2016.

CHIACHIO, N. B. **A construção dos serviços de assistência social como política social pública**. 2011. 226 f. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/27/TDE-2011-07-26T06:24:40Z-11328/Publico/Neiri%20Bruno%20Chiachio.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2016.

CHIORO, A., SCAFF, A. **A implantação do Sistema Único de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. Disponível em: <<http://www.webartigos.com/artigos/saude-e-cidadania-a-implantacao-do-sistema-unico-de-saude/10229/>>. Acesso em: 21 jun. 2016.

CIDADES (MINISTÉRIO DAS CIDADES). **Plano diretor participativo**: guia para elaboração pelos municípios e cidadãos. Confea, 2004. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Eventos/Oficina-RagularizacaoFundiaria/PlanoDiretor/Plano%20Diretor%20Participativo%20Guia%20para%20a%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20pelo%20munic%C3%ADpio%20e%20os%20cidad%C3%A3os.pdf>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

COHEN, S. C.; CYNAMON, S. E.; KLIGERMAN, D. C.; ASSUMPÇÃO, R. F. Habitação saudável no programa saúde da família (PSF): uma estratégia para as políticas públicas de saúde e ambiente. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 807-813, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n3/a26v09n3>>. Acesso em: 23 maio 2016.

COMERLATTO, D.; MATIELLO, A.; COLLISELLI, L.; RENK, E. C.; KLEBA, M. E. Gestão de políticas públicas e intersetorialidade: diálogo e construções essenciais para os conselhos municipais. **Revista Katálisis**, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 265-271, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rk/v10n2/a15v10n2>>. Acesso em: 25 maio 2016.

COSTA, M. F. B. N. A.; CIOSAK, S. I. Atenção integral na saúde do idoso no Programa Saúde da Família: visão dos profissionais de saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 437-444, 2010. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/download/40559/43688>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (Orgs.). **Promoção da Saúde**: conceitos, reflexões, tendências. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 229p.

DEL CIAMPO et al. O Programa de Saúde da Família e a Puericultura. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 739-743, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csc/v11n3/30988.pdf>>. Acesso em: 4 jul. 2016.

DELFINI, P.S.S. et al. Parceria entre CAPS e PSF: o desafio da construção de um novo saber. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 14, n. 5, p. 1483-1492, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v14s1/a21v14s1>> Acesso em: 6 jul. 2016.

DEMARZO, M.M.P.; AQUILANTE, A.G. Abordagem à saúde escolar. Cap.66. In: GUSSO, G. e LOPES, J.M.C. (Org.) **Tratado de Medicina de Família e Comunidade**. Porto Alegre: Artmed, 2012.

DESLANDES, S. F.; MITRE, R. M. A. Processo comunicativo e humanização em saúde. **Interface – comunicação, saúde, educação**, Botucatu, v.13, supl.1, p. 641-649, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832009000500015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 1 jul. 2016.

DIAS, M. T. G. História e reflexão sobre as políticas de saúde mental no Brasil e no Rio Grande do Sul. **Open Journal Systems**, v. 12, n. 3, 2012. Disponível em: <<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/8235/5998>>. Acesso em: 30 maio 2016.

DONATO, A.F.; ROSENBERG, C.P. Algumas idéias sobre a relação Educação e Comunicação no âmbito da Saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 12, n. 2, p. 18-25, 2003. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/7095/0> Acesso em: 10 jul. 2016.

DONNANGELO, M. C. F.; PEREIRA, L. **Saúde e Sociedade**. São Paulo: Duas Cidades, 1976.

EMMI, D.T.; BARROSO, R.F.F. Avaliação das ações de saúde bucal no Programa Saúde da Família no distrito de Mosqueiro, Pará. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 35-41, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000100008>. Acesso em: 4 jun. 2016.

ERDMANN, A. L.; SOUSA, F. G. M. Cuidando da criança na Atenção Básica de Saúde: atitudes dos profissionais da saúde. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, v. 33, n. 2, p.150-160, 2009. Disponível em: <<http://www.academia.edu/download/35686829/150a160.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

ESCOREL, S. et al. O programa de saúde da família e a construção de um novo modelo para a atenção básica no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 21, n.2, p.164-176, 2007. Disponível em: <<http://iris.paho.org/xmlui/bitstre>>

am/handle/123456789/9334/11.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 26 jun. 2016.

FADEL, C. B.; SCHNEIDER, L.; MOIMAZ, S. A. S.; SALIBA, N. A. Administração pública: o pacto pela saúde como uma nova estratégia de racionalização das ações e serviços em saúde no Brasil. **Revista Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2, p. 445-456, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a08.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2016.

FARIAS, M. A. V.; MOURA, E. R. F. Saúde bucal no contexto do programa saúde da família do município de Iracema, no Ceará. **Revista de Odontologia da UNESP**, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 131-137, 2003. Disponível em: <<http://www.revodontolunesp.com.br/article/51ae4a9c1ef1faca3d002596>>. Acesso em: 4 jun. 2016.

FARINATTI, P. T. V.; FERREIRA, M. S. **Saúde, promoção da saúde e educação física**: conceitos, princípios e aplicações. Rio de Janeiro: UERJ, 2006.

FERNANDES, L. C. L.; BERTOLDI, A. D.; BARROS, A. J. D. Utilização dos serviços de saúde pela população coberta pela Estratégia de Saúde da Família. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 595-603, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsp/2009nahead/483.pdf>>. Acesso em: 27 jun. 2016.

FERRAZ, S. T. **Cidades Saudáveis**: uma urbanidade para 2000. Brasília: Paralelo 15, 1999.

FIGUEIREDO, G. L. A.; MELLO, D. F. A prática de enfermagem na atenção à saúde da criança em unidade básica de saúde. **Revista Latino-americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 11, n. 4, p. 544-51, 2003. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/1800/1847>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

FIGUEIREDO, M. D.; FURLAN, P. G. O subjetivo e o sociocultural na coprodução de saúde e autonomia. In: CAMPOS, G. W. S.; GUERRERO, A. V. P. (Orgs.). **Manual de Práticas em Atenção Básica**: Saúde Ampliada e Compartilhada: Hucitec. 2008. p. 154-178.

FIOCRUZ. Biblioteca virtual Sérgio Arouca. **Reforma Sanitária**. 1998. Disponível em: <<http://bvsarouca.icict.fiocruz.br/sanitarista05.html>>. Acesso em: 17 jun. 2016.

FLORIN, D.; BASHAM, S. Evaluation of health promotion in clinical settings. Evaluating Health Promotion. **Practice and Methods**, [impresso], 2000. p. 140-150

FRANCO, T. B.; BUENO, W. S.; MERHY, E. E. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: Betim, Minas Gerais, Brasil. **Caderno Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 15, p. 345-53, 1999. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csp/v15n2/0319>>. Acesso em: 4 jun. 2016.

FREITAS, F.P.; PINTO, I.C. Percepção da equipe de saúde da família sobre a utilização do sistema de informação da atenção básica-SIAB. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 13, n. 4, p. 547-554, 2005. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/2117>>. Acesso em: 8 jul. 2016.

FURTADO, J.P. Avaliação da situação atual dos Serviços Residenciais Terapêuticos no SUS. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 785-795, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csc/v11n3/30993.pdf>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

GARCIA, P. P. N. S.; CORONA, S. A. M.; VALSECKI JÚNIOR, A. A educação e motivação: segunda avaliação da efetividade de métodos educativos-preventivos relativos à cárie dental e à doença periodontal. **Revista de Odontologia da UNESP**, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 405-415, 1998. Disponível em: <<http://www.revodontolunesp.com.br/files/v27n2/v27n2a05.pdf>>. Acesso em: 4 jun. 2016.

GIACOMOZZI, C. M.; LACERDA, M. R. A prática da assistência domiciliar dos profissionais da estratégia de saúde da família. **Texto e Contexto em Enfermagem**, Florianópolis, v. 15, n. 4, p. 645-53, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/tce/v15n4/v15n4a13>>. Acesso em: 24 jun. 2016.

GIOVANELLA, L. et al. **Políticas e sistema de saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012, 1100p. Disponível em: <<http://books.scielo.org>>. Acesso em: 30 jun. 2016.

GIOVANELLA, L. et al. Saúde da família: limites e possibilidades para uma abordagem integral de atenção primária à saúde no Brasil. **Ciência e saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 783-794, 2009. Disponível em: <http://www.institutoconscienciago.com.br/pdf/saude/limites_possibilidades.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2016.

HAFNER, M. D. L. M. B. et al. A formação médica e a clínica ampliada: resultados de uma experiência brasileira. **Ciência e saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, p. 1715-1724, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v15s1/083.pdf>>. Acesso em: 30 jun. 2016.

HILGER, E.C.; ABEGG, C.; PRETTO SM. Análise das abordagens de Educação em Saúde em programas de saúde bucal. **Ação Coletiva** [impresso], v.2, n.2, p. 4-10, 1999.

INOJOSA, R. M. Intersetorialidade e a configuração de um novo paradigma organizacional. **Revista de Administração Pública**, v. 2, n. 2, p. 35-48, 1998. Disponível em: <http://www.pucsp.br/prosaude/downloads/bibliografia/intersetorialidade_configuracao_novo_paradigma_organizacional.pdf>. Acesso em: 25 maio 2016.

JORGE, M.H.P.M. et al. Avaliação do sistema de informação sobre nascidos vivos e o uso de seus dados em epidemiologia e estatísticas de saúde. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 27, n. supl., p. 1-46, 1993. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/23933>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

JUNQUEIRA, L. A. P.; INOJOSA, R. M.; KOMATSU, S. Descentralização e intersetorialidade na gestão pública municipal no Brasil: a experiência de Fortaleza. 1997. Disponível em: <<http://revistas.ufpr.br/psicologia/article/viewArticle/4797>>. Acesso em: 20 maio 2016.

KAWAMOTO, E. E.; SANTOS, M. C. H.; MATTOS, T. M. **Enfermagem Comunitária**. São Paulo: EPU, 2009, 184p.

KELLES, S. M. B.; MACHADO, C. J.; BARRETO, S. M. Ten-years of bariatric surgery in Brazil: in-hospital mortality rates for patients assisted by universal health system or a health maintenance organization. **ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**, São Paulo, v. 27, n. 4, p. 261-267, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-67202014000400261&script=sci_art-text&tlng=pt>. Acesso em: 6 jul. 2016.

KNAUTH, D. R.; COUTO, M. T.; FIGUEIREDO, W. S. A visão dos profissionais sobre a presença e as demandas dos homens nos serviços de saúde: perspectivas para a análise da implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 10, p. 2617-2626, 2012. Disponível em: <http://observatorio.fm.usp.br/bitstream/handle/OPI/679/art_COUTO_The_standpoint_of_professionals_on_the_presence_and_2012_por.PDF?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 jul. 2016.

L'ABBATE, S. A análise institucional e a saúde coletiva. **Ciências e saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 265-274, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v8n1/a19v08n1.pdf>>. Acesso em: 26 maio 2016.

LACERDA JÚNIOR, F.; GUZZO, R. S. L. Prevenção primária: análise de um movimento e possibilidades para o Brasil. **Interação em psicologia**, Curitiba, v. 9, n. 2, 2005. Disponível em: <<http://revistas.ufpr.br/psicologia/article/viewArticle/4797>>. Acesso em: 20 maio 2016.

LANCETTI, A. Radicalizar a desinstitucionalização. In: Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Caderno de textos de apoio da III Conferência Nacional de Saúde Mental**. Brasília; 2001. p. 84-89.

LAVRAS, C. C. C. **Descentralização e estruturação de redes regionais de atenção à saúde no SUS**. Política e Gestão Pública em Saúde. São Paulo: Hucitec, 2011.

LEAL, A. F.; FIGUEIREDO, W. S.; SILVA, G. S. N. O percurso da política nacional de atenção integral à saúde dos homens (PNAISH), desde a sua formulação até a sua implementação nos serviços públicos locais de atenção à saúde. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 10, p. 2607-2616, 2012. Disponível em: <<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/950937>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A. M. C. **Promoção de saúde, a negação da negação**. Rio de Janeiro: Vieira e Lent, 2004.

LEVCOVITZ, E.; GARRITO, N. Saúde da família: a procura de um modelo anunciado. **Caderno de Saúde da Família**. Brasília: Ministério da Saúde, ano 1, n. 1, p. 3, 1996.

LIMA, F.L.C. O núcleo de apoio à saúde da família e alguns dos seus desafios. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v.3, n.2, p.118-133, 2013. Disponível em:

<<http://www.grupouninter.com.br/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/144/11>>. Acesso em: 30 jun. 2016.

LIMA, L. D. et al. Descentralização e regionalização: dinâmica e condicionantes da implantação do Pacto pela saúde no Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 7, p. 1903-1914, 2012. Disponível em: <http://observatorio.fm.usp.br/bitstream/handle/OPI/684/art_VIANA_Decentralization_and_regionalization_dynamics_and_conditioning_factors_for_2012.PDF?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 jul. 2016.

LIMA, N. T.; SANTANA, J.P. (Org.). Saúde coletiva como compromisso: a trajetória da ABRASCO. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n.10, p. 2517-2522, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n10/30.pdf>>. Acesso em: 21 maio 2016.

LIMA, S. S.; BRASIL, S. A. Do Programa de Volta para Casa à conquista da autonomia: percursos necessários para o real processo de desinstitucionalização. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 67-88, 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/physis/v24n1/0103-7331-physis-24-01-00067.pdf>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

LUZ, M. T. Complexidade do campo da saúde coletiva: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e transdisciplinaridade de saberes e práticas - análise sócio-histórica de uma trajetória paradigmática, **Saúde Social**, São Paulo, v.18, n. 2, p. 304-311, 2009. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/viewFile/29601/31469>>. Acesso em: 2 jun. 2016.

MACHADO, M. F. A. S. et. al. Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. **Ciência e saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 335-42, 2007. Disponível em: <<https://www.cepesc.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Livro-completo.pdf#page=43>>. Acesso em: 24 maio 2016.

MARTINI, J.G. Implantação do Programa de Saúde da Família em Porto Alegre. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 53, n. especial, p. 71 -76, dez. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672000000700009&script=sci_arttext> Acesso em 28 jul. 2016.

MARTINS, A. M.; MALAMUT, B. S. Análise do discurso da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 429-440, 2013. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/76442/0>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

MATTOS, R. A. **Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos**. Os Sentidos, 2001. Disponível em: <<https://www.cepesc.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Livro-completo.pdf#page=43>>. Acesso em: 24 maio 2016.

MATTOS, R.A. A integralidade na prática (ou sobre a prática da integralidade). **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 1411-1416, 2004.

Disponível em: <http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2004000500037&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 24 maio 2016.

MEDEIROS, K. et al. O sistema de informação em saúde como instrumento da política de recursos humanos: um mecanismo importante na detecção das necessidades da força de trabalho para o SUS. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 433-440, 2005. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/23933>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

MENDES, E.V. As redes de atenção à saúde. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2297-2305, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

MESQUITA, J. F.; NOVELLINO, M. S. F.; CAVALCANTI, M. T. A reforma psiquiátrica no Brasil: um novo olhar sobre o paradigma da saúde mental. 2010. In: Encontro Nacional De Estudos Populacionais, 2010, Caxambu, MG. **Anais eletrônicos**. Caxambu. ABEP. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/eixo_4/abep2010_2526.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2016.

MILORI, A. S.; NORDI, P. P.; VERTUAN, V.; CARVALHO, J. Respostas de um programa preventivo de placa dentária bacteriana. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 23, n. 2, p. 325-231, 1994. Disponível em: <http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2004000500037&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 24 maio 2016.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **ABC do SUS: doutrinas e princípios**. Secretária da Nacional de Assistência à Saúde. Brasília, DF, 1990. Disponível em: <http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2016.

MINISTÉRIO da Saúde. Departamento de atenção básica. Secretaria de assistência à saúde. **O trabalho do Agente Comunitário de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_05a.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2016.

MOLESINI, J. A. et al. Programação Pactuada Integrada e Gestão compartilhada do SUS. **Revista Baiana Saúde Pública**, Salvador, v. 34, n. 3, p. 623-638, 2010. Disponível em: <<http://brasil.campusvirtualsp.org/sites/default/files/FIOCRUZ%20PPI%20e%20Gesto%20Compartilhada%20do%20SUS.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

MOURA, E. C.; LIMA, A. M. P.; URDANETA, M. Uso de indicadores para o monitoramento das ações de promoção e atenção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 10, p. 2597-2606, 2012. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12716/2/ARTIGO_UsoIndicadoresPara.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

MOYSÉS, S. J.; MOYSÉS, S.T.; KREMPEL, M. C. Avaliando o processo de construção de políticas públicas de promoção de saúde: a experiência de Curitiba. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 627-41, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v9n3/a10v09n3.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2016.

NASCIMENTO, D.D.G; OLIVEIRA, M.A.C. Reflexões sobre as competências profes-

sionais para o processo de trabalho nos núcleos de apoio à saúde da família. **O mundo da saúde**, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 92-96, 2010. Disponível em: <http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/74/12_revisao_reflexoes.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2016.

Nicolescu, B. **O Manifesto da Transdisciplinaridade**. São Paulo: Triom, 1999. novos paradigmas? **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 4, p. 299-316, 1998. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v32n4/a2593>>. Acesso em: 20 maio 2016.

NUNES, E. D. Saúde coletiva: história de uma ideia e de um conceito. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 5-21, 1994. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v3n2/02.pdf>>. Acesso em: 21 maio 2016.

NUNES, E. D. Sobre a história da saúde pública: ideias e autores. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 251-264, 2000. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csc/v5n2/7095.pdf>>. Acesso em: 21 maio 2016.

OLIVEIRA, J. A. A saúde pública hoje: notas para um debate sobre a conjuntura em saúde e a situação da ENSP ao seu interior. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 326-33, 1988. Disponível em: <<http://www.scielo.org/pdf/csp/v4n3/07.pdf>>. Acesso em: 1 jun. 2016. Acesso em: 21 maio 2016.

Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS. Série Técnica do Projeto de Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília. 2002. 116p. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_09.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2016.

ORTIGA, A. M. B.; THIELE, A. B.; SILVA, V. S. B. **Guia para elaboração do plano municipal de saúde**. Secretaria do Estado de Santa Catarina. 2011. Disponível em: <portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com>. Acesso em: 4 jul. 2016.

OSMO, A.; SCHRAIBER, L. B. O campo da saúde coletiva no Brasil: definições e debates em sua constituição. **Saúde Social**, São Paulo, v. 24, p. 205-218, 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v24s1/0104-1290-sausoc-24-s1-00205.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2016.

PAIM, J. A reforma sanitária e os modelos assistenciais. In: Rouquayrol, M.; Almeida Filho, N. **Epidemiologia e saúde**. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. PAIM, J. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. **Lancet**, v. 6736, n. 11, p. 60054-60058, 2011. Disponível em: <<http://www.cpgss.pucgoias.edu.br/ArquivosUpload/31/file/O%20SISTEMA%20DE%20SAUDE%20BRASILEIRO.pdf>>. Acesso em: 17 jun. 2016.

PAIM, J. S. **Modelos assistenciais**: reformulando o pensamento e incorporando a proteção e a promoção da saúde. Seminários Temáticos Permanentes. AN-VISA/ISCUFBA. Brasília, 2001. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/6168/1/Paim%20JS.%20Texto%20Modelos%20Assistenciais.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2016.

PAIM, J. S. Modelos de atenção e vigilância da saúde. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 6, p. 567-571, 2003. Disponível em: <<https://scholar.google>>.

com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Paim+2003&btnG=&lr>. Acesso em: 30 jun. 2016.
PAIM, J. S. **Reforma sanitária brasileira**: contribuição para a compreensão e crítica. Salvador: Edufba; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n8/24.pdf>>. Acesso em: 17 jun. 2016.

PAIM, J. S. Uma análise sobre o processo de reforma sanitária brasileira. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 81, p. 27-37, 2009. Disponível em: <<http://www.prppg.ufpr.br:8080/saudecoletiva/sites/default/files/processoseletivo2015/politicas/PAIM,%20Jairnilson%20%20Uma%20analise%20sobre%20o%20processo%20da%20RSB.pdf>>. Acesso em: 1 jun. 2016.

PAIM, J. S.; ALMEIDA FILHO, N. **A crise da saúde pública e a utopia da saúde coletiva**. Salvador: Casa da Qualidade, 2000, p. 63. Disponível em: <<http://www.worldcat.org/title/crise-da-saude-publica-e-a-utopia-da-saude-coletiva/oclc/47646715>>. Acesso em: 20 maio 2016.

PAIVA, C.H.A.; TEIXEIRA, L.A. Reforma Sanitária e a criação do Sistema Único de saúde: notas sobre contextos e autores. **História, Ciências, Saúde**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 15-35, 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-21-1-00015.pdf>>. Acesso em: 17 jun. 2016.

PAULETO, A. R. C.; PEREIRA, M.L.T.; CYRINO, E. G. Saúde bucal: uma revisão crítica sobre programações educativas para escolares. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 121-30, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csc/v9n1/19829.pdf>>. Acesso em: 4 jun. 2016.

PEPE, V.E. Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), p. 67, 2009. In: Brasil. Ministério da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagen/3039.pdf#page=87>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

PIETROBON, L.; PRADO, M. L.; CAETANO, J. C. Saúde Suplementar no Brasil: o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar na regulação do setor. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 767-783, 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/physis/v18n4/v18n4a09.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

PIOLA, S. F.; SERVO, L.M.; SÁ, E. B.; PAIVA, A.B. Financiamento do Sistema Único de saúde: Trajetória recente e cenários para o futuro. **Análise Econômica**, Porto Alegre, v. 30, n. especial, p. 9-33, 2012. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/article/viewFile/25261/21530>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

PNS. PLANO NACIONAL DE SAÚDE. **Políticas públicas saudáveis**. Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade nova de Lisboa, Lisboa, 2011. Disponível em: <<http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.wpengine.netdna-cdn.com/files/2010/09/PPS1.pdf>>. Acesso em: 23 maio 2016.

PRODOC 914 BRA, UNESCO. Projeto memória e patrimônio da saúde pública no Brasil: A trajetória de Sérgio Arouca. Relatório de Atividades Sérgio Arouca, 1976-1988. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: <<http://www.memoriasocial>>.

pro.br/linhas/arouca/relatorios/relatorio19761988.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2016.

PUPO, G. D. et al. **Rede de atenção à saúde**. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Ciências Farmacêuticas e Gestão da Assistência Farmacêutica - EaD, 2014. Disponível em: <<https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/3250/Rede%20de%20Aten%E7%E3o%20%E0%20Sa%FAde.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

RAPOSO, C. A Política de Atenção Integral à Saúde do Adolescente e Jovem: uma perspectiva de garantia de direito à saúde? **Revista em Pauta**, Rio de Janeiro, n. 23, p. 117-138, 2010. Disponível em: <<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/450>>. Acesso em: 4 jul. 2016.

RESTREPO, H. E. Conceptos e definiciones. In: Restrepo HE, Málaga H. **Promoción de la salud: como construir vida saludable**. Colômbia: Editorial Médica Panamericana; 2001. Disponível em: <http://www.conarem.ins.gov.py/wp-content/uploads/2014/08/11-Prom_Salud.-Restrepo-Malaga.pdf>. Acesso em: 21 maio 2016.

REZENDE, D. A.; ULTRAMARI, C. Plano diretor e planejamento estratégico municipal: introdução teórica conceitual. **RAP**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 2, p. 255-271, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rap/v41n2/05.pdf>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

RIBEIRO, C. D. M.; SCHRAMM, F. R. Medical care, organ and tissue transplants, and targeted policies. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 9, p. 1945-1953, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2006000900026&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 4 jul. 2016.

RIBEIRO, J.A.; PIOLA, S.F.; SERVO, L.M.S. As novas configurações de antigos problemas: financiamento e gasto com ações e serviços públicos de saúde no Brasil. **Divulgação em Saúde para Debate**, Rio de Janeiro, n. 37, p. 21-43, 2007. Disponível em: <http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34128922/DSD_ES_I_impressa.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1467920677&Signature=s%2B7%2BbepGKLzV%2FIsX%2BcpHfVZD-mKU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEconomia_Politica_da_Saude_introduzindo.pdf#page=23>. Acesso em: 7 jul. 2016.

RODRIGUES, D.; SANTOS, V. E. A educação em saúde na estratégia saúde da família: uma revisão bibliográfica das publicações científica no Brasil. **J Health Sci. Inst.**, v. 28, n. 4, p. 321-324, 2010. Disponível em: <http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2010/04_out-dez/V28_n4_2010_p321-324.pdf>. Acesso em: 25 maio 2016.

RODRIGUES, R. A. P. et al. Política nacional de atenção ao idoso e a contribuição da enfermagem. **Texto contexto enfermagem**. Florianópolis, v. 16, n. 3, p. 536-45, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/a21v16n3.pdf>>. Acesso em: 6 jul. 2016.

RODRIGUEZ, M.R. Análise histórica da trajetória do profissional do fisioterapeuta até sua inserção nos núcleos de apoio a saúde da família (NASF). **Comum Ciênc. Saúde**, v. 21, n. 3, p. 261-266, 2011. Disponível em: <<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=619058&indexSearch=ID>>. Acesso em: 30 jun. 2016.

ROSA, W.A.G.; LABATE, R.C. Programa saúde da família: a construção de um novo modelo de assistência. **Revista Latino-americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 13, n. 6, p. 1027-1034, 2005. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rlae/article/download/2162/2255>>. Acesso em: 27 jun. 2016.

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. **Epidemiologia e saúde**. Modelos de atenção e vigilância da saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003, p. 567-571.

ROZENFELD, S. (Org.). **Fundamentos da vigilância sanitária**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009, 301p. Disponível em: <<http://books.scielo.org>>. Acesso em: 30 jun. 2016.

SANTOS FILHO, S.B. Perspectivas da avaliação na política nacional de humanização em saúde: aspectos conceituais e metodológicos. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 999-1010, 2007. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rlae/article/download/2162/2255>>. Acesso em: 30 jun. 2016.

SANTOS, A. M.; ASSIS, M. M. A. Da fragmentação à integralidade: construindo e (des)construindo a prática de saúde bucal no programa de saúde da família (PSF) de Alagoinhas, BA. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 53-61, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232006000100012>. Acesso em: 4 jun. 2016.

SCHIMITH, M. D.; LIMA, M. A. D. S. Acolhimento e vínculo em uma equipe do programa saúde da família. **Caderno Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 6, p. 1487-1494, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n6/05.pdf>>. Acesso em: 4 jun. 2016.

SCHMITT, V. et al. Interdisciplinaridade e Pós-Graduação. **Revista de Biologia e Ciências da Terra**, v. 6, n. 2, p. 295-304, 2006. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Fialho/publication/266606921_Interdisciplinaridade_e_Ps-Graduao/links/5444f7ab0cf2e6f0c0fbfc57.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2016.

SEGRE, M.; FERRAZ, F. C. O conceito de saúde. **Revista Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 5, p. 538-42, 1997. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v31n5/2334.pdf>>. Acesso em: 21 maio 2016.

SENNA, M.C.M. **Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)**. p. 87, 2009. In: Brasil. Ministério da Saúde. A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3039.pdf#page=87>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

SILVA JUNIOR, J. B. I Editorial, 40 anos do programa nacional de imunizações: uma conquista da saúde pública brasileira. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 22, n. 1, p. 7-8, 2013. Disponível em: <<http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v22n1/v22n1a01.pdf>>. Acesso em: 4 jul. 2016.

SILVA, D. S.; AZEVEDO, D. M. D. As novas práticas em saúde mental e o trabalho no serviço residencial terapêutico. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 603-9, 2011. Dis-

ponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452011000300023&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 6 jul. 2016.

SILVA, M.J.P. O papel da comunicação na humanização da atenção à saúde. **Revista Bioética**, Brasília, v. 10, n. 2, p. 73-88, 2009. Disponível em: <http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewArticle/215>. Acesso em: 4 jun. 2016.

SOLLA, J.J.S.P. Acolhimento no sistema municipal de saúde. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v.5, n.4, p.493-503, 2005. Disponível: <<http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v5n4/27768>>. Acesso em: 4 jun. 2016.

SOUTO, K.M.B. A política de atenção integral à saúde da mulher: uma análise de integralidade e gênero. **Serviço Social**, Brasília, v. 10, n. 22, p.161-182, 2009. Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/viewArticle/17>. Acesso em: 5 jul. 2016.

SOUZA, G. C. A.; COSTA, I. C. C. O SUS nos seus 20 anos: reflexões num contexto de mudanças. **Saúde e sociedade**, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 509-517, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v19n3/04.pdf>>. Acesso em: 23 jun. 2016.

SPEDO, M. S.; TANKA, O. Y.; PINTO, N. R. S. O desafio da descentralização do Sistema Único de saúde em município de grande porte: o caso de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 8, p. 1781-1790, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n8/14.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

TAMBELLINI, T. A. Resenha “Arouca, meu irmão: uma trajetória a favor da saúde coletiva”: um legado também para o campo da saúde ambiental brasileira. **Tempus. Actas em saúde coletiva**, Brasília, v. 4, n. 4, p.158, 2009. Disponível em: <<http://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus/article/download/755/1549>>. Acesso em: 7 jun. 2016.

TEIXEIRA, C. F. Formulação e implementação de políticas públicas saudáveis: desafios para o planejamento e gestão das ações de promoção da saúde nas cidades. **Saúde social**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1 p. 37-46, 2004a. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902004000100005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 4 jun. 2016.

TEIXEIRA, C. F.; PAIM, J. S.; VILASBÔAS, A. L. SUS, modelos assistenciais e vigilância da saúde. **IESUS**, Salvador, v. VII, n. 2, p. 8-28, 1998. Disponível em: <<http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/iesus/v7n2/v7n2a02.pdf>>. Acesso em: 29 jun. 2016.

TEIXEIRA, C. Os princípios do sistema único de saúde. **Texto de apoio elaborado para subsidiar o debate nas conferências municipal e estadual de saúde**. Salvador, 2011. Disponível em: <http://www.saude.ba.gov.br/pdf/os_principios_do_sus.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2016.

TEIXEIRA, C.F. **Planejamento municipal em saúde**. Salvador: ISC-UFBA, 2001. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6721/1/Teixeira,%20Carmen.%20Cap.%202%20Planejamento%20em%20saude.pdf>>. Acesso em: 4 jul. 2016.

TEIXEIRA, J. A. C. **Comunicação em saúde**: relação técnicos de saúde–utentes. Análise psicológica, p. 615-620, 2004b. Disponível em: <<http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/229/1/AP%20222%283%29%20615-620.pdf>>. Acesso em: 4 jun. 2016.

UGÁ, M.A.D.; SANTOS, I.S. Uma análise da progressividade do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 8, p. 1597-1609, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csp/v22n8/08.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2016.

VASCONCELOS, C.M.; PASCHE, D.F. O sistema único de saúde. **Saúde em debate**. Hucitec, Fiocruz, Juiz de Fora, v. 170, p. 531-562, 2006. Disponível em: <<http://www.ufjf.br/facfisio/files/2012/06/refe.-SUS-Vasconcelos-e-Pasche.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

VASCONCELOS, E. M. **Educação popular nos serviços de saúde**. 3. ed. São Paulo: Hucitec; 1997.

VENANCIO, S.I. et al. Sistema de vigilância alimentar e nutricional no Estado de São Paulo, Brasil: experiência da implementação e avaliação do estado nutricional de crianças. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Boa Vista, v. 7, n. 2, p. 213-220, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151938292007000200012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 7 jul. 2016.

VIANA, A. L. D.; DAL POZ, M. R. Reforma do sistema de saúde no brasil e o programa de saúde da família. **PHYSIS: Revista Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, p. 225-264, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/physis/v15s0/v15s0a11>>. Acesso em: 23 jun. 2016.

VILLARINHO, M. V. et al. Políticas públicas de saúde face à epidemia da AIDS e a assistência às pessoas com a doença. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 66, n. 2, p. 271-217, 2013. Disponível em: <<http://oaji.net/articles/2014/672-1400694427.pdf>>. Acesso em: 5 jul. 2016.

WHO (World Health Organization, 1946). **Constitution of the world health organization**. Basic Documents, WHO. Genebra. 45. ed., 2006. Disponível em: <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf>. Acesso em: 21 maio 2016.

WHO (World Health Organization, 1991). Declaração de Sundsvall. In: Ministério da Saúde/ FIOCRUZ. **Promoção da saúde**: Cartas de Ottawa, Adelaide, Sundsvall e santa fé de Bogotá. Ministério da Saúde/IEC, BRASÍLIA, p. 31-40. Disponível em: <http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/Dec_Sundsvall.htm>. Acesso em: 21 maio 2016.

WINSLOW, C.E.A. The unfilled fields of public health. **Science**, v. 51, p. 23-33, 1920. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1645011?seq=2#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 19 maio 2016.

ZILLMER, J. G. V.; SCHWARTZ, E.; MUNIZ, R.M.; LIMA, L. Avaliação da completude das informações do hiperdia em uma unidade básica do sul do Brasil. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 31, n. 2, p. 240-246, 2010. Disponível em: <<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/11967/10231>>. Acesso em: 8 jul. 2016.